



DCEM – Préparation aux ECN

Marjorie Sroussi

Mots clés

les points des grilles

ECN

**Nouveau programme ECN :
tous les mots clés incontournables
classés par modules**



EDITIONS

Retrouvez plus de livres médicaux à télécharger gratuitement exclusivement sur :
| www.facebook.com/LeTresorDesMedecins | www.facebook.com/groups/LeTresorDesMedecins |
| www.letresordesmedecins.wordpress.com | www.letresordesmedecins.blogspot.com |

Le trésor des Médecins





Marjorie Sroussi Sommaire

LA DECISION THERAPEUTIQUE	9
MODULE 1 : APPRENTISSAGE DE L'EXERCICE MEDICAL	9
ITEM N°1 Relation médecin-malade	9
ITEM N°2 Méthodologie de la recherche clinique	10
ITEM N°3 Raisonnement et décision en médecine Médecine fondée sur les preuves.....	10
ITEM N°4 Evaluation des examens complémentaires dans la démarche médicale : prescriptions utiles et inutiles	10
ITEM N°5 Indication et stratégie d'utilisation des principaux examens d'imagerie	10
ITEM N°6 Le dossier médical	11
ITEM N°7 Ethique et déontologie médicale : droits du malade, problèmes liés au diagnostic, au respect de la personne et à sa mort	11
ITEM N°8 Certificats médicaux	11
ITEM N°9 Hospitalisation sous contraintes Hospitalisation à la demande d'un tiers	12
ITEM N°10 Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire	12
ITEM N°11 Principes d'une démarche d'assurance qualité. Evaluation des pratiques professionnelles	12
ITEM N°12 Recherche documentaire et autoformation	12
ITEM N°13 Organisation des systèmes de soins : filières et réseaux	13
ITEM N°14 Protection sociale	13
MODULE 2 : DE LA CONCEPTION A LA NAISSANCE	13
ITEM N°15 Examen prénuptial	13
ITEM N°16 Grossesse normale	14
ITEM N°17 Principales complications de la grossesse Hémorragie génitale	14
ITEM N°18 Grossesse extra-utérine	15
ITEM N°19 Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum	15
ITEM N°20 Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques, ..	15
ITEM N°21 Prématurité et retard de croissance intra-utérin. Facteurs de risque et prévention	17
ITEM N°22 Accouchement, délivrance et suites de couche normales Accouchement.....	17
ITEM N°23 Evaluation et soins du nouveau né à terme	18
ITEM N°24 Allaitement et complications	18
ITEM N°25 Suites de couche pathologiques : pathologie maternelle dans les 40 jours.....	18
ITEM N°26 Anomalies du cycle menstruel ; métrorragies	19
ITEM N°27 Contraception	19
ITEM N°28 Interruption volontaire de grossesse	19
ITEM N°29 Stérilité du couple : conduite de la première consultation	19
ITEM N°30 Assistance médicale à la procréation. Principaux aspects biologiques, médicaux et éthiques.....	20
ITEM N°31 Problèmes posés par les maladies génétiques à propos : D'une maladie chromosomique : la trisomie 21	20
MODULE 3 : MATURATION ET VULNERABILITE	21
ITEM N°32 Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant :	21



ITEM №33 Suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un adolescent normal	21
ITEM №34 Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant	22
ITEM №35 Développement bucco-dentaire et anomalies	22
ITEM №36 Retard de croissance staturo-pondéral	23
ITEM №37 Maltraitance et enfant en danger	23
ITEM №38 Puberté normale et pathologique	23
ITEM №39 Troubles du comportement de l'adolescent	24
ITEM №40 Sexualité normale et ses troubles	24
ITEM №41 (regroupe les anciens items 41 et 266) Troubles anxieux	24
ITEM №42 Troubles du comportement alimentaire de l'enfant et de l'adulte Anorexie mentale	25
ITEM №43 Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte Enfant	25
ITEM №44 Risque suicidaire de l'enfant et de l'adulte : identification et prise en charge	25
ITEM №45 Addictions et conduites dopantes : épidémiologie, prévention, dépistage. Morbidité, comorbidité et complications. Prise en charge, traitements substitutifs et sevrage : alcool, tabac, psycho actifs et substances illicites. Alcool	26
ITEM №46 Sujets en situation de précarité : facteurs de risque et évaluation. Mesures de protection.	26
ITEM №47 Bases psychopathologiques de la psychologie médicale	26
ITEM №48 Différents types de techniques psycho-thérapeutiques	26
MODULE 4 : HANDICAP. INCAPACITE. DEPENDANCE.	26
ITEM №49 Evaluation clinique et fonctionnelle d'un handicap moteur, cognitif ou sensoriel	26
ITEM №50 Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge	26
ITEM №51 L'enfant handicapé : orientation et prise en charge	27
ITEM №52 Le handicap mental. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice Sauvegarde de justice	27
ITEM №53 Principales techniques de rééducation et de réadaptation	27
MODULE 5 : VIEILLISSEMENT	28
ITEM №54 Vieillesse normale : aspects biologiques fonctionnels et relationnels	28
ITEM №55 Ménopause et andropause Ménopause	28
ITEM №56 Ostéoporose	28
ITEM №57 Arthrose	29
ITEM №58 Cataracte	29
ITEM №59 La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et thérapeutiques	29
ITEM №60 Déficit sensoriel du sujet âgé Vision	29
ITEM №61 Troubles nutritionnels chez le sujet âgé	30
ITEM №62 Troubles de la marche et de l'équilibre. Chutes chez le sujet âgé	30
ITEM №63 Confusion, dépression et démences chez le sujet âgé Confusion	30
ITEM №64 Autonomie et dépendance chez le sujet âgé	31
MODULE 6 : DOULEUR- SOINS PALLIATIFS-ACCOMPAGNEMENT	31
ITEM №65 Bases neurophysiologiques et évaluation d'une douleur aiguë et chronique	31
ITEM №66 Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses (posologies à connaître)	31
ITEM №67 Anesthésie locale, locorégionale et générale Anesthésie locale	32

ITEM N°68 Douleur chez l'enfant : sédation et traitements antalgiques 32
 MODULE 6 : Douleur - Soins palliatifs - Accompagnement **Erreur ! Signet non défini.**

ITEM N°69 Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en fin de vie.	
Accompagnement d'un mourant et de son entourage	32
ITEM N°70 Deuil normal et pathologique.....	33
MODULE 7 : SANTE ET ENVIRONNEMENT. MALADIES TRANSMISSIBLES	33
ITEM N°71 Mesure de l'état de santé de la population.....	33
ITEM N°72 Interprétation d'une enquête épidémiologique.....	33
ITEM N°73 Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation.....	33
ITEM N°74 Risques sanitaires liés aux irradiations. Radioprotection	34
ITEM N°75 Epidémiologie et prévention des maladies transmissibles : méthodes de surveillance.....	34
ITEM N°76 Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications.....	34
ITEM N°77 Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte (posologies à	34
ITEM N°78 Coqueluche	35
ITEM N°79 Ectoparasitose cutanée : gale et pédiculose Gale sarcoptique	35
ITEM N°80 Endocardite infectieuse	35
ITEM N°81 Fièvre chez un malade immunodéprimé	35
ITEM N°82 Grippe	36
ITEM N°83 Hépatites virales Hépatites aiguës	36
ITEM N°84 Infections à herpès virus de l'enfant et de l'adulte immunocompétents	36
ITEM N°85 Infection à VIH.....	37
ITEM N°86 Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de	37
ITEM N°87 Infections cutanéomuqueuses bactériennes et mycosiques Impétigo	38
ITEM N°88 Infections génitales de la femme .Leucorrhées Salpingites.....	39
ITEM N°89 Infections génitales de l'homme. Ecoulement urétral Urétrite.....	39
ITEM N°90 Infections naso-sinusiennes de l'enfant et de l'adulte Sinusites maxillaires.....	39
ITEM N°91 Infections nosocomiales	40
ITEM N°92 Infections ostéoarticulaires.....	40
ITEM N°93 Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte.....	41
ITEM N°94 Maladies éruptives de l'enfant Scarlatine	41
ITEM N°95 Maladies sexuellement transmissibles Gonococcies.....	42
ITEM N°96 Méningites infectieuses et méningo-encéphalites chez l'enfant et chez l'adulte	42
ITEM N°97 Oreillons	42
ITEM N°98 Otalgies et otites chez l'enfant et l'adulte Otalgies	43
ITEM N°99 Paludisme.....	43
ITEM N°100 Parasitoses digestives Lamblase	43
ITEM N°101 Pathologie d'inoculation CAT devant une plaie	44
ITEM N°102 Pathologie infectieuse chez les migrants Importées :.....	45
ITEM N°103 Prévention du tétanos	45
ITEM N°104 Septicémie.....	45
ITEM N°105 Surveillance des porteurs de valve et de prothèse vasculaire.....	45
ITEM N°106 Tuberculose.....	46
ITEM N°107 Voyage en pays tropical : conseils avant le départ.....	46

ITEM N°108 Environnement professionnel et santé	46
ITEM N°109 Accidents du travail et maladies professionnelles Accidents du travail	47
ITEM N°110 Besoins nutritionnels et apports alimentaires de l'adulte	47
ITEM N°111 Sport et santé	48
MODULE 8 : IMMUNOPATHOLOGIE REACTION INFLAMMATOIRE	48
ITEM N°112 Réaction inflammatoire : Aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir.....	48
ITEM N°113 Allergies et hypersensibilités chez l'enfant et l'adulte : aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement.....	48
ITEM N°114 Allergies cutanéomuqueuses chez l'enfant et l'adulte. Urticaire,	49
ITEM N°115 Allergies respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte	49
ITEM 115 bis Déficit immunitaire	50
ITEM N°116 Pathologies auto-immunes : aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement	50
ITEM N°117 Lupus érythémateux disséminé.....	50
ITEM N°118 Maladie de Crohn et recto-colite hémorragique Maladie de Crohn .	51
ITEM N°119 Maladie de Horton et pseudo-polyarthrite rhizomélisque Maladie de Horton.....	51
ITEM N°120 Pneumopathie interstitielle diffuse.....	52
ITEM N°121 Polyarthrite rhumatoïde	52
ITEM N°122 Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)	52
ITEM N°123 Psoriasis.....	53
ITEM N°124 Sarcoïdose	53
ITEM N°125 Sclérose en plaques.....	53
ITEM N°126 Immunoglobuline monoclonale.....	54
ITEM N°127 Transplantation d'organes : aspects épidémiologiques et immunologiques	54
MODULE 9 : ATHEROSCLEROSE -HYPERTENSION - THROMBOSE	54
ITEM N°128 Atherome : épidémiologie et Physiopathologie.....	54
ITEM N°129 Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention	55
ITEM N°129 bis Prise en charge d'une dyslipidémie	55
ITEM N°130 Hypertension artérielle de l'adulte	55
ITEM N°131 Artériopathie oblitérante de l'aorte et des membres inférieurs	56
ITEM N°132 Angine de poitrine et infarctus myocardique Angor chronique stable	56
ITEM N°133 Accidents vasculaires cérébraux AVC ischémique.....	57
ITEM N°134 Néphropathie vasculaire.....	57
ITEM N°135 Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire.....	58
ITEM N°136 Insuffisance veineuse chronique - varices.....	58
ITEM N°137 Ulcère de jambe	58
MODULE 10 : CANCEROLOGIE - ONCO-HEMATOLOGIE	59
ITEM N°138 Cancer : épidémiologie, cancérogénèse, développement tumoral, .	59
ITEM N°139 Facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers Facteurs de risque.....	59
ITEM N°140 Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations paracliniques ; stadification, pronostic Signes d'appel.....	59
ITEM N°141 Traitement des cancers : Chirurgie	60
ITEM N°142 Prise en charge et accompagnement d'un malade cancéreux à tous	



les stades de la maladie	60
ITEM №143 Agranulocytose médicamenteuse : conduite à tenir	60
ITEM №144 Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques	61
ITEM №145 Tumeurs de la cavité buccale et des voies aéro-digestives supérieures	61
ITEM №146 Tumeurs intracrâniennes	62
ITEM №147 Tumeurs du col utérin	62
ITEM №148 Tumeurs du colon et du rectum	62
ITEM №149 Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques	62
ITEM №150 Tumeurs de l'estomac	63
ITEM №151 Tumeurs du foie, primitives et secondaires Carcinome hépatocellulaire	63
ITEM №152 Tumeurs de l'œsophage	63
ITEM №153 Tumeurs de l'ovaire Kystes	64
ITEM №154 Tumeurs des os primitives et secondaires Primitives	64
ITEM №155 Tumeurs du pancréas Adénocarcinome	64
ITEM №156 Tumeurs de la prostate	64
ITEM №157 Tumeurs du poumon, primitives et secondaires	65
ITEM №158 Tumeurs du rein	65
ITEM №159 Tumeurs du sein	65
ITEM №160 Tumeurs du testicule	66
ITEM №160 bis Tumeurs vésicales	66
ITEM №161 Dysmyélopoïèse	66
ITEM №162 Leucémies aiguës	67
ITEM №163 Leucémies lymphoïdes chroniques	67
ITEM №164 Lymphomes malins	67
ITEM №165 Maladie de Vaquez	67
ITEM №166 Myelome multiple des os	68
MODULE 11 : SYNTHÈSE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE. DE LA PLAINTÉ DU PATIENT À LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE. URGENCES	68
ITEM №167 Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Cadre réglementaire de la prescription thérapeutique et recommandations.	68
ITEM №168 Effet placebo et médicaments placebo	68
ITEM №169 L'évaluation thérapeutique et les niveaux de preuve	69
ITEM №170 La décision thérapeutique personnalisée. Observance médicamenteuse.	69
ITEM №171 Recherche d'un terrain à risque et adaptation thérapeutique.	69
ITEM №172 Automédication	69
ITEM №173 Prescription et surveillance des antibiotiques	69
ITEM №174 Prescription et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et .	70
ITEM №175 Prescription et surveillance d'un traitement anti-thrombotique Antiagrégants plaquettaires	70
ITEM №176 Prescription et surveillance des diurétiques	71
ITEM №177 Prescription et surveillance des psychotropes Antidépresseurs	71
ITEM №178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. Hémovigilance	71
ITEM №179 Prescription d'un régime diététique	71
ITEM №180 Prescription d'une cure thermique	72
ITEM №181 Iatrogénie. Diagnostic et prévention	72

ITEM №182 Accidents des anticoagulants Héparines.....	72
ITEM №183 Accueil d'un sujet victime de violences sexuelles.....	72
ITEM №184 Agitation et délires aigus	73
ITEM №185 Arrêt cardio-circulatoire	73
ITEM №186 Asthénie et fatigabilité	73
ITEM №187 Anomalie de la vision d'apparition brutale Œil rouge et douloureux : Cf. ITEM 212 Œil blanc et indolore	73
ITEM №188 Céphalées aiguës et chroniques	74
ITEM №189 Conduite suicidaire chez l'adolescent et l'adulte	74
ITEM №190 Convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.....	74
ITEM №191 Crise d'angoisse aiguë et attaque de panique.....	74
ITEM №192 Déficit neurologique récent.....	75
ITEM №193 Détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte Nourrisson	75
ITEM №194 Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte Cf. ITEM 302 pour l'adulte	75
ITEM №195 Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte	76
ITEM №196 Douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte.....	76
ITEM №197 Douleur thoracique aiguë et chronique.....	76
ITEM №198 Dyspnée aiguë et chronique.....	76
ITEM №199 Etat confusionnel et trouble de conscience	77
ITEM №200 Etat de choc	77
ITEM №201 Evaluation de la gravité et recherche des complications précoces Chez un brûlé	77
ITEM №202 Exposition accidentelle aux liquides biologiques. Conduite à tenir..	79
ITEM №203 Fièvre aiguë chez l'enfant et chez l'adulte	79
ITEM №205 Hémorragie digestive Haute :	79
ITEM №206 Hypoglycémie.....	80
- épreuve de jeune.....	80
ITEM №207 Infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines).....	80
ITEM N°208 Ischémie aiguë des membres	80
ITEM №209 Malaise, perte de connaissance	81
ITEM №210 Malaise grave du nourrisson et mort subite Malaise grave	81
ITEM №211 Œdème de Quincke et anaphylaxie.....	81
ITEM №212 Œil rouge et/ou douloureux Sans baisse de l'acuité visuelle	81
ITEM №213 Plaies, piqûres et morsures. Prévention de la rage	82
ITEM №214 Principales intoxications aiguës Psychotropes	82
ITEM №215 Rachialgie.....	83
ITEM №216 Rétention aiguë d'urine.....	83
ITEM №217 Syndrome occlusif	83
ITEM №218 Syndrome pré-éclamptique (ne figure plus dans le nouveau programme).....	84
ITEM №219 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro- électrolytiques.....	84
ITEM №220 Adénome hypophysaire	84
ITEM №221 Algodystrophie.....	85
ITEM №222 Anémie par carence martiale (ne figure plus dans le nouveau programme).....	85



ITEM N°223 Angiomes cutanés	85
ITEM N°224 Appendicite de l'enfant et de l'adulte	85
ITEM N°225 Arthropathie microcristalline Goutte	85
ITEM N°226 Asthme de l'enfant et de l'adulte	86
ITEM N°227 Bronchopneumopathie chronique obstructive	86
ITEM N°228 Cirrhose et complications Cirrhose	87
ITEM N°229 Colopathie fonctionnelle	87
ITEM N°230 Coma non traumatique	87
ITEM N°231 Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval	87
ITEM N°232 Dermatoses faciales Acné	88
ITEM N°234 Diverticulose colique et sigmoïdite	89
ITEM N°235 Epilepsie de l'enfant et de l'adulte Partielle	90
ITEM N°236 Fibrillation auriculaire	90
ITEM N°237 Fractures chez l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques	90
ITEM N°238 Fracture de l'extrémité inférieure du radius chez l'adulte	91
ITEM N°239 Fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte	91
ITEM N°240 Glaucome chronique	91
ITEM N°241 Goitre et nodule thyroïdien Nodule thyroïdien	91
ITEM N°242 Hémochromatose	92
ITEM N°243 Hémorragie génitale chez la femme	92
ITEM N°244 Hémorragie méningée	92
ITEM N°245 Hernie pariétale chez l'enfant et l'adulte Chez l'adulte	92
ITEM N°246 Hyperthyroïdie	93
ITEM N°247 Hypertrophie bénigne de la prostate	93
ITEM N°248 Hypothyroïdie	93
ITEM N°249 Insuffisance aortique	94
ITEM N°250 Insuffisance cardiaque de l'adulte	94
ITEM N°251 Insuffisance mitrale	94
ITEM N°252 Insuffisance rénale aiguë. Anurie	95
ITEM N°253 Insuffisance rénale chronique	95
ITEM N°254 Insuffisance respiratoire chronique	95
ITEM N°255 Insuffisance surrénale Périphérique :	95
ITEM N°256 Lésions dentaires et gingivales	96
ITEM N°257 Lésions péri-articulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l'épaule	96
ITEM N°258 Lithiase biliaire et complications	96
ITEM N°259 Lithiase urinaire	97
ITEM N°261 Maladie de Parkinson	97
ITEM N°262 Migraine et algies de la face Migraine	98
ITEM N°263 Myasthénie	98
ITEM N°264 Néphropathie glomérulaire	99
ITEM N°265 Neuropathie périphérique	99
ITEM N°267 Obésité de l'enfant et de l'adulte	99
ITEM N°268 Pancréatite aiguë	99
ITEM N°269 Pancréatite chronique	100
ITEM N°270 Pathologie des glandes salivaires Tumorale	100
ITEM N°271 Pathologie des paupières	101
ITEM N°272 Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme Torsion	

du cordon spermatique	101
ITEM №273 Pathologie hémorroïdaire Hémorroïdes externes	101
ITEM №274 Péricardite aiguë	102
ITEM №275 Péritonite aiguë	102
ITEM №276 Pneumothorax	102
ITEM №277 Polykystose rénale	102
ITEM №278 Psychose et délire chronique Schizophrénie	103
ITEM №279 Radiculalgie et syndrome canalaire Sciatique	103
ITEM №281 Rétrécissement aortique	104
ITEM №282 Spondylarthrite ankylosante	104
ITEM №283 Surveillance d'un malade sous plâtre	104
ITEM №284 Troubles de la conduction intra-cardiaque	105
ITEM №285 Troubles de l'humeur. Troubles bipolaires	105
ITEM №286 Troubles de la personnalité	105
ITEM №287 Trouble de la réfraction	106
ITEM №288 Troubles des phanères	106
ITEM №289 Troubles somatoformes	106
ITEM №291 Adénopathie superficielle	107
ITEM №292 Algies pelviennes chez la femme	107
ITEM №293 Altération de la fonction visuelle	107
ITEM №294 Altération de la fonction auditive	108
ITEM №295 Amaigrissement	108
ITEM №296 Aménorrhée secondaire	108
ITEM №297 Anémie	109
ITEM №298 Ascite	109
ITEM №299 Boiterie et troubles de la démarche chez l'enfant	109
ITEM №300 Constipation chez l'enfant et l'adulte (avec le traitement) Chez l'enfant	110
ITEM №301 Déficit moteur et /ou sensitif des membres	110
ITEM №302 Diarrhée aiguë chez l'enfant et chez l'adulte (avec le traitement) Chez l'adulte	110
ITEM №303 Diarrhée chronique Diarrhée motrice	111
ITEM №304 Diplopie	112
ITEM №305 Douleur buccale	112
ITEM №306 Douleur des membres et des extrémités	112
ITEM №307 Douleur et épanchement articulaire	112
ITEM №308 Dysphagie	113
ITEM №309 Electrocardiogramme : indications et interprétations	113
ITEM №310 Elévation de la créatininémie	113
ITEM №311 Eosinophilic	113
ITEM №312 Epanchement pleural	113
ITEM №313 Epistaxis (avec le traitement)	114
ITEM №314 Exanthème	114
ITEM №315 Hématurie	114
ITEM №316 Hémogramme : indications et interprétation	114
ITEM №317 Hémoptysie	115
ITEM №318 Hépatomégalie et masse abdominale	115
ITEM №319 Hypercalcémie (avec le traitement)	115
ITEM №320 Ictère	115
ITEM №321 Incontinence urinaire de l'adulte Chez la femme	116

ITEM N°322 Mouvements anormaux.....	116
ITEM N°323 Œdèmes des membres inférieurs.....	116
ITEM N°324 Opacités et masses intra-thoraciques	117
ITEM N°325 Palpitations.....	117
ITEM N°326 Paralysie faciale	117
ITEM N°327 Phénomène de Raynaud.....	117
ITEM N°328 Protéinurie et syndrome néphrotique chez l'enfant et chez l'adulte.....	118
ITEM N°329 Prurit (avec le traitement)	118
ITEM N°330 Purpuras chez l'enfant et chez l'adulte	118
ITEM N°331 Souffle cardiaque chez l'enfant	118
ITEM N°332 Splénomégalie.....	119
ITEM N°333 Strabisme de l'enfant.....	119
ITEM N°334 Syndrome mononucléosique	119
ITEM N°335 Thrombopénie	119
ITEM N°336 Toux chez l'enfant et chez l'adulte (avec le traitement)	120
ITEM N°337 Trouble aigu de la parole. Dysphonie	120
ITEM N°338 Trouble de l'érection	120
ITEM N°339 Troubles de l'hémostase et de la coagulation	120
ITEM N°340 Troubles de la marche et de l'équilibre.....	121
ITEM N°341 Troubles de la miction	121
ITEM N°342 Tuméfaction pelvienne chez la femme.....	121
ITEM N°343 Ulcération ou érosion des muqueuses orales et / ou génitales	121
ITEM N°344 Vertiges	122
ITEM N°345 Vomissements du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte (avec le traitement)	122

LA DECISION THERAPEUTIQUE.

URGENCES

MALADIES ET GRANDS SYNDROMES

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT

Collection

MODULE 1 : APPRENTISSAGE DE L'EXERCICE MEDICAL

ITEM N°1 Relation médecin-malade

- relation contractuelle
- confiance
- empathie
- consentement du malade Annonce d'une maladie grave
- cadre adapté : en consultation, au calme, disposer de temps
- annonce du diagnostic par le médecin référent
- information claire, compréhensible, adaptée
- délivrée progressivement, avec tact et empathie
- répondre aux questions

Retrouvez plus de livres médicaux à télécharger gratuitement exclusivement sur :

| www.facebook.com/LeTresorDesMedecins | www.facebook.com/groups/LeTresorDesMedecins |

| www.letresordesmedecins.wordpress.com | www.letresordesmedecins.blogspot.com |



- annonce du projet thérapeutique : message d'espoir Formation du patient atteint d'une maladie chronique
- prise en charge multidisciplinaire : médicale, psychologique, sociale
- prise en charge à 100% ALD 30
- éducation thérapeutique +++
- association de malades (ex : diabète)
- apprentissage des gestes d'urgence (ex : hypoglycémie et diabète) Personnalisation de la prise en charge médicale
- projet pédagogique : intégrer le patient à sa prise en charge pour améliorer l'observance
- :

ITEM N°2 Méthodologie de la recherche clinique

- les acteurs : promoteur, investigateur, sujets inclus, CPP (Comité de Protection des Personnes)
- consentement libre, éclairé, écrit, révocable à tout moment +++
- loi Huriet-Sérusclat 1988
- pertinence clinique
- critère de jugement principal
- la randomisation garantit la comparabilité
- analyse en intention de traiter :

ITEM N°3 Raisonnement et décision en médecine Médecine fondée sur les preuves

- autoformation
- sources d'information : banques de données de la littérature scientifique : Medline
- qualité d'une revue : comité de lecture et impact factor
- niveau de preuve :
- niveau 1 = grade A : preuve scientifique établie
- niveau 2 = grade B : présomption scientifique
- niveau 3 = grade C : faible niveau de preuve **Aléa thérapeutique**
- accident médical
- responsabilité sans faute médicale
- c'est au médecin d'apporter la preuve que l'information a été donnée +++
- réparation des préjudices par le CRCI (commission régionale de conciliation et d'indemnisation)
- :

ITEM N°4 Evaluation des examens complémentaires dans la démarche médicale : prescriptions utiles et inutiles

- test de référence : gold standard
- validité d'un test : sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative
- VPP augmente si prévalence augmente ; VPN diminue si prévalence augmente
- efficacité diagnostique : $\text{bien classés} / \text{total} = (VP + VN) / \text{total}$
- un test de dépistage privilégie une sensibilité élevée
- courbe ROC : définit le meilleur seuil; aire sous la courbe = efficacité globale du test
- :

ITEM N°5 Indication et stratégie d'utilisation des principaux examens d'imagerie

- radio standard : rayons X : parler d'opacité ou de clarté
- TDM : parler de densité
- IRM : non irradiante ; parler d'intensité ; attention aux contre-indications : pace maker, stimulateur neuro-électrique, implants ferromagnétiques...
- écho-doppler : ultra-sons, non invasif mais opérateur-dépendant
- scintigraphie : attention : parfois contre-indiquée chez la femme enceinte (marqueurs tératogènes)



- PETscan : traceur = FDG (fluoro désoxy glucose)
- chez l'enfant : priorité aux examens non irradiants : échographie +++ :

ITEM N°6 Le dossier médical

- durée de conservation : dans le privé : 30 ans, dans le public : 20 ans
- le patient peut avoir accès à son dossier médical : loi du 4 mars 2002 : délai de 48h à 8 jours si l'hospitalisation date de moins de 5 ans ; sinon, délai prolongé à 2 mois

L'information du malade

- claire, légitime, compréhensible, adaptée
- en cas de litige, c'est au médecin d'en apporter la preuve (recueil du consentement éclairé)

Le secret médical

- code pénal, code de la santé publique, code de déontologie
- non opposable au patient
- dérogations obligatoires : certificat de naissance, de décès, arrêt de travail, maladie professionnelle, maladies contagieuses, HDT, HO, alcoolique dangereux...)
- dérogations facultatives : sévices à mineurs, viol...

ITEM N°7 Ethique et déontologie médicale : droits du malade, problèmes liés au diagnostic, au respect de la personne et à sa mort

- code de déontologie : rédigé par l'ordre national des médecins
- droits du malade : information, consentement préalable, secret médical, respect
- principes éthiques : primum non nocere, autonomie du patient, équité
- déontologie : primauté de la personne, liberté du patient, obligation de compétences, obligation de moyens

ITEM N°8 Certificats médicaux

- responsabilité disciplinaire, pénale et civile
- identification du médecin, date et signature systématiques +++
- les dires du patient doivent être rapportés au conditionnel
- respect du secret médical sauf dérogations
- le certificat de blessure a une valeur juridique : pour les blessures volontaires, ITT > 8 j : délit et tribunal correctionnel ; ITT < 8 j : contravention et tribunal de police ; pour les blessures involontaires, le seuil ITT est de 3 mois
- terminer la rédaction d'un certificat par « certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit »

Décès et législation

- certificat de décès : 2 parties :
 - . partie supérieure nominative, remise à l'officier d'état civil qui délivre le permis d'inhumer
 - . partie inférieure anonyme qui énumère les causes du décès, adressée à la DDASS ; intérêt épidémiologique
- définition de la mort en réa = mort cérébrale : critères cliniques + 2 EEG plats ou 1 angiographie montrant l'absence de perfusion cérébrale
- inhumation obligatoire entre 24h et 6 j après le décès

Prélèvement d'organes et législation

- gratuité
- anonymat
- principe de présomption de consentement
- registre national des refus + témoignage de la famille avant tout prélèvement
- donneur vivant : recueil du consentement devant le président du tribunal de grande instance
- donneur mineur : avec accord parental et après avoir rencontré un comité d'experts





ITEM N°9 Hospitalisation sous contraintes Hospitalisation à la demande d'un tiers

- article L 3212-1 du code de la santé publique
- 3 pièces : demande d'admission du tiers, 2 certificats médicaux (dont un fait par un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil)
- durant l'hospitalisation : certificats de 24 h, quinzaine puis mensuels **Hospitalisation d'office**
- article L3213-1 du code de la santé publique
- 2 pièces : 1 certificat médical d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil et un arrêté préfectoral
- si danger imminent : un simple avis médical suffit ; le préfet doit statuer dans les 24h
- certificats durant l'hospitalisation : idem HDT
- :

ITEM N°10 Responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire

- obligation de moyens
- responsabilité civile :
 - . contractuelle et délictuelle ; la victime doit apporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les 2
 - . donne droit à des dommages et intérêts
- responsabilité disciplinaire :
 - . règles de déontologie
 - . conseil régional de l'ordre des médecins
 - . sanctions : avertissement ; blâme avec ou sans publication ; interdiction temporaire d'exercer ; interdiction définitive d'exercer ou radiation de l'ordre
- :

ITEM N°11 Principes d'une démarche d'assurance qualité. Evaluation des pratiques professionnelles

- évaluation des pratiques professionnelles :
 - . démarche volontaire et obligatoire pour tout médecin libéral
 - . évaluation par les pairs
 - . URML = union régionale de médecine libérale . 3 phases : information sur les référentiels, auto-évaluation, bilan et synthèse
 - . rapport d'évaluation et attestation valable 5 ans
- accréditation :
 - . initiative de l'établissement
 - . auto-évaluation par rapport aux référentiels
 - . visite d'accréditation
 - . rapport d'experts
 - . valable 5ans
 - . organisée par l'ANAES : agence nationale d'accréditation et d'évaluation des soins
- :

ITEM N°12 Recherche documentaire et autoformation

- banque de données : articles médicaux, thèses, Medline **Lecture critique d'un article médical**
- Plan :
 - résumé
 - introduction
 - matériel et méthodes
 - résultats
 - discussion, conclusion

- bibliographie

Recommandations pour la pratique clinique

- sujet vaste, questions nombreuses, littérature abondante, pas de controverse
- phase de préparation : groupe de travail puis groupe de lecture
- élaboration puis diffusion des recommandations **Conférences de consensus**
- sujet limité, littérature limitée, questions peu nombreuses, controverse
- phase de préparation : groupe d'experts, groupe bibliographique
- conférence publique
- délibération du jury
- rédaction et diffusion des recommandations **Maladies orphelines**
- prévalence inférieure à 1/2000
- orphanet
- associations de malades
- :

ITEM N°13 Organisation des systèmes de soins : filières et réseaux

- ONDAM : objectif national de dépense de l'assurance maladie
- carte sanitaire
- filière de soins actuelle : celle du médecin traitant
- Grande-Bretagne : NHS : national health service
- USA : Medicare (sujets âgés), Medicaid (défavorisés)
- secteur 1 : honoraires opposables
- secteur 2 : honoraires libres
- secteur 3 : non conventionnés :

ITEM N°14 Protection sociale

- solidarité nationale
- financement obligatoire : CSG + cotisations salariales + taxes -> URSSAF
- risques pris en charge : santé, vieillesse, famille
- prestations en nature ou en espèce
- régime général/ des exploitants agricoles/ des travailleurs indépendants
- ticket modérateur
- CMU : couverture médicale universelle **Consommation médicale et économie de santé**
- CMT (conso médicale totale) = CSBM + médecine préventive
- CSBM (conso de soins et biens médicaux) = soins hospitaliers + soins ambulatoires + transports sanitaires + médicaments + biens médicaux
- dépense courante de santé
- financement : sécurité sociale 75% + état 1% + mutuelles 7% + assurances privées 3% + ménages 10%
- :

MODULE 2 : DE LA CONCEPTION A LA NAISSANCE

ITEM N°15 Examen prénuptial

- obligatoire ; doit dater de moins de 2 mois
- 2 consultations
- éducation : hygiène, MST, grossesse, contraception
- examens complémentaires obligatoires que pour la femme : Groupe, rhésus, RAI, sérologies toxoplasmose et rubéole



- si sérologie rubéole négative : vaccination contre la rubéole
- information sur les y globulines anti-D si rhésus négatif
- certificat prénuptial remis en main propre à chacun des 2 époux : respect du secret médical :

ITEM N°16 Grossesse normale

- 7 consultations prénatales + 1 consultation post-natale obligatoires
- âge gestationnel : date des dernières règles + datation échographique entre 7 et 12 SA (longueur crânio-caudale)
- déclaration de grossesse avant 16 SA
- dépistage de la trisomie 21 entre 15 et 18 SA : c'est l'information qui est obligatoire et pas le dépistage
- examens biologiques obligatoires :
 - . 1 ère consultation : Groupe, rhésus, RAI, sérologies rubéole, toxoplasmose, syphilis et bandelette urinaire . à 6 mois : NFS, RAI, sérologie hépatite B : Ag HbS . à 7 mois : Groupe, rhésus, RAI . sérologie toxoplasmose tous les mois si négative
 - 3 échographies remboursées : à 12 SA -> datation, à 22 SA -> morphologique, à 32 SA -> de croissance
 - congé maternité : 6 semaines avant le terme + 10 semaines après. + 14 jours si grossesse pathologique (congé paternité = 11 j)

Besoins nutritionnels de la femme enceinte

- folates : supplémentation systématique : 0,4 mg/j ; 5 mg/j si grossesse à risque
- vitamine D : supplémentation systématique : 1 dose de 100000 UI à 28 SA
- dépistage d'une carence martiale
- pas de tabac, d'alcool, ni d'automédication +++
- prise de poids : 1^{er} trimestre : 500 g/mois ; 2^e trimestre : 1 kg/mois ; 3^e trimestre : 2 kg/mois. En tout : 9 à 12 kg :

ITEM N°17 Principales complications de la grossesse

Hémorragie génitale

- Groupe rhésus RAI (comme pour toute hémorragie)
- examen au spéculum : élimine une origine cervico-vaginale
- y globulines anti D si rhésus négatif +++
- 1^{er} trimestre : GEU +++ ou fausse couche précoce ; cinétique des pHCG quantitatifs
- 3^e trimestre : TV contre-indiqué avant l'échographie +++ (risque d'hémorragie cataclysmique si placenta praevia) ; enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) (retentissement fœtal)
- corticothérapie prénatale si grossesse ^ 34 SA

HTA gravidique, pré-éclampsie

- HTA gravidique = TA > 140/90 mmHg après 20 SA
- pré-éclampsie = HTA gravidique + protéinuric > 0,3 g/24h
- insuffisance utéro-placentaire
- complications : éclampsie, hématome rétro-péritonéal, Hellp syndrome, RCIU dysharmonieux, oligoamnios, CIVD
- décubitus latéral gauche
- attention !! Contre-indication aux diurétiques, IEC et au régime désodé pendant la grossesse
- dans le bilan, penser au bilan de l'HTA : ECG, fond d'œil
- prévention des rechutes : aspirine 100 mg/j à partir de 12 SA jusqu'à l'accouchement lors de la prochaine grossesse

Menace d'accouchement prématuré

- contractions utérines + modifications du col avant 37 SA
- échographie du col : longueur cervicale < 20 mm
- la première étiologie à éliminer est l'origine infectieuse
- recherche d'une rupture prématurée des membranes : test à la diamine oxydase



- corticothérapie prénatale avant 34 SA +++
- bilan préthérapeutique avant les (32 + : ECG, kaliémie, glycémie
- 2 contre-indications majeures à la tocolyse : la chorioamniotite et toute souffrance fœtale +++

Diabète gestationnel

- dépistage entre 24 et 28 SA
- 2 stratégies : test de O'Sullivan ou stratégie de l'OMS
- complications :
 - . fœtus : macrosomie, hydramnios, mort fœtale in utero, maladie des membranes hyalines, dystocie des épaules, hypoglycémie néonatale
 - . mère : HTA gravidique, diabète, récurrence lors d'une prochaine grossesse
- antidiabétiques oraux (ADO) contre-indiqués +++, traitement = régime ± insuline
- oestroprogestatifs contre-indiqués dans le post-partum

Diabète prééclampsie

- grossesse programmée
- équilibre glycémique péri-conceptionnel
- arrêt des ADO et relais par insuline avant le début de la grossesse
- risque de malformations congénitales

Fièvre

- listériose jusqu'à preuve du contraire +++
- chorioamniotite
- si pyélonéphrite : ECBU tous les mois jusqu'à l'accouchement
- risque de MAP
- vérifier le statut sérologique +++ (toxoplasme, rubéole)
- antipyrétiques systématiques (idem enfant)
- :

ITEM N°18 Grossesse extra-utérine

- (3HCG quantitatifs + échographie pelvienne
- groupe rhésus RAI
- laparoscopie + anapath : penser à prévenir du risque de salpingectomie et de conversion laparo +++
- vérification post-op de la décroissance des pHCG si traitement conservateur
- en l'absence de contre-indication : traitement médical = méthotrexate
- pronostic = récurrence, stérilité tubaire
- yglobulines anti D si rhésus négatif
- :

ITEM N°19 Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum

- blues du post-partum : bénin
- dépressions du post-partum : simples = phobies d'impulsion ; mélancoliques
- psychose puerpérale : délire oniroïde centré sur l'enfant
- attention à l'infanticide +++
- hospitalisation en unité mère-enfant
- éliminer une organicité +++, ex : thrombose veineuse cérébrale : TDM cérébral
- arrêt de l'allaitement si prescription de psychotropes
- bromocriptine (Parlodel®) contre-indiqué si ATCD psy
- :

ITEM N°20 Prévention des risques fœtaux : infection, médicaments, toxiques,

irradiation

Toxoplasmose

- sérologie mensuelle si négative
- règles hygiéno-diététiques
- toxoplasmose congénitale entre 4 et 10 SA



- spiramycine en urgence si seroconversion
- amniocentèse 4 semaines après la seroconversion : PCR + test d'inoculation à la souris
- bilan néonatal : écho transfontanellaire, sérologies au cordon, histologie du placenta

Rubéole

- rubéole congénitale avant 18 SA +++
- prévention = vaccination : contre-indiquée pendant la grossesse
- amniocentèse 5 semaines après seroconversion **Hépatite B**
- contamination périnatale
- Ag HbS systématique à 6 mois
- pas d'embryofoetopathie
- sérovaccination du nouveau-né
- allaitement autorisé **Hépatite C**
- pas de dépistage obligatoire
- rechercher une co-infection VIH
- ribavirine contre-indiquée
- allaitement autorisé

VIH

- sérologie obligatoirement proposée
- si pas d'indication à une trithérapie : AZT PO à 20 SA systématique
- AZT IV pendant l'accouchement
- césarienne prophylactique à 38 SA sauf si charge virale indétectable
- allaitement contre-indiqué **CMV**
- 1^{re} cause de déficit neurocongénital (surdité)
- pas de dépistage systématique **HSV**
- herpès néonatal
- traitement de la mère si primo-infection : Aciclovir 8 jours PO
- césarienne prophylactique si primo-infection dans le dernier mois ou récurrence la dernière semaine de grossesse

Syphilis

- dépistage obligatoire par la sérologie
- syphilis congénitale après 18 SA □ **sténose**
- contamination alimentaire-* règles hygiéno-diététiques
- à évoquer devant toute fièvre
- diagnostic = hémocultures
- traitement = amoxicilline 3 à 6 g/j pendant 4 semaines
- déclaration obligatoire +++ **Varicelle**
- varicelle congénitale avant 20 SA
- varicelle néonatale
- pneumopathie varicelleuse
- zona la première année de vie
- surveillance échographique tous les mois si varicelle maternelle **Strepto B**
- dépistage : prélèvement vaginal à 8 mois
- antibioprophylaxie perpartum : pénicilline G IV
- responsables d'infections néonatales **Parvovirus B19**
- anémie fœtale
- anasarque fœtoplacentaire
- exsanguino-transfusion **Tuberculose**
- pyrazinamide contre-indiqué et rifampicine contre-indiquée au 1^{er} trimestre
- traitement = trithérapie pendant 9 mois
- contre-indication de l'allaitement
- isolement du nouveau-né
- BCG précoce **Médicaments**
- tératogénité
- attention aux médicaments contre-indiqués : lithium, AVK, IEC, AINS, certains antibiotiques, anti diabétiques oraux...
- contre-indication aux vaccins vivants
- prévention : pour les inducteurs enzymatiques : supplémentation en vitamines K et D. Dépakine : supplémentation en acide folique

Tabac

- diminution de la fécondité



- risque plus élevé de GEU
- risques de : fausses couches, prématurité, RCIU, mort fœtale in utero, placenta praevia, hématome rétro-placentaire, mort subite du nourrisson

Alcool

- tératogène
 - neurotoxicité
 - syndrome d'alcoolisation fœtale
 - RCIU harmonieux
 - dysmorphie crânio-faciale
 - retard mental + troubles neuro-comportementaux
- Drogues**
- cocaïne tératogène
 - risques infectieux : VIH, VHB, VHC
 - fausses couches, RCIU, mort fœtale in utero
 - syndrome de sevrage néonatal -PMI

Irradiation

- radiosensibilité maximum entre 4 et 10 SA
- risque tératogène
- dose gonade ; si > 200 cGy -► IMG
- :

ITEM N°21 Prématurité et retard de croissance intra-utérin. Facteurs de risque et prévention

RCIU

- biométries < 10^e percentile ; sévère si < 3^e percentile
- harmonieux / dysharmonieux
- courbe de croissance
- doppler des artères utérines, ombilicales et cérébrales fœtales
- hauteur utérine insuffisante pour l'âge
- sérologies ± amniocentèse
- insuffisance placentaire

Prématurité

- naissance avant 37 SA
- maladie des membranes hyalines
- entérocolite ulcéronécrosante
- HTAP : hypertension artérielle pulmonaire
- hémorragie intra-ventriculaire
- séquelles : leucomalacie péri-ventriculaire, grêle court...
- caféine si naissance avant 32 SA
- mise en couveuse
- :

ITEM N°22 Accouchement, délivrance et suites de couche normales Accouchement

- modification du col + contractions utérines
 - présentation
 - engagement : passage du détroit supérieur : OIGA +++ (occipito-iliaque gauche antérieure) -> signes de Farabeuf et de Demelin
 - descente et rotation : excavation pelvienne : OP ++ (occipito-pubienne)
 - dégagement : passage du détroit inférieur
 - indice de Magnin = diamètre promonto-rétro-pubien + diamètre transverse médian ; normal > 230 mm
 - délivrance
 - électrocardiogramme
 - partogramme
- Suites de couches**
- globe utérin
 - y-globulines anti-D si rhésus négatif
 - diurèse
 - lochies



- montée laiteuse
- hypercoagulabilité ; attention à la phlébite +++
- visite de post-partum obligatoire
- contraception
- rééducation périnéale
- :

ITEM N°23 Evaluation et soins du nouveau né à terme

- score d'Apgar
- soins du cordon
- prise de la température rectale (élimine l'imperforation anale), test à la seringue (élimine l'atrésie de l'oesophage), aspiration nasopharyngée (élimine l'atrésie des choanes)
- mensurations : poids, taille, périmètre crânien
- collyre antibiotique
- palpation des pouls fémoraux
- vitamine K PO 2 mg
- valeurs normales : FC = 90 - 160 /min, FR = 30 - 60 /min, TA = 70 mmHg de systolique
- tout symptôme = infection materno-fœtale jusqu'à preuve du contraire
- détresse respiratoire : indice de Silverman
- émission de méconium avant 36 h, sinon : retard
- dépistage obligatoire : hypothyroïdisme, phénylcétonurie, hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose + drépanocytose si origine à risque
- supplémentation en vitamine D, fluor, vitamine K 2 mg/semaine si allaitement maternel exclusif
- :

ITEM N°24 Allaitement et complications

- colostrum
- montée laiteuse à J3
- 2 hormones hypophysaires : prolactine (lactogénèse) et ocytocine (vidange)
- lien mère-enfant
- protection contre les infections du nouveau né : immunoglobulines
- complications : crevasses, engorgement mammaire, lymphangite -> pas de contre-indication à l'allaitement ; galactophorite et abcès mammaire -> contre-indication à l'allaitement +++
- test de Budin
- si refus d'allaitement : Parïodel[®]/bromocriptine 2cp/jour pendant 3 semaines
- :

ITEM N°25 Suites de couche pathologiques : pathologie maternelle dans les 40 jours

- hémorragiques
- infectieuses : endométrite du post-partum
- thrombo-emboliques ; attention à la phlébite pelvienne associée à l'endométrite ; thrombose veineuse cérébrale
- rétention aiguë d'urine
- troubles psychiatriques
- aménorrhée du post-partum : première étiologie à évoquer : nouvelle grossesse ; autres = synéchie utérine, hyperprolactinémie, syndrome de Sheehan

Hémorragie de la délivrance

- urgence vitale ; groupe, rhésus, RAI
- perte sanguine > 500 ml
- 2 causes principales : atonie utérine et rétention placentaire
- révision utérine +++ et examen sous valves ± délivrance artificielle
- ocytociques IV
- massage utérin



- si échec : prostaglandines Nalador® IV
- si échec : radio-embolisation des artères utérines
- si échec : ligature des artères utérines voire hystérectomie d'hémostase
- prévention : délivrance dirigée (ocytociques) si facteurs de risques
- :

ITEM N°26 Anomalies du cycle menstruel ; métrorragies

- évoquer une GÉU en premier lieu +++
- fausse couche spontanée
- grossesse intra-utérine évolutive : décollement trophoblastique
- môle hydatiforme : surveillance de la décroissance des BHCG (risque de choriocarcinome)
- cancer du col
- cervicite
- syndrome prémenstruel : prise en charge médicale : progestatif du 15^e au 25^e jour du cycle
- :

ITEM N°27 Contraception

- pilule = œstre-progestatif : attention aux contre-indications ; risque thrombo-embolique ; bilan biologique à 3 mois : lipidique, glycémique ; ex : Minidril®
- autres œstro-progestatifs : patch (Evra®), anneau intra-vaginal
- microprogestatif : micro-dosée ; ex : Microval®
- progestatif de 3^e génération ; ex : Cérazette®
- dispositif intra-utérin/ stérilet ; durée = 5 ans
- implant SC (Implanon®) = progestatif
- préservatif = seule prévention contre les MST +++
- contraception d'urgence : progestatif de 3^e génération 2cp à 12 h d'intervalle moins de 72 h après le rapport sexuel (Norvelo®)
- contraception du post-partum : micro-progestatif ++
- si ATCD thrombo-embolique : œstro-progestatifs et progestatifs contre-indiqués
- si ATCD de GEU : éviter le stérilet et les micro-progestatifs
- ligature des trompes : irréversible ; consentement écrit ; délai de réflexion de 4 mois ; clause de conscience
- :

ITEM N°28 Interruption volontaire de grossesse

- limite = 14 SA
- dossier guide ; entretien social obligatoire si mineure
- consentement écrit
- délai de réflexion = 7 jours (n'est plus obligatoire)
- clause de conscience
- IVG médicamenteuse : avant 7 SA : RU486 + Cytotec®
- IVG instrumentale : aspiration endo-utérine + curetage sous AG
- penser à la contraception après l'IVG +++
- penser aux vglobulines si rhésus négatif +++
- :

ITEM N°29 Stérilité du couple : conduite de la première consultation

- délai de 12 mois à 2 ans avant les investigations
- principaux éléments à rechercher à l'interrogatoire :
 - . âge maternel
 - . ATCD de salpingite : obstruction tubaire bilatérale
 - . fréquence des rapports sexuels
- examens complémentaires :
- . courbe de température sur 3 mois



- . échographie pelvienne
- . bilan hormonal : FSH, LH, œstradiol, TSH, T4, prolactinémie
- . hystérosalpingographie
- . spermogramme
- . test post-coïtal
- . sérologies (pour le couple)
- .

ITEM N°30 Assistance médicale à la procréation. Principaux aspects biologiques, médicaux et éthiques

- s'adresse à des couples infertiles vivants, en âge de procréer, mariés ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans
- consentement écrit
- insémination intra-utérine : seulement si perméabilité tubaire
- fécondation in vitro et transfert d'embryons (FIVET) : pour les infertilités d'origine tubaire
- complications :
 - . syndrome d'hyperstimulation ovarienne (accidents thrombo-emboliques) . torsion d'annexé .
 - grossesse multiple . GEU :

ITEM N°31 Problèmes posés par les maladies génétiques à propos : D'une maladie chromosomique :

la trisomie 21

- rôle de l'âge maternel
- dépistage anténatal :
 - . marqueurs sériques entre 15 et 18 SA . clarté nucale (1^{re} échographie anténatale) . caryotype (amniocentèse)
- conseil génétique
- malformations cardiaques (communication auriculo-ventriculaire ++)
- LAM (leucémie aiguë myéloïde)
- récurrence = 1% pour la trisomie 21 libre
- maladie autosomique récessive
- mutation AF508, protéine CFTR
- test de la sueur
- biologie moléculaire avec consentement écrit +++
- conseil génétique
- hétérozygotes dans la population = 1/25
- iléus méconial
- retard staturo-pondéral et pubertaire
- insuffisance pancréatique exocrine
- atteinte pulmonaire

D'une maladie d'instabilité : le syndrome de l'X fragile

- transmission sur le mode dominant, lié à l'X ; pénétrance variable ; atteint surtout les garçons
- diagnostic : biologie moléculaire avec consentement écrit
- gène FMR1
- retard mental + syndrome dysmorphique + macro-orchidie à la puberté
- femmes vectrices

Remarque : techniques de diagnostic anténatal :

- amniocentèse entre 15 et 18 SA (risque = 1%)
- ponction de villosités chorionales entre 10 et 13 SA
- ponction de sang fœtal entre 20 et 38 SA
- .



MODULE 3 : MATURATION ET VULNERABILITE

ITEM N°32 Développement psychomoteur du nourrisson et de l'enfant :

aspects normaux et pathologiques

Sommeil

- cauchemar
- terreur nocturne
- hypersomnie : attention aux causes neurologiques
- vomissements psychogènes
- anorexie du nourrisson : entre 6 et 9 mois
- PICA : carences affectives graves ; attention au saturnisme
- mérycisme : perte pondérale systématique
- 18 mois : propreté diurne
- 2 - 3 ans : propreté nocturne
- énurésie et encoprésie : n'en parler qu'après l'âge de 4 ans
- constipation : attention à l'organicité
- règles hygiéno-diététiques
- calendrier
- méthode de conditionnement : « pipi-stop »
- réflexes archaïques disparaissent à 5 mois
- 9 mois : station assise sans appui, debout avec appui, préhension pousse-index, peur de l'étranger
- syndrome hyperkinétique : hyperactivité + impulsivité + distractibilité ; traitement = Ritaline + guidance parentale

Langage

- 10 mois : 1^{er} mot
- 3 ans : apparition du « je »
- troubles du langage écrit : dyslexie, dysorthographe
- devant tout trouble du langage : rechercher un trouble de l'audition +++
- bilan orthophonique
- nourrisson : test de Brunet-Lezine : donne un quotient de développement
- QI verbal, de performance, global
- retard mental : QI < 70
- bilan minimal pour un retard mental : . caryotype
- . sérologies TORCH . IRM cérébrale
- . bilan orthophonique, psychomoteur, psychologique, pédagogique, éducatif
- Troubles de l'apprentissage** - principales étiologies : . maladie somatique . phobie scolaire . trouble du langage . retard mental . QI élevé . déficit sensoriel
- . syndrome hyperkinétique avec trouble de l'attention . contexte familial pathologique . trouble anxieux
- :

ITEM N°33 Suivi d'un nourrisson, d'un enfant et d'un adolescent normal

- poids, taille, périmètre crânien
- courbe staturo-pondérale +++
- développement psychomoteur
- statut vaccinal
- carnet de santé +++
- régime alimentaire

Dépistage des anomalies orthopédiques

- pied bot varus équin = urgence différée
- genu varum : attention à la maladie de Blount et au rachitisme
- luxation congénitale de hanche : . manœuvre de Barlow : ressaut
- . limitation de l'abduction
- . échographie de hanche à 1 mois si facteurs de risque
- scoliose :
- . adolescence



- . âge osseux
- . gibbosité
- . angle de Cobb

Des troubles visuels

- leucocorie : attention au rétinoblastome
- rétinopathie du prématuré
- strabisme :
- . risque d'amblyopie
- . test des reflets cornéens
- . test de l'écran
- . tolérance à l'occlusion d'un oeil
- après 2 ans et demi : acuité visuelle

Et auditifs

- réflexe cochléo-palpébral
 - oto-émissions acoustiques provoquées
 - potentiel évoqué auditif si suspicion ou facteurs de risque de surdité
 - 4 mois : jouets de Moatti
 - 9 mois : jouets sonores : si test négatif : réflexe d'orientation-investigation
 - tout retard de langage doit faire suspecter un trouble auditif +++
 - otoscopie systématique : otite séreuse très fréquente +++
 - surdités secondaires : méningites, otites séromuqueuses
- Examens de santé obligatoires**
- 20 examens médicaux préventifs gratuits entre 0 et 6 ans
 - à J8, 9 mois et 24 mois : certificats délivrés au terme de la consultation ; permettent de recevoir les prestations sociales

Médecine scolaire

- examen obligatoire à 6 ans : mensurations, dépistage sensoriel, test de reproduction graphique
- médecine préventive

éducation à la santé Mortalité et morbidité infantile

- seuil de viabilité : 22 SA et poids > 500 g
- mortalité infantile (0 - 1an) = 4,5 /1000
- mortalité néonatale précoce : entre J0 et J8
- mortalité néonatale tardive : entre J9 et J27
- mortalité post-néonatale : entre J28 et 1 an
- mortalité périnatale : entre 28 SA et J8
- mortalité néonatale : entre J0 et J28
- taux de mortinatalité : nombre de fœtus viables décédés avant la naissance / nombre de fœtus viables
- :

ITEM N°34 Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant

- promouvoir l'allaitement maternel
- allaitement artificiel : 1 cuillère-mesure pour 30 mL d'eau
- J15 à 3 mois : quantité de lait = poids (en g) /10 + 250 mL
- lait HA si famille atopique
- hydrolysats si allergie aux protéines de lait de vache
- laits pré-épaissis si RGO
- supplémentation :
- . fluor : 0,25 mg/j de 0 à 2 ans
- . vitamine D : 800 UI/j si lait artificiel ; 1200 UI/j si allaitement maternel
- . vitamine K : 2 mg à la naissance systématiquement ; 2 mg/semaine si allaitement maternel
- diversification vers 5 mois + 500 mL de lait de suite
- pas d'aliment allergisant (kiwi, cacahuète) avant 3 ans
- ;

ITEM N°35 Développement bucco-dentaire et anomalies

- fente labio-palatine ; prévalence = 1/1000
- syndrome de Pierre Robin
- 1^{re} dentition :



- . incisives : à 6 mois . 1ères molaires : 12 à 18 mois . canines : 18 à 24 mois . 2^e molaires : 24 à 36 mois
- 2^e dentition :
- . incisives : à 6 ans
- . 1ères molaires : 6 ans
- . 2^e molaires : 12 ans
- . canines : 11 ans
- . 3èmes molaires 17- 25 ans
- prévention de la carie dentaire : . supplémentation en fluor
- . limiter la consommation de sucre . brossage soigneux des dents . détartrage régulier
- . dépistage chez le dentiste 1 fois par an
- :

ITEM N°36 Retard de croissance staturo-pondéral

- poids ou taille < 3ème percentile ou < -2 DS ou cassure de la courbe staturo-pondérale
- courbe de croissance +++
- retard statural isolé : syndrome de Turner, maladie coeliaque, retard simple
- déficit en GH
- âge osseux < âge statural < âge chronologique = hypothyroïdie
- âge osseux : indice de Risser sur radio du bassin
- bilan biologique : bilan hormonal, bilan de malabsorption, TSH-T4, fer sérique, test de la sueur, caryotype ± test de stimulation de l'hormone de croissance
- prise de poids normale : . 30 g/j le premier mois
- . 25 g/j le 2^e et 3^e mois . 20 g/j de 3 à 6 mois . 10 g/j de 6 à 12 mois
- un repère : 4 ans : 1 m ; 16kg ; PC = 50 cm :

ITEM N°37 Maltraitance et enfant en danger

- suspicion : lésions inhabituelles pour des traumatismes spontanés
- syndrome de Silverman (radiologique) +++
- troubles du comportement
- signes de carences
- bilan systématique :
- . radiographie du squelette + bilan d'hémostase + fond d'oeil + photographies
- accord parental non nécessaire pour les examens ou l'hospitalisation
- signalement judiciaire ou administratif +++
- certificat médical descriptif
- ordonnance de placement provisoire : demande faite au Procureur de la République

Protection maternelle et infantile

- éducation sanitaire familiale
- informations sur la contraception
- consultations prénatales et postnatales
- surveillance médicale des enfants jusqu'à 6 ans
- médecine de prévention (vaccins...) :

ITEM N°38 Puberté normale et pathologique

- stades de Tanner
- augmentation de la vitesse de croissance : 9 -10 cm/an
- bilan minimal de toute puberté pathologique :
- . courbe de croissance +++
- . échographie pelvienne (chez la fille)
- . bilan hormonal
- . âge osseux
- . TDM des surrénales
- . test au LHRH

Puberté précoce

- avant 8 ans chez la fille ; avant 9 ans chez le garçon



- centrale : taux élevé de LHRH -> IRM cérébrale
 - traitement : analogues de LHRH **Retard pubertaire**
 - après 13 ans chez la fille ; après 14 ans chez le garçon
 - périphérique : taux élevé de LHRH -> caryotype : syndrome de Turner ou de Klinefelter
 - central : taux bas de LHRH -> IRM cérébrale
 - retard simple : rechercher des ATCD familiaux
 - traitement substitutif : stéroïdes sexuels
- Wofes :

ITEM N°39 Troubles du comportement de l'adolescent

- hyperactivité avec déficit de l'attention
 - trouble oppositionnel avec provocation
 - répercussion socio-familiale
 - échec scolaire
 - évolution vers une personnalité antisociale
 - abus de substances
 - guidance parentale
 - soutien scolaire
- :

ITEM N°40 Sexualité normale et ses troubles

- paraphilie : exhibitionnisme, fétichisme, masochisme, sadisme, voyeurisme, pédophilie
 - problème médico-légal : injonction de soins
 - sanctions pénales
 - thérapies comportementales
 - traitement anti-androgènes (Androcur)
 - dysfonctions sexuelles : troubles de l'érection, dyspareunie
- :

ITEM N°41 (regroupe les anciens items 41 et 266) Troubles anxieux

- trouble panique :
- . répétition d'attaques de panique
- . anxiété anticipatoire
- . souvent associé à l'agoraphobie
- trouble anxiété généralisée : . anxiété chronique
- . hypervigilance . insomnie
- complications : tentatives de suicide, conduites addictives
- psychothérapie comportementale avec déconditionnement progressif
- antidépresseurs : 1RS ++ (Déroxaf) + anxiolytiques en début de traitement
- traitement de fond = psychothérapie analytique **Troubles phobiques (ancienne névrose phobique)**
- conduite d'évitement, de réassurance
- réaménagement
- anxiété anticipatoire
- objet contraphobique
- phobie sociale / simple/ agoraphobie
- traitement = psychothérapie cognitive et comportementale : désensibilisation
- Troubles obsessionnels compulsifs (ancienne névrose obsessionnelle)**
- personnalité obsessionnelle : méticuleux, ponctuel, perfectionniste, autoritaire
- obsessions : idéatives, phobiques, impulsives
- compulsions = rituels (lavage, vérification) -> caractère contraignant
- répercussion invalidante des symptômes
- lutte anxieuse contre les compulsions
- Troubles conversifs (ancienne névrose hystérique)**
- personnalité histrionique : érotisation des rapports sociaux
- conversion : somatique ou psychique



- pas d'organicité ; variabilité des symptômes
- « belle indifférence », théâtralisme, suggestibilité
- traitement : limiter les bénéfices secondaires +++, isoler de la famille **Etat de stress post-traumatique**
- différé par rapport à l'événement
- syndrome de répétition
- remaniement de la personnalité (régression) **Troubles de l'adaptation**
- à tout âge
- facteur de stress + prédisposition individuelle
- :

ITEM N°42 Troubles du comportement alimentaire de l'enfant et de l'adulte Anorexie mentale

- les 3 A : anorexie, amaigrissement, aménorrhée
- déni de la maigreur
- dysmorphophobie
- hyperactivité motrice et intellectuelle
- isolement social
- traitement hospitalier : contrat de poids, isolement, rééducation alimentaire

Boulimie

- la crise boulimique
- troubles du comportement : stratégies de maintien du poids, stratégies d'évitement, conduites impulsives
- éviter l'hospitalisation
- psychothérapie cognitive et comportementale
- ± antidépresseur anti-impulsif (ex : Prozac®) **Pour les 2**
- hypokaliémie -> ECG +++
- glycémie
- :

ITEM N°43 Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte

Enfant

- insomnies
- hypersomnie : attention aux tumeurs cérébrales
- apnées du sommeil et mort subite
- parasomnies : somnambulisme, terreur nocturne, cauchemars

Adulte

- insomnies +++
- attention aux abus d'anxiolytiques et d'hypnotiques +++
- calendrier du sommeil
- Polysomnographie
- complication = dépression
- syndrome d'apnée du sommeil
- benzodiazepines : prescription limitée à 4 semaines
- règles hygiéno-diététiques :

ITEM N°44 Risque suicidaire de l'enfant et de l'adulte : identification et prise en charge

- 1^{re} cause de décès avant 35 ans
- facteurs de risque :
 - . primaires : troubles psychiatriques, antécédents personnels ou familiaux de TS, impulsivité, communication d'une intention suicidaire . secondaires : isolement social, chômage, événement de vie . tertiaires : sexe masculin, âge, période de vulnérabilité
- conduite à tenir : hospitalisation 24 h minimum, avis psychiatrique systématique, suivi en ambulatoire
- :



ITEM N°45 Addictions et conduites dopantes : épidémiologie, prévention, dépistage. Morbidité, comorbidité et complications. Prise en charge, traitements substitutifs et sevrage : alcool, tabac, psycho actifs et substances illicites. Alcool

:

ITEM N°46 Sujets en situation de précarité : facteurs de risque et évaluation. Mesures de protection.

- 25% de la population française
- isolement familial
- alcoolisme, tabagisme
- risque suicidaire
- défaut d'accès aux soins
- protection : CMU (couverture médicale universelle), AME (aide médicale d'état)
- hébergement en appartement thérapeutique

:

ITEM N°47 Bases psychopathologiques de la psychologie médicale

- conséquences de la maladie : régression
- réactions dépressive, anxieuse, hostile face à la maladie
- réactions du malade : adaptation, suradaptation, déni, réaction persécutive, isolation

:

ITEM N°48 Différents types de techniques psycho-thérapeutiques

- psychothérapie de soutien : toujours
- psychothérapie analytique : pour les troubles conversifs, phobiques, obsessionnels et d'anxiété. Contre-indiquée dans les psychoses +++
- psychothérapie cognitivo-comportementale : technique de désensibilisation ++ : affrontement progressif des situations anxiogènes
- psychothérapie familiale : pour les enfants et les adolescents

:

MODULE 4 : HANDICAP. INCAPACITE. DEPENDANCE.

ITEM N°49 Evaluation clinique et fonctionnelle d'un handicap moteur, cognitif ou sensoriel

- modèle de Wood : lésion -> déficience incapacité handicap ou désavantage social
- CDAPH = commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (regroupe les anciens COTOREP et CDES) : orientation de la personne handicapée : insertion scolaire, professionnelle et sociale
- carte d'invalidité
- allocation adulte handicapé (AAH)
- attribution de l'allocation pour l'éducation spécialisée (AES)
- macaron GIC

:

ITEM N°50 Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge

- maladie thrombo-embolique +++ -> HBPM, bas de contention
- infections : pulmonaires, urinaires ...
- escarres mobilisation régulière, supports adaptés, pas de massage des points d'appui, formation du personnel soignant...
- hypotension orthostatique
- dénutrition -> régime hypercalorique hyperprotidique



- constipation
- rétractions tendineuses, ankylose
- déminéralisation osseuse
- dépression
- kinésithérapie +++
- toujours limiter la durée de l'alitement, notamment chez les personnes âgées
- :

ITEM N°51 L'enfant handicapé : orientation et prise en charge

- prise en charge multidisciplinaire
- privilégier le maintien à domicile et l'intégration en milieu scolaire ordinaire
- CDAPH
- AES : allocation d'éducation spéciale
- structures sanitaires : CAMSP (centre d'action médico-social précoce : pour les moins de 6 ans), CMPP (centre médico-psychopédagogique : pour les plus de 6 ans)
- structures médico-éducatives : IME (instituts médico-éducatifs), SESSAD (services d'éducation spéciale et de soins à domicile)
- :

ITEM N°52 Le handicap mental. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice Sauvegarde de justice

- mesure d'urgence, à effet immédiat
- mesure transitoire : 2 mois
- droits civils et civiques conservés
- modalités : 1 certificat médical + déclaration au Procureur de la République
- désignation d'un mandataire **Tutelle**
- mesure durable, complète
- incapacité civile presque totale
- modalités : certificat médical + instruction de la demande par le juge des tutelles + audition de l'intéressé
- tuteur désigné par le juge des tutelles **Curatelle**
- mesure intermédiaire
- :

ITEM N°53 Principales techniques de rééducation et de réadaptation

- kinésithérapie passive :
 - . levée de l'inhibition douloureuse
 - . lutte contre les rétractions musculo-tendineuses
 - . maintien des amplitudes articulaires
- kinésithérapie active :
 - . renforcement musculaire, lutte contre l'amyotrophie . rééducation proprioceptive . réadaptation à l'effort
- kinésithérapie spécifique : respiratoire, périnéale, sphinctérienne, biofeed-back
- physiothérapie : chaud/ froid/ ultrasons
- ergothérapie
- éducation : économie articulaire, règles d'hygiène de vie... **Savoir prescrire la masso-kinésithérapie et l'orthophonie Kinésithérapie**
- prescription médicale
- préciser si caractère urgent
- zone à traiter et indication
- domicile/ autre lieu
- nombre et fréquence des séances
- contre-indication à certaines techniques
- si accident de travail, préciser la prise en charge à 100% **Orthophonie**
- communication orale et écrite
- demande d'entente préalable à la CPAM
- bilan orthophonique



MODULE 5 : VIEILLISSEMENT

ITEM N°54 Vieillesse normale : aspects biologiques fonctionnels et relationnels

- facteurs génétiques et environnementaux
- diminution des réserves fonctionnelles
- diminution de la masse maigre, augmentation de la masse grasse, diminution de la masse osseuse
- diminution de la filtration glomérulaire
- diminution de la mémoire et des capacités attentionnelles
- presbytie, cataracte, presbycusie
- **Données épidémiologiques et sociologiques**
- vieillissement de la population : + de 60 ans = 21% de la population ; + de 75 ans = 8% de la population
- espérance de vie : hommes = 74 ans ; femmes = 82 ans
- augmentation de l'espérance de vie sans incapacité
- **Prévention du vieillissement pathologique**
- contrôle des facteurs de risque cardio-vasculaires
- respect du poids idéal : alimentation équilibrée
- prévention des infections : vaccinations (grippe)
- prévention psychique : maintien des relations sociales
- activité physique +++
- suivi médical, dépistage :

ITEM N°55 Ménopause et andropause

Ménopause

- diagnostic clinique : aménorrhée secondaire depuis plus de 1 an
- carence œstrogénique définitive
- ménopause précoce = avant 45 ans
- syndrome climatérique
- facteur de risque d'ostéoporose
- mammographie
- THS (traitement hormonal substitutif) : proposé ; seule indication = syndrome climatérique ; bilan pré-thérapeutique ; attention aux contre-indications ; œstrogène + progestatif ; réévaluation régulière ; 5 ans maximum

Andropause

- 20% des hommes
- testostérone < 2 ng/mL
- traitement = supplémentation en androgènes : attention au risque de cancer de la prostate -> surveillance du PSA

ITEM N°56 Ostéoporose

- primitive : post-ménopausique/ sénile
- secondaire : corticoïdes, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, Cushing...
- facteurs de risque : femme, âge, tabac, alcool, régime pauvre en calcium, sédentarité, faible BMI
- tassement vertébral bénin : respect du mur postérieur, pas de géode, pas de lyse corticale, atteinte des vertèbres lombaires ou dorsales basses
- ostéodensitométrie : T-score < -2,5 DS (= définition)
- bilan : NFS, bilan phosphocalcique, VS, électrophorèse des protéines sériques, créatinine, vitamine D (normal)
- 1 diagnostic différentiel : myélome dans sa forme décalcifiante diffuse
- traitement : but = stabilisation de la masse osseuse (et pas augmentation)
- règles hygiéno-diététiques

- . supplémentation en calcium et vitamine D
- . bisphosphonates
- . ou SERMS (Raloxifene®) attention, contre-indiqué si antécédent de thrombose
- prévention des chutes
- suivi : CTX sériques, taille, ostéodensitométrie 2 ans après l'instauration du traitement
- :

ITEM N°57 Arthrose

- horaire mécanique
- signes radiologiques :
 - . pincement articulaire localisé . ostéocondensation sous-chondrale . géodes d'hyperpression . osteophytes
- indices fonctionnels pour évaluer le retentissement ; ex : indice de Lequesne
- règles hygiéno-diététiques
- kinésithérapie, économie articulaire
- infiltrations cortisoniques
- suivi : périmètre de marche, EVA :

ITEM N°58 Cataracte

- 1^{re} cause de cécité dans le monde
- baisse de l'acuité visuelle de loin, photophobie, myopie d'indice
- sous-capsulaire postérieure/ corticale/ nucléaire
- la plus fréquente : senile = cortico-nucléaire
- secondaires : traumatique, diabétique, post-corticothérapie, héréditaire, myopie forte
- bilan pré-opératoire : kératométrie + biométrie ou échographie en mode A
- traitement chirurgical si acuité visuelle $\leq 4/10$ ou gêne fonctionnelle : -> extraction extra-capsulaire du cristallin par phacoémulsification et mise en place d'un implant de chambre postérieure sous anesthésie locale
- complications de la chirurgie : rupture capsulaire postérieure, œdème de cornée, œdème maculaire, endophtalmie, décollement de rétine, cataracte secondaire : opacification capsulaire postérieure
- :

ITEM N°59 La personne âgée malade : particularités sémiologiques, psychologiques et thérapeutiques

- anamnèse difficile
- symptômes atypiques : absence de douleur, absence de fièvre, absence de contracture abdominale, révélation par un syndrome confusionnel
- polypathologie : moyenne = 5 maladies
- polymédication ; attention à la iatrogénie
- adapter les posologies à la fonction rénale
- prise en charge multidisciplinaire : psychologique, nutritionnelle, aides sociales
- prévenir la perte d'autonomie
- :

ITEM N°60 Déficit sensoriel du sujet âgé

Vision

- DM LA
- forme précoce : drusens, atrophique, exsudative
- métamorphopsies, scotome central
- angiographie à la fluorescéine et au vert d'indocyanine
- vitaminothérapie
- forme exsudative : photocoagulation laser ou photothérapie dynamique si néo-vaisseaux rétrofovéolaires
- rééducation visuelle « basse vision »



Audition

- presbyacousie
- surdité de perception bilatérale prédominant dans les aigus
- audiométrie vocale supérieure à l'audiométrie tonale
- audioprothèse bilatérale précoce
- orthophonie
- conseils à l'entourage

Conséquences

- chutes
- isolement
- dépression :

ITEM N°61 Troubles nutritionnels chez le sujet âgé

- contre-indications aux régimes stricts +++
- anthropométrie : poids, IMC, circonférence brachiale, pli cutané tricipital
- diminution de la sensation de soif
- iatrogénie
- malnutrition exogène = carence d'apport ; malnutrition endogène hypercatabolisme
- conséquences : infections, retard de cicatrisation, chutes
- valeurs normales : albumine > 40 g/L pré-albumine > 200 mg/L
- évaluer les ingestas
- MNA = mini nutritionnal assessment +++
- prise en charge :
 - . réhydratation : orale / hypodermoclyse . toujours privilégier la voie orale
 - . fractionner les repas
 - . NRJ > 1500 Kcal/j ; protides > 1,1 à 1,2 g/kg/j
 - . compléments nutritionnels, suppléments vitaminiques
 - . hygiène bucco-dentaire
 - .

ITEM N°62 Troubles de la marche et de l'équilibre. Chutes chez le sujet âgé

- rechercher systématiquement la notion de malaise et de perte de connaissance devant toute chute
- étiologies à rechercher :
 - . iatrogénie, psychotropes +++ . hypotension orthostatique
 - . liées à l'environnement -> évaluation par un ergothérapeute . troubles neurologiques : démences, syndrome parkinsonien
- évaluation de la marche : . get up and go test
- . test de Tinetti . station unipodale
- conséquences de la chute : . rhabdomyolyse
- . syndrome post-chute . syndrome dépressif
- 3 éléments importants du bilan : glycémie, CPK, ECG +++
- kinésithérapie : rééducation de la marche
- .

ITEM N°63 Confusion, dépression et démences chez le sujet âgé Confusion

- début brutal
- fluctuation des symptômes
- altération de la conscience
- perplexité anxieuse
- étiologies à rechercher systématiquement : fécalome, rétention aiguë d'urine -> toucher rectal systématique +++, iatrogénie, intoxication au monoxyde de carbone
- TDM cérébral sans injection systématique
- dans le bilan biologique, penser à : glycémie, calcémie, TSH
- éviter les contentions et les neuroleptiques **Démences**
- troubles de la mémoire + syndrome aphaso-apraxy-agnosique + désorientation temporo-spatiale
- retentissement sur la vie quotidienne



- anosognosie -> interrogatoire de l'entourage
- MMS = mini mental status, IADL = échelle instrumentale des activités de la vie quotidienne
- prise en charge multidisciplinaire
- stimulation cognitive
- protection juridique
- syndrome dépressif : diagnostic différentiel ou secondaire à la démence

Maladie d'Alzheimer :

- diagnostic de certitude = histologique : plaques séniles, dégénérescence neuro-fibrillaire, angiopathie amyloïde
- atrophie hippocampique et temporo-pariétale
- troubles mnésiques : mémoire antérograde
- manque du mot, test de l'horloge, test des 5 mots de Dubois
- troubles comportementaux
- inhibiteurs de l'acétylcholinestérase (Aricept®) **Dépression**
- plainte somatique chez le sujet âgé
- causes : deuil, isolement, solitude
- risque suicidaire
- GDS = gériatrie dépression scale
- pas d'antidépresseur tricyclique (effets secondaires) +++, préférer les 1RS
- :

ITEM N°64 Autonomie et dépendance chez le sujet âgé

- échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne : IADL
- grille AGGIR +++ : permet d'évaluer l'attribution de l'APA (aide personnalisée pour l'autonomie) et la tarification des institutions
- privilégier le maintien à domicile
- aides à domicile
- prise en charge multidisciplinaire
- aménagement de l'environnement : ergothérapie
- institutions : EHPAD
- information et soutien de la famille
- :

MODULE 6 : DOULEUR- SOINS PALLIATIFS- ACCOMPAGNEMENT

ITEM N°65 Bases neurophysiologiques et évaluation d'une douleur aiguë et chronique

- sensibilité thermo-algique : faisceau spino-thalamique
- mécanismes : excès de nociception, neurogène, psychogène
- intensité : EVA (échelle visuelle analogique) = auto-évaluation
- efficacité des antalgiques et des différents traitements entrepris
- retentissement : insomnie, dépression
- centres antidouleur :

ITEM N°66 Thérapeutiques antalgiques médicamenteuses et non médicamenteuses (posologies à connaître)

Paliers de l'OMS :

- niveau 1 : antalgiques périphériques non **Opioides** : . Paracetamol 60 mg/kg/j
- . aspirine . AINS
- . Néfopam = Acupan®
- niveau 2 : **Opioides** faibles : . codéine
- . dextropropoxyphène : Diantalvic® 2 gélules « 3 /j . Tramadol (Topalgie®, Contramal®)
- niveau 3 : **Opioides** forts :



. agonistes purs : morphine, oxycodone, fentanyl (Durogesic®) . agonistes antagonistes : buprenorphine (Temgesic®), nalbuphine (Nubain®)
 -> ordonnance sécurisée, écriture en toutes lettres durée de prescription = 7 ou 28 j maximum +++
 -> prévention systématique de la constipation +++ (Duphalac®) ± antiémétique
 . posologies : titration +++ ; per os : 1 mg/kg/j LP + interdose = 1/6 de la dose de fond = 10 mg . IV = 3x per os ; SC = 2 « per os
 - ne jamais associer 2 antalgiques de même palier
 - toujours penser aux co-analgésiques : AINS, corticoïdes, antispasmodiques, antidépresseurs tricycliques, antiépileptiques (pour les douleurs neurogènes), myorelaxants, soutien psychologique :

ITEM N°67 Anesthésie locale, locorégionale et générale

Anesthésie locale

- Lidocaïne
- adjuvants : adrénaline : attention ! Jamais sur les extrémités (risque de nécrose)
- test d'aspiration
- garder le contact verbal
- risque de toxicité neurologique et cardiologique (troubles de la conduction)
- contre-indiquée si infection locale (ex : panaris) **Anesthésie locorégionale**
- IV :
 - . membre isolé de la circulation générale par un garrot artériel . pas d'adrénaline
 - . pour les chirurgies courtes, de moins d'1 heure
- anesthésies rachidiennes :
 - . péridurale (espace peridural)/ rachianesthésie (dans le LCR) . pour les chirurgies sous-ombilicales de moins de 3 heures (gynéco, uro...)
 - . complications : hypotension, rétention aiguë d'urines, céphalées post-PL, hématome
- blocs périphériques : plexiques/ tronculaires **Anesthésie générale**
- mesures obligatoires :
 - . consultation avec l'anesthésiste : information sur les risques, recueil du consentement éclairé . bilan clinique et paraclinique . visite pré-anesthésique (quelques heures avant)
 - produits utilisés : hypnotique + morphinique + curare ± antibioprophylaxie
 - surveillance : score de somnolence, score respiratoire
 - attention à la balance bénéfices/risques +++ :

ITEM N°68 Douleur chez l'enfant : sédation et traitements antalgiques

- moins de 4 ans : hétéroévaluation : échelle OPS (objective pain scale)
- 4 à 6 ans : EVA + autre auto-évaluation (échelle des 6 visages) ; si échec : hétéroévaluation
- plus de 6 ans : auto-évaluation : EVA
- moyens non médicamenteux : rassurer, présence des parents, distraire, relaxer...
- moyens médicamenteux :
 - . paracétamol 60 mg/kg/j
 - . ibuprofène 30 mg/kg/j, contre-indiqué avant l'âge de 6 mois . codéine 1 mg/kg/6h, contre-indiquée avant l'âge de 1 an . dextropropoxyphène contre-indiqué avant l'âge de 15 ans . nalbuphine (Nubain®) 0,2 mg/kg/6h contre-indiqué avant l'âge de 18 mois
 - . morphine
- EMLA +++ -MEOPA :

ITEM N°69 Soins palliatifs pluridisciplinaires chez un malade en fin de vie. Accompagnement d'un mourant et de son entourage

- approche globale, multidisciplinaire
- prise en charge de la douleur
- confort, qualité de fin de vie
- respect de la dignité et des croyances
- accompagnement psychologique : patient et famille
- pas de geste invasif ni d'examen abusif ; pas d'acharnement thérapeutique



- nursing : kinésithérapie, prévention des escarres, soins de bouche...
- hydratation, alimentation
- anxiolytiques : Hypnovel®
- traitement de l'encombrement bronchique = Scopolamine
- :

ITEM N°70 Deuil normal et pathologique

- deuil normal : 3 phases : choc -> dépression réactionnelle -> soulagement
- deuil pathologique = fixation à l'une des étapes du deuil normal . risque suicidaire
- . manifestations somatiques . déni
- . culpabilité . dépression
- prévention = verbalisation et expression des émotions

MODULE 7 : SANTE ET ENVIRONNEMENT. MALADIES TRANSMISSIBLES

ITEM N°71 Mesure de l'état de santé de la population

- taux de natalité = naissances/population
- taux de fécondité = naissances vivantes/femmes en âge de procréer
- taux de mortalité = décès/population
- taux de létalité = décès dus à la maladie/cas de la maladie
- taux d'attaque = nouveaux cas sur une période/sujets à risque pendant cette période
- prévalence = durée de la maladie x incidence
- mortalité infantile = très bon marqueur de la qualité du système de soins
- espérance de vie : à la naissance/à un âge donné/ sans incapacité
- :

ITEM N°72 Interprétation d'une enquête épidémiologique

- épidémiologie observationnelle :
 - . descriptive/ analytique; prospective /rétrospective . études de cohorte / transversales/ cas-témoin
- biais de sélection/ de classement/ de confusion
- risque relatif ou odds ratio (pour les études cas-témoins)
- l'intervalle de confiance ne doit pas contenir 1 pour pouvoir conclure +++

ITEM N°73 Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation

- risque infectieux : microbiologique
- risque toxique : chimique ou physique
- risque allergique **Toxi-infections alimentaires**
- définition : au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général digestive, pouvant être rapportés à une même origine alimentaire . .
- déclaration obligatoire à la DDASS +++
- 2 mécanismes : entéroinvasif-> syndrome dysentérique et entérotoxigène -> syndrome cholériforme
- par ordre de fréquence : salmonelles, staphylocoque doré, Clostridium perfringens
- durée d'incubation
- prélèvements microbiologiques : coprocultures + recherche de toxines
- enquête épidémiologique : étude cas-témoin, courbe épidémique, calcul du taux d'attaque (reflète la contagiosité)
- enquête sanitaire : étude de la chaîne alimentaire -



ITEM N°74 Risques sanitaires liés aux irradiations. Radioprotection

- équivalent de dose : Sievert
- radiosensibilité des tissus : dose seuil pour chaque tissu
- effets carcinogènes
- éviter les examens inutiles, diminuer le nombre de clichés, protection des gonades
- attention particulièrement chez l'enfant
- pour les professionnels : doses maximales admissibles : catégorie A : 20 mSv/an ; catégorie B : 6 mSv/an
- OPRI : office de protection contre les rayonnements ionisants
- :

ITEM N°75 Épidémiologie et prévention des maladies transmissibles : méthodes de surveillance

- épidémie, endémie, pandémie
- déclaration obligatoire à la DDASS +++ : information transmise à l'Institut de veille sanitaire
- centres nationaux de référence
- réseaux sentinelles de laboratoires et de médecins
- enquêtes épidémiologiques ponctuelles
- mesures de prévention : éviction, isolement, hygiène, antibioprophylaxie, éducation, vaccinations
- :

ITEM N°76 Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications

- vaccins obligatoires : BCG (plus obligatoire depuis juillet 2007) et DTP
- vaccins vivants : BCG, ROR, fièvre jaune, varicelle : contre-indiqués si immunodépression ou grossesse
- vaccin contre le pneumocoque : heptavalent chez le moins de 2 ans, pneumo23 chez le plus de 2 ans
- 3 dates pour le vaccin heptavalent (DTP, coqueluche, haemophilus, hépatite B, pneumocoque) : 2, 4 et 16 mois
- chez le voyageur : fièvre jaune, typhoïde, hépatite A, rage, méningocoque A et C
- mécanisme = immunoprophylaxie active A/ores :

ITEM N°77 Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte (posologies à connaître)

Angines

- TDR (test de diagnostic rapide) pour toute angine érythémateuse chez l'enfant de plus de 3 ans
- prélèvement de gorge si facteurs de risque de rhumatisme articulaire aigu ou si échec du traitement
- avec fausses membranes -> MNI test ; attention à la diphtérie
- angine ulcéreuse : attention à agranulocytose et aux hémopathies -> NFS
- complications :
 - . locales : adénite, phlegmon, abcès -> amygdalectomie à distance . générales (strepto A) : RAA, glomérulonéphrite aiguë, érythème noueux, scarlatine ...
- si TDR positif (angine à streptocoques) -> antibiothérapie : amoxicilline 50 mg/kg/j pendant 6 jours
- si allergie : macrolides

Contre-indication aux AINS Rhinopharyngites

- pas d'examen complémentaire
- otoscopie
- facteurs de risque : absence d'allaitement maternel, tabagisme passif, garde en collectivité
- complications : otite moyenne aiguë, sinusite, dyspnée chez le nouveau-né
- traitement symptomatique : désinfection rhino-pharyngée pluriquotidienne
- adénoïdectomie si otites à répétition
- :

ITEM N°78 Coqueluche

- contagé
- toux quinteuse
- apyrexie
- Bordetella Pertussis : isolement sur culture ou PCR + sérologie
- hyperlymphocytose
- risque léthal avant 6 mois : apnées, malaise, quintes asphyxiantes ou syncopales (donc hospitalisation systématique)
- complications : coqueluche maligne, surinfections, complications mécaniques, nutritionnelles, neurologiques (convulsions)
- en hospitalisation : isolement, scope, matériel d'intubation à proximité
- en ambulatoire : éviction scolaire pendant 5 jours
- antibiothérapie = traitement symptomatique (et pas curatif) : macrolides 50 mg/kg/j pendant 14 jours
- antibioprophylaxie de l'entourage : macrolides pendant 5 jours
- attention : pas de kinésithérapie +++ (favorise les quintes)
- prévention : vaccin acellulaire à M2, M3, M4 ; rappel à M16 puis à 12 ans
- :

ITEM N°79 Ectoparasitose cutanée : gale et pédiculose Gale sarcoptique

- prurit collectif
- topographie évocatrice
- lésions spécifiques : sillons, vésicules perlées, nodules scabieux
- gale norvégienne chez l'immunodéprimé
- impétiginisation
- traitement scabicide : local = Ascabiof; général = ivermectine **Pediculoses humaines**
- prurit du cuir chevelu
- poux + lentes
- pas d'éviction scolaire sauf si surinfection
- traitement pédiculicide et lenticide : Pyrethrine de synthèse en lotion ou Malathion
- décontamination des vêtements et de la literie
- :

ITEM N°80 Endocardite infectieuse

- subaiguë d'Osier/ aiguë ; valve native/ prothèse
- porte d'entrée : ORL, digestive, urologique, cutanée, iatrogène...
- souffle cardiaque
- hémocultures : prévenir le laboratoire de la suspicion d'endocardite (les cultures doivent être gardées plus longtemps)
- échographie-doppler cardiaque : végétations, lésions valvulaires
- ECG : recherche un BAV-> abcès du septum -> chirurgie
- complications emboliques (surtout avec le staphylocoque doré) : toujours palper les pouls périphériques et faire un examen neurologique
- complication rénale = GNRP (glomérulonéphrite rapidement progressive)
- anévrysmes mycotiques -> contre-indication aux anticoagulants dans l'endocardite +++
- bi-antibiothérapie IV pendant 4 à 6 semaines
- au décours : éducation sur l'antibioprophylaxie
- :

ITEM N°81 Fièvre chez un malade immunodéprimé

- hospitalisation en urgence + isolement
- prélèvements bactériologiques systématiques
- si dépression de l'immunité humorale (ex : splénectomie) : germes encapsulés ++ (pneumocoque ++)-> C3G en urgence
- si dépression de l'immunité cellulaire (ex : lymphome) : HSV ++
- neutropénie fébrile : traitement = S-lactamine à large spectre + aminoside (imipénème ou Fortum®+ amikacine IV)



- si KT central ou si échec à 48 h de traitement : rajouter de la vancomycine
- facteurs de croissance hématopoïétiques :

ITEM N°82 Grippe

- épidémies hivernales
- risque de surinfection (pneumopathie, infection ORI_____)
- grippe maligne (SDRA) -> hospitalisation en réanimation
- diagnostic clinique
- traitement ambulatoire : . antipyrétiques
. repos, arrêt de travail . vitamine C
. traitement antiviral moins de 72h après le début : inhibiteurs de la neuraminidase (oseltamivir) pendant 5 jours
- prévention : vaccination 1 fois par an ; 1 contre-indication = allergie à l'œuf
:

ITEM N°83 Hépatites virales Hépatites aiguës

- asymptomatiques dans 90% des cas ; sinon : phase pré-ictérique puis phase ictérique
- gravité = TP < 50%, encéphalopathie
- cytolysé avec ALAT > ASAT et ALAT > 20N
- arrêt systématique de l'alcool et des médicaments hépatotoxiques
- hépatite A : transmission oro-fécale, pas de forme chronique **Hépatites chroniques**

Hépatite B

- MST
- formes chroniques = 10% : Ag HBs positif plus de 6 mois
- mutant pré-C (50%) : réplique avec : PCR positive, Ag HBe négatif et Ac anti-HBe positif
- complications : cirrhose, carcinome hépato-cellulaire, périartérite noueuse, glomérulonéphrite extra-membraneuse
- traitement des formes actives sur le plan biologique ou histologique : analogues nucléosidiques (Lamivudine) ou INFa
- score Métavir : PBH, fibrotest (non validé)
- chez le nouveau-né ou si accident d'exposition au sang : immunoprophylaxie passive par vglobulines

Hépatite C

- chronicité : 50 à 80%
- bilan : Ac anti-VHC, PCR, génotypage
- PBH : pas si génotype 2 ou 3, cirrhose ou grossesse car traitement systématique ; fibrotest validé
- complications : cirrhose, CHC, cryoglobulinémie, glomérulonéphrite membrano-proliférative
- traitement : INFa péguilé + ribavirine ; 6 mois si génotype 2 ou 3, 12 mois si génotype 1
- ribavirine : contraception et surveillance NFS (risque d'anémie hémolytique)
- vaccination contre les hépatites B et A

Anomalies biologiques hépatiques chez un sujet asymptomatique Elévation des transaminases

- aiguë :
. hépatites aiguës virales (ALAT > ASAT), hépatites aiguës médicamenteuses, syndrome de Budd Chiari . ASAT > ALAT : hépatite aiguë alcoolique . dans les 2 cas : PBH + échographie hépatique systématiques
- chronique :
. NASH : stéatose hépatique non alcoolique (syndrome polymétabolique)
. stéatose macrovésiculaire alcoolique
. hépatites virales chroniques, hépatites auto-immunes
:

ITEM N°84 Infections à herpès virus de l'enfant et de l'adulte immunocompétents

- Un mot-clé commun : Vésicule +++

HSV : herpès cutanéomuqueux

- primo-infection : HSV1 : gingivostomatite ; HSV2 = MST : vulvovaginite, balanite ou asymptomatique



- récurrences
- kératite herpétique : contre-indication aux corticoïdes locaux +++
- traitement : aciclovir PO
- herpès récurrent = plus de 6 poussées par an : traitement pendant 6 mois

VZV : varicelle

- diagnostic clinique : prurit, vésicules, éléments d'âges différents
- attention à la fasciite nécrosante : contre-indication aux AINS +++
- complications neurologiques : ataxie cérébelleuse, convulsions
- chez l'adulte : pneumopathie varicelleuse
- contre-indication à l'aspirine +++ (syndrome de Reye)
- éviction scolaire

Zona

- topographie métamérique unilatérale
- thoracique : éruption en hémi-ceinture
- ophtalmique : urgence thérapeutique
- du ganglion géniculé : zone de Ramsay-Hunt ; paralysie faciale périphérique
- douleurs post-zostérielles
- sujet jeune : rechercher une immunodépression (VIH, lymphome...)
- traitement : Aciclovir 200 mg « 5/j pendant 7j moins de 72h après le début de l'éruption

Terrains à risque

- atopique : pustulose varioliforme de Kaposi Juliusberg : traitement = Aciclovir + antibiothérapie anti-staphylococcique IV
- femme enceinte : varicelle congénitale si contamination avant 20 SA
- herpès néonatal (remarque : pas de sérologie chez le nouveau-né mais PCR, culture...)

ITEM N°85 Infection à VIH

- sérologie avec accord : 2 ELISA, si positives : Western Blot, à confirmer sur 2 prélèvements
- si suspicion de primo-infection : Ag p24 ou PCR
- bilan Initial : sérologies CMV, toxo, HBV, HCV, syphilis ; CD4, charge virale, bilan lipidique, IDR à la tuberculine, radiographie de thorax, examen gynécologique chez la femme
- traitement = trithérapie : 2 INTI + 1 IP ou 1 INNTI
- toujours penser aux prophylaxies primaires ou secondaires (Bactrim® quand CD4 < 200/mm³)
- déclaration obligatoire
- contre-indication des vaccins vivants +++
- importance de l'observance médicamenteuse **Pneumocystose**
- radiographie de thorax : syndrome interstitiel péri-hilaire
- fibroscopie bronchique + LBA : Pneumocystis jirovecii
- facteur pronostique : LDH
- traitement : Bactrim® pendant 3 semaines + corticothérapie si paO₂ < 70 mmHg; si allergie aux sulfamides : atovaquone ou pentamidine IV

Toxoplasmose cérébrale

- abcès multiples en cocarde
- traitement : pyriméthamine + sulfadiazine + acide folinique pendant 6 semaines

Rétinite à CMV

- antigénémie pp65 + PCR + fond d'oeil
- traitement : ganciclovir pendant 3 semaines

Cryptococcose

- LCR : coloration à l'encre de Chine
- traitement = amphotéricine B **Tuberculose**
- formes extra-pulmonaires surtout
- attention aux interactions médicamenteuses : rifampicine /inhibiteurs protéasiques

ITEM N°86 Infections broncho-pulmonaires du nourrisson, de l'enfant et de

l'adulte

Bronchiolite

- VRS



- dyspnée expiratoire, sibilants
- asthme du nourrisson : 3 épisodes de dyspnée expiratoire avant 2 ans
- traitement : DRP + Kinésithérapie + antipyrétiques + fractionner les repas
- critères d'hospitalisation à connaître ++
- si hospitalisation : isolement + scope systématiques
- pas d'antibiothérapie si pas de foyer à la radiographie de thorax **Bronchites**
- pas de radiographie de thorax ; diagnostic clinique
- essentiellement virales; l'apparition de sécrétions purulentes correspond à l'évolution normale et pas à une origine bactérienne
- traitement symptomatique (pas d'antibiothérapie)
- chez le BPCO : antibiothérapie si dyspnée : Augmentin® **Pneumopathies**

Chez l'adulte

- pneumonie franche lobaire aiguë :
- . pneumocoque : syndrome de condensation ; traitement = amoxicilline 3 g/j pendant 6j
- . légionelle : déclaration obligatoire, sérologie, antigène soluble urinaire ; traitement = macrolides
- pneumonies interstitielles :
- . mycoplasmes : traitement = macrolides pendant 14j
- pneumonies excavées : anaérobies, Klebsiella, staphylocoque
- radiographie de thorax + hémocultures systématiques +++
- penser à la kinésithérapie respiratoire
- évaluation systématique à 48h
- si comorbidités ou inhalation : traitement par Augmentin®
- si hospitalisation en réanimation : fibroscopie + PDP systématiques ; traitement par C3G + macrolides IV

Chez l'enfant

- 1/3 virales 1/3 bactériennes 1/3 co-infection
- douleur abdominale +++
- chez le moins de 3 ans : pneumocoque +++
- chez le plus de 3 ans : pneumocoque ou mycoplasme
- staphylococcie pleuro-pulmonaire : 1 signe : ballonnement abdominal Nofes :

ITEM №87 Infections cutané-muqueuses bactériennes et mycosiques Impétigo

- enfant
- contagiosité +++ : éviction scolaire
- lésion élémentaire = bulle
- traitement local + règles d'hygiène
- antibiothérapie : pénicilline M pendant 10j **Furoncle**
- folliculite profonde centrée sur un poil, nécrotique
- complication : staphylococcie maligne de la face
- pas de manipulation +++
- traitement local + règles d'hygiène
- penser à l'arrêt de travail si profession à risque (cuisinier) **Erysipèle**
- streptocoque pyogenes
- grosse jambe rouge aiguë fébrile (au niveau de la face : bourrelet périphérique)
- forme typique, sans comorbidité : pas d'examen complémentaire
- complication : fasciite nécrosante : urgence médico-chirurgicale
- antibiothérapie : pénicilline G ou amoxicilline pendant 10 j
- traitement de la porte d'entrée +++
- SAT VAT
- contre-indication aux AINS ++++ **Candida Albicans**
- stomatite : muguet ± perleche
- vulvovaginite
- intertrigos des grands plis
- prélèvement mycologique systématique : pseudo-filaments à l'examen direct + culture sur milieu de Sabouraud
- Dermatophytes de la peau glabre, des plis et des phanères**
- peau convexe : herpès circiné ; guérison centrale
- plis inter-digito-plantaires (pied d'athlète)
- teignes : tondantes / kérion ; éviction scolaire ++++



- prélèvement mycologique systématique : filaments + culture sur milieu de Sabouraud
- :

ITEM N°88 Infections génitales de la femme .Leucorrhées Salpingites

- chlamydiae, gonocoque, mycoplasme
- MST
- douleur lors de la mobilisation utérine
- premier diagnostic différentiel devant une douleur abdominale chez la femme jeune = GEU
- complications : aiguës : pyosalpinx, abcès, péritonite, périhépatite ; à distance : stérilité, GEU, douleurs pelviennes chroniques
- cœlioscopie : patiente prévenue du risque de salpingectomie et de conversion en laparotomie +++
- antibiothérapie : C3G + cycline + métronidazole pendant 14j
- mise au repos des ovaires : pilule
- si stérilet : ablation + culture **Cervicite**
- MST : chlamydiae, gonocoque
- traitement des 2 germes systématiquement : azithromycine + ceftriaxone en dose unique

Leucorrhées

- physiologiques
- candida albicans : vulvovaginite, leucorrhées grumeleuses et blanchâtres ; traitement = ovule + crème antifongiques
- trichomonas vaginalis = MST ; leucorrhées verdâtres ; parasite mobile à l'examen direct ; traitement = Flagyl® PO + ovule
- Gardnerella vaginalis : test à la potasse ; Clue cells à l'examen direct ; traitement = Augmentin® pendant 7j
- :

ITEM N°89 Infections génitales de l'homme. Ecoulement urétral Urétrite

-MST

- Chlamydiae : subaiguë ; PCR sur le premier jet d'urines ; grattage urétral
- Gonocoque : aigu ; écoulement purulent, diplocoque gram - ; prélèvements multiples (urètre, anus, pharynx...)
- traitement double systématique : azithromycine + C3G en dose unique **Orchi-épididymite**
- diagnostic différentiel : torsion testiculaire
- signe de Prehn positif
- bloc épидидymo-testiculaire
- rechercher une prostatite associée +++ (TR)
- ECBU sur premier et deuxième jet + prélèvement urétral
- MST
- complications : abcès, ischémie testiculaire, infertilité
- traitement : C3G IM + doxycycline pendant 10j
- :

ITEM N°90 Infections naso-sinusiennes de l'enfant et de l'adulte

Sinusites maxillaires

- pas de radiographie dans les formes typiques (sauf si suspicion d'origine dentaire)
- traitement symptomatique pendant 48h ; si pas d'amélioration ou forte suspicion d'étiologie bactérienne : antibiothérapie (Augmentin)

Sinusites frontales et sphénoïdales

- douleurs rétro-orbitaires, céphalées
- TDM systématique
- complications : méningite, thrombophlébite, abcès cérébral, empyème, ostéomyélite
- antibiothérapie : Augmentin® pendant 10j + corticothérapie pendant 5j
- contre-indication aux AINS **Ethmoïdite**
- enfant jeune
- comblement de l'angle interne de l'œil, œdème palpébral



- TDM + examen ophtalmologique
- hospitalisation ; traitement : C3G + fosfomycine IV
- adénoïdectomie à distance **Sinusites chroniques**
- granulome apical dentaire
- radiographie des sinus + panoramique dentaire
- traitement chirurgical :

ITEM N°91 Infections nosocomiales

- délai : 48h après l'admission ; pour une infection du site opératoire : délai = 30j, 1an si matériel étranger
- précoce/ tardive ; seuil = 5j
- taux de résistance aux antibiotiques élevé
- signalement obligatoire au CLIN et à la DDASS
- facteurs de risque : liés au terrain, sondage vesical, SNG, ventilation assistée, troubles de la déglutition, décubitus dorsal strict, durée d'hospitalisation pré-opératoire
- diagnostic microbiologique systématique : ECBU, PDP, antigénurie légionelle (si infection pulmonaire), hémocultures périphériques et sur cathéter central
- antibiothérapie adaptée
- ablation de matériel, retrait de KT...
- prévention : limiter les indications de sondage urinaire, de SNG ou de ventilation assistée ; limiter la durée d'hospitalisation pré-opératoire, règles d'asepsie stricte ...
- :

ITEM N°92 Infections ostéoarticulaires

- documentation microbiologique systématique
- antibiothérapie probabiliste = pénicilline M + gentamycine, secondairement adaptée
- antibiotiques à bonne pénétration osseuse : fluoroquinolones, macrolides, synergistines, cyclines, rifampicine
- germes : staphylocoque ++ ; chez le drépanocytaire : salmonelle **Arthrite**
- rechercher la porte d'entrée +++
- ponction du liquide articulaire : examen cytologique, bactériologique et biochimique
- imagerie : radiographie : pincement articulaire diffus, érosions, déminéralisation
- hémocultures
- immobilisation antalgique
- drainage + lavage articulaire si épanchement abondant et purulent
- rééducation
- arthrose secondaire **Ostéomyélite**
- rechercher la porte d'entrée
- douleur d'allure fracturaire métaphysaire
- mobilités articulaires normales
- radiographie : réaction périostée
- scintigraphie osseuse (recherche d'autres localisations)
- immobilisation antalgique; antibiothérapie 3 à 6 semaines
- complications : épiphysiodèse, abcès sous-périosté **Discospondylite**
- raideur localisée
- rechercher des signes neurologiques +++ et une porte d'entrée
- si complication neurologique : traitement chirurgical (laminectomie)
- symptômes chroniques : BK (mal de Pott), brucellose
- radiographie : pincement discal, érosion des plateaux, géodes en miroir
- IRM rachidienne
- si hémocultures négatives : ponction-biopsie disco-vertébrale
- PL contre-indiquée
- immobilisation antalgique, corset rachidien +++
- rééducation
- :





ITEM N°93 Infections urinaires de l'enfant et de l'adulte

- fièvre = pyélonéphrite aiguë
- ASP + échographie rénale systématiques : si dilatation des cavités pyélocalicielles -> drainage des urines en urgence
- cystite non compliquée : traitement minute : fluoroquinolone
- règles hygiéno-diététiques
- traitement de la pyélonéphrite : fluoroquinolone ou C3G (+ aminoside si grave) pendant 10 à 21 j
- ECBU de contrôle +++
- prostatites : attention, si rétention aiguë d'urines : KT sus-pubien (sondage urinaire contre-indiqué)
- chez l'enfant : échographie rénale + cystographie rétrograde à distance de l'infection systématiques (recherche un reflux vésico-urétral)

Leucocyturie

- bactériurie asymptomatique : traitement uniquement chez la femme enceinte
- leucocyturie aseptique : BK, germes intracellulaires, immunodépression, infection décapitée par une antibiothérapie
- :

ITEM N°94 Maladies éruptives de l'enfant

Scarlatine

- toxine de streptocoque A
- angine
- pas d'intervalle de peau saine
- atteinte des plis de flexion
- glossite
- desquamation en lambeaux des extrémités ; langue framboisée
- antibioprophylaxie des sujets contacts

Rougeole

- catarrhe des voies aériennes supérieures
- signe de Kôplik avant l'éruption
- éruption morbilliforme descendante ; avec intervalles de peau saine
- éviction scolaire
- déclaration obligatoire

Rubéole

- adénopathies cervicales
- attention aux femmes enceintes ++
- éruption roséoliforme
- éviction scolaire

Exanthème subit (6e maladie)

- nourrisson
- HHV6
- fièvre (risque de convulsion) puis éruption sur la nuque et le tronc

Mégalérythème épidémique (5^e maladie)

- parvovirus B19
- visage (joues)
- purpura des extrémités
- crise érythroblastopénique

Mononucléose infectieuse

- angine, polyadénopathie, splénomégalie
- exanthème après la prise d'aminopénicilline

Maladie de Kawasaki

- fièvre
- adénopathie cervicale
- chéilite, glossite, énanthème
- érythème palmoplantaire
- desquamation en doigts de gant
- anévrysme des coronaires : échographie cardiaque systématique
- immunoglobulines IV + aspirine
- :



ITEM N°95 Maladies sexuellement transmissibles Gonococcies

- uréthrite aiguë, écoulement purulent
- complications : épididymite, prostatite, salpingite
- tonnes extra-génitales : anorectales, pharyngées : prélèvements multiples ++
- culture sur gélose chocolat ; diplocoque gram négatif
- gonococcémie : arthrite septique, pustules, ténosynovites
- traitement = C3G + traitement anti-chlamydiae systématique **Chlamydirose**
- uréthrite subaiguë, souvent asymptomatique
- complications : salpingite, Fitz-Hugh-Curtis, Fiessinger-Leroy-Reiter
- grattage cellulaire, PCR sur le premier jet d'urine
- traitement = azithromycine ou doxycycline + traitement du gonocoque systématique

Syphilis

- MST
- treponema pallidum
- incubation = 3 semaines
- phase primaire = chancre + adénopathie inguinale
- phase secondaire = roséole, alopecie en clairière, poly-adénopathie, syndrome grippal ; les plaques muqueuses et les syphilides sont contagieuses ++
- phase tertiaire = gommages, aortite, atteinte neurologique
- neurosyphilis : traitement par pénicilline G
- syphilis précoce ou tardive : seuil = 1 an
- microscope à fond noir
- sérologie TPHA VDRL
- extencilline = pénicilline G à libération prolongée, IM
- réaction d'Herxheimer : prévention par la corticothérapie
- surveillance = VDRL quantitatif
- déclaration obligatoire
- :

ITEM N°96 Méningites infectieuses et méningo-encéphalites chez l'enfant et chez l'adulte

- syndrome méningé fébrile
- signe de Kernig et de Brudzinski
- rechercher un purpura fulminans ++++ (traitement = C3G IM en urgence)
- si signe de localisation : TDM cérébral avant la PL
- glycémie
- purulentes : méningocoque, pneumocoque, listeria, haemophilus
- lymphocytaires : virales, BK, listeria
- rhombencéphalite : listeria, BK
- méningocoque : déclaration obligatoire + antibioprophylaxie + vaccination + isolement
- listeria : résistance aux C3G ; traitement : amoxicilline + gentamycine pendant 3 semaines
- pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline : traitement : C3G + vancomycine
- corticothérapie : enfant, BK
- enfant : mesure du PC +++
- encéphalite : PCR HSV, TDM cérébrale, EEG, interféron a : aciclovir 15 mg/kg/8h IV systématique
- séquelles sensorielles : oto-émissions acoustiques provoquées
- :

ITEM N°97 Oreillons

- virus ourlien : tropisme glandulaire et nerveux
- diagnostic clinique : 1/3 asymptomatique
- parotidite bilatérale
- orchite : risque d'atrophie testiculaire, stérilité, azoospermie
- méningite lymphocytaire, méningo-encéphalite : surdité séquellaire
- traitement symptomatique
- isolement, éviction scolaire +++
- vaccin vivant atténué :

ITEM N°98 Otagies et otites chez l'enfant et l'adulte

Otagies

- alcool/ tabac-» attention au cancer ORL +++
 - otalgie réflexe
 - examen bucco-dentaire, cervical, ORL **Otitis**
 - otite moyenne aiguë
 - . 3 germes : haemophilus, pneumocoque, moraxella catarrhalis
 - . fièvre chez l'enfant -> réflexe otoscopie
 - . paracentèse : chez le moins de 3 mois/ si complications/ échec du traitement/ hyperalgie
 - . complications : méningite, mastoïdite, thrombophlébite, paralysie faciale, labyrinthite, abcès
 - . antibiothérapie si stade purulent : Augmenta® 80 mg/kg/j pendant 8j
 - otite externe
 - . bénigne : traitement local antiseptique + antibiotique . vérifier l'absence de perforation tympanique avant tout traitement local . maligne : à Pseudomonas : antibiothérapie IV + traitement chirurgical : survient surtout chez le diabétique +++ : faire une glycémie . si otorrhée, faire un prélèvement bactériologique
 - otite séromuqueuse
 - . épanchement rétro-tympanique de plus de 3 mois
 - . hypoacousie
 - . impédancemétrie
 - . aérateurs trans-tympaniques
 - . récursive d'otites moyennes aiguës : indication à une adénoïdectomie
- /Votes :

ITEM N°99 Paludisme

- Plasmodium falciparum
 - transmission vectorielle : anophèle femelle
 - accès palustre simple : 3 phases ; fièvre tierce ou quarte
 - frottis goutte épaisse devant toute fièvre après un voyage en zone impaludée +++
 - accès palustre pernicieux : hospitalisation en réanimation : traitement : Quinine IV 25 mg/kg/j pendant 7j
 - surveillance : dextro, ECG, quininémie, parasitémie
 - si retour de zone 3 : traitement par doxycycline 200 mg/j IV
 - effets secondaires de la quinine : hypoglycémie, hypotension, troubles de la conduction
 - déclaration obligatoire seulement si paludisme autochtone
 - prophylaxie :
 - . protection contre les piqûres
 - . zone 1 : chloroquine
 - . zone 2 : chloroquine + proguanil
 - . zone 3 : méfloquine (contre-indiquée si épilepsie, troubles psy, femme enceinte)
 - . Asie : doxycycline
- A/ores :

ITEM N°100 Parasitoses digestives Lamblase

- Giardia lamblia = protozoaire cosmopolite
- contamination oro-fécale lutte contre le péril fécal
- asymptomatique ou syndrome dyspeptique, diarrhée, malabsorption
- examen parasitologique des selles : formes végétatives mobiles, kystes ; à répéter
- traitement = metronidazole pendant 5j **Taeniasis**
- Taenia saginata ou solium = cestodes cosmopolites
- contamination alimentaire : viande de porc ou de bœuf
- asymptomatique ou troubles digestifs, anneaux dans les sous-vêtements
- examen parasitologique des selles : œufs, anneaux dans les selles, scotch-test, sérologie
- traitement = praziquantel **Ascaridiose**
- Ascaris lumbricoïdes = nematode



- contamination oro-fécale lutte contre le péril fécal
- asymptomatique ou syndrome de Loeffler, migrations aberrantes
- examen parasitologique des selles : œufs
- traitement = flubendazole -**Oxyurose**
- Enterobius vermicularis = nematode cosmopolite
- ingestion d'œufs, auto-infestation
- prurit anal nocturne, vulvo-vaginite
- scotch test
- traitement = flubendazole + traitement de l'entourage + règles d'hygiène

Amibiase

- Entamoeba histolytica histolytica = protozoaire
- contamination oro-fécale -> lutte contre le péril fécal
- amibiase colique aiguë : syndrome dysentérique, syndrome rectal . rectosigmoïdoscopie : ulcérations muqueuses + micro-abcès
- . maligne : tout le colon, perforation, hémorragie, occlusion, choc septique : chirurgie (colectomie)
- . examen parasitologique des selles : amibes hématophages ; sérologies négatives
- amoebome : pseudotumeur inflammatoire du caecum -> biopsies
- amibiase hépatique : hépatomégalie, fièvre, altération de l'état général ; un syndrome phrénique doit faire craindre un abcès hépatique
- . examen parasitologique des selles négatif, sérologie positive, échographie hépatique : retrouve des abcès multiples ; la ponction est inutile ++
- traitement = amoebicide diffusible = Flagyl® pendant 10j + amoebicide de contact = Intérix®

Hydatidose

- Échinococcus granulosus ; Maghreb ++
- contact avec chien / mouton parasité
- homme = hôte accidentel ; impasse évolutive
- kystes hydatiques : hépatiques, pulmonaires, cérébraux
- sérologie
- attention : ponction contre-indiquée +++
- complications : fissuration des voies biliaires, abcès, rupture, compression d'organes
- traitement chirurgical + albendazole pendant plusieurs mois

A/ores :

ITEM N°101 Pathologie d'inoculation CAT devant une plaie

- prévention tétanos/ rage
- exploration chirurgicale, retrait des corps étrangers
- lavage, désinfection, parage, ± suture
- antibioprophylaxie : Augmentin® **Pasteurellose**
- incubation courte : 3 - 6 h
- signes inflammatoires marqués, douleur
- prélèvements bactériologiques + hémocultures
- traitement = amoxicilline pendant 10j **Maladie des griffes du chat**
- Bartonella henselae
- incubation 7-60 jours
- une ou plusieurs adénopathies volumineuses, indolores
- chez l'immunodéprimé : angiomatose bacillaire
- ponction ganglionnaire : histologie + sérologie
- abstention thérapeutique ou cyclines pendant 1 mois **Maladie de Lyme**
- Spirochète : Borrelia Burgdorferi
- piqure de tique
- phase primaire : érythème chronique migrant
- phase secondaire : arthralgies, myocardite, méningoradiculite sensitive, méningite lymphocytaire, paralysie faciale
- phase tertiaire : acrodermatite chronique atrophiante, lymphocytome cutané bénin, arthrites, démence
- sérologie
- ECG ++
- traitement : amoxicilline 3-4 g/j dans la phase primaire ; 6-8 g/j dans la phase secondaire ; phase tertiaire : C3G



- attention à la maladie professionnelle (ex : bûcheron)
- A/ores :

ITEM N°102 Pathologie infectieuse chez les migrants

Importées :

- parasitoses : paludisme ; parasitoses digestives (attention à l'anguillulose si corticothérapie), bilharziose urinaire, filariose, hydatidose, gale
- viroses : VIH, HBv
- bactéries : tuberculose, lèpre, trachome
- mycoses : teignes
- Acquisés :**
- précarité : tuberculose
- MST : VIH, VHB
- drépanocytaire : germes encapsulés
- dépistage
- suivi médico-social
- :

ITEM N°103 Prévention du tétanos

- Clostridium tétani ; neurotoxine, réservoir tellurique
- déclaration obligatoire
- trismus sans fièvre -> arrêt de l'alimentation
- tétanos généralisé : contracture généralisée + dysautonomie
- diagnostic clinique
- traitement : hospitalisation en réa, traitement de la plaie, pénicilline G, immunoglobulines IM, VAT
- prophylaxie primaire : VAT
- prophylaxie secondaire : risque élevé : Ig spécifiques IM + rappel + vaccin
- :

ITEM N°104 Septicémie

- Sepsis = syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS) + infection
- Sepsis sévère = sepsis + dysfonctionnement d'organe / hypotension / hypoperfusion d'organes.
- Syndrome de défaillance multiviscérale : plusieurs dysfonctions d'organes
- Choc septique = sepsis + hypotension (< 90 mmHg ou diminution de plus de 40 mmHg) persistant malgré le remplissage vasculaire
- . hyperkinétique / hypokinétique
- . traitement = remplissage vasculaire + drogues inotropes + bi-antibiothérapie probabiliste
- . corticothérapie : hémisuccinate d'hydrocortisone ($\pm$ test au synacthène) (à discuter) . contrôle de la glycémie
- . $\pm$ protéine C activée
- :

ITEM N°105 Surveillance des porteurs de valve et de prothèse vasculaire

- valve mécanique : avantage = dure toute la vie - inconvénients = hémolyse, anticoagulant à vie
- bioprothèse : avantage = pas d'anticoagulant - inconvénient = dégénérescence après 10-15 ans
- chirurgie conservatrice : valvuloplastie (mitrale) **Risques**
- 1ère complication = accident hémorragique sous AVK +++
- embolie
- endocardite
- désinsertion de prothèse
- thrombose (occlusive / non occlusive) -> héparine non fractionnée + chirurgie en urgence
- souffle de régurgitation = toujours pathologique **Surveillance**
- INR /mois
- NFS, bilan d'hémolyse, bilan martial, ECG, ETT, Radio de thorax /an
- bilan stomato et ORL x 2/an ++
- radiocinéma postopératoire de la valve (pour les valves mécaniques)



- éducation, carte de porteur de prothèse
- prévention de l'endocardite d'Osier : antibioprophylaxie ++++ **Prothèse vasculaire**
- complications : thrombose, sténose, anévrisme, infection
- :

ITEM N°106 Tuberculose

- coloration de Ziehl-Nielsen -> BAAR
- culture sur milieu de Löwenstein
- granulome épithélioïde et giganto-cellulaire avec nécrose caséeuse
- IDR à la tuberculine : immunité cellulaire
- Primo-infection : virage de l'IDR - pas de BK dans l'expectoration . traitement si symptomatique ou si enfant / Immunodéprimé
- chimioprophylaxie des sujets contacts (enfant, ID) = Isoniazide + Rifampicine x 3 mois
- bilan préthérapeutique = créatinine, BHC, uricémie, fond d'oeil
- traitement = IREP x 2 mois + IR pendant 6-12 mois
- surveillance : transaminases, radio de thorax, BK-crachats
- indication de la corticothérapie = méningite, péricardite, miliaire asphyxiante
- attention aux interactions médicamenteuses ; rifampicine = inducteur enzymatique (interactions avec AVK, traitement VIH, contraceptifs oraux, corticoïdes)
- déclaration obligatoire
- vitamine B6
- sérologie VIH +++
- éducation : observance
- PEC 100%
- isolement respiratoire +++
- recherche des sujets contacts : clinique, IDR, radio de thorax
- tuberculose disséminée : miliaire, mal de Pott, atteinte ganglionnaire, neurologique...
- :

ITEM N°107 Voyage en pays tropical : conseils avant le départ

- prévention du paludisme : exposition et chimioprophylaxie
- vaccination : DTP, fièvre jaune (obligatoire), typhoïde, hépatite A et B, méningite
- lutte contre le péril fécal : eau, alimentation, lavage des mains
- lutte contre les parasites : pas de baignade, pas de marche pieds nus
- prévention MST
- photoprotection
- assurance tous risques **Pathologies du retour : fièvre, diarrhée Fièvre**
- interrogatoire +++
- paludisme : incubation > 7 jours -> frottis goutte épaisse
- arbovirus : incubation : 3-15 jours
- méningite
- hépatites virales
- fièvre typhoïde : déclaration obligatoire, pouls dissocié, tymphos, fièvre en plateau
- sérologie VIH
- hémocultures
- infections communautaires **Diarrhée**
- bénigne +++ : turista (ECET)
- syndrome dysentérique : shigelle, salmonelle, amibiase
- syndrome cholérique : choléra : attention à la déshydratation
- fièvre typhoïde, paludisme
- sérologie VIH
- examen parasitologique des selles, coproculture
- :

ITEM N°108 Environnement professionnel et santé

Prévention des risques professionnels. Organisation de la



Médecine du Travail

Missions du médecin du travail

- visite d'embauché : fiche d'aptitude
- visite de reprise, périodique (tous les 2 ans)
- amélioration des conditions de travail
- protection des salariés contre les nuisances
- prévention et éducation sanitaire
- tiers-temps : étude des différents postes de travail
- secret médical : communication avec le médecin traitant seulement si accord du patient

Prévention des risques professionnels

- protection collective
- protection individuelle
- formation et information des salariés

Pneumoconioses

- silicose : opacités pulmonaires, calcification en coquille d'oeuf, insuffisance respiratoire chronique
- asbestose : amiante, au lavage bronchio-alvéolaire : corps asbestosiques > 1 /ml, plaques pleurales, calcifications pleurales en coquille d'oeuf, mésothéliome pleural (plèvre mamelonnée)

Nofes :

ITEM N°109 Accidents du travail et maladies professionnelles Accidents du travail

- tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail + accidents de trajet
- présomption d'imputabilité
- déclaration à l'employeur dans les 24 heures
- employeur : déclaration à la CPAM dans les 48 heures + attestation de salaire + feuille d'accident de travail remis à la victime
- médecin : certificat médical initial /de prolongation /final : IPP +++ **Maladies professionnelles**
- tableaux : titre, symptôme, délai de prise en charge, professions concernées, durée minimum d'exposition
- si pas de tableau : comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
- la victime envoie le formulaire de déclaration de maladie professionnelle + certificat médical initial + attestation de salaire à la CPAM

Conséquences

- PEC 100 % + exonération du ticket modérateur et du forfait hospitalier
- indemnités journalières sans délai de carence si arrêt de travail
- indemnisation : si IPP < 10% : capital, si IPP > 10% : rente
- :

ITEM N°110 Besoins nutritionnels et apports alimentaires de l'adulte

EDUCATION +++ Adulte

- énergie : homme : 2500 Kcal/j - femme : 2000 Kcal/j
- glucides 50% - lipides 35% - protides 15% = 0,8 g/kg/j
- sodium : 4 g/j - fer : 15 mg/j - calcium : 1 g/j
- 3 repas /j
- importance des fruits et légumes
- eau : 1,5 l/j **Femme enceinte**
- supplémentation en folates : 0,5 mg/j si pas de facteur de risque, sinon 5 mg/j
- supplémentation martiale ++ si facteur de risque
- Vitamine D 100 000 UI à M7 **Sujet âgé**
- supplémentation en calcium et Vitamine D
- pas de régime restrictif +++
- protides : 1 g/kg/j **Evaluation de l'état nutritionnel**
- enquête alimentaire : interrogatoire (dernières 24 heures), carnet alimentaire pendant 7j, comportement alimentaire
- poids, IMC
- mesures anthropométriques : plis cutané (tricipital) = masse grasse, circonférence brachiale = masse maigre

Dénutrition

- BMI < 19



- 2 modèles : carence d'apports énergétique (marasme), carence protéique (Kwashiorkor)
- susceptibilité aux infections, difficultés de cicatrisation
- marqueurs biologiques : albumine (sévère si < 30 g/l), pré-albumine, CRP
- retentissement : NFS, glycémie... **Prise en charge :**
- renutrition progressive
- indications de nutrition artificielle : perte de poids > 10%, syndrome d'hypercatabolisme > 15 j
- voie entérale (SNG, gastrostomie) à privilégier par rapport à la voie parentérale
- attention au syndrome de renutrition : correction des carences vitaminiques et en oligo-éléments

ITEM N°111 Sport et santé

Rôle préventif pour les facteurs de risque cardio-vasculaires, l'ostéoporose, les cancers **Aptitude aux sports chez l'enfant et chez l'adulte**

- conseiller la pratique d'un sport adapté
- examen médical d'aptitude au sport : fonction cardiovasculaire (ECG recommandé, pas obligatoire), examen orthopédique (rachis ++), test de Ruffier- Dickson si cardiopathie (épreuve d'effort)
- surveillance de la croissance et de la maturité sexuelle +++
- certificats : de non contre-indication à la pratique d'un sport, de dispense
- risques de l'entraînement intensif (> 8 h / semaine) = ostéochondrose, fractures de fatigue, arrachement tendineux, retard de croissance
- attention aux produits dopants **Besoins nutritionnels chez le sportif**
- augmentation des besoins énergétiques
- glucides : principal substrat énergétique pour les sports d'intensité élevée
- lipides : principal substrat énergétique pour les sports d'intensité modérée (endurance)
- pas d'augmentation des apports lipidiques, pas de supplémentation protidique
- hydratation et apport sodé : attention au coup de chaleur

MODULE 8 : IMMUNOPATHOLOGIE REACTION INFLAMMATOIRE

ITEM N°112 Réaction inflammatoire : Aspects biologiques et cliniques. Conduite à tenir

- clinique : douleur, rougeur, chaleur, œdème
- biologique : VS, CRP, fibrinogène, orosomucoïde, pro-calcitonine
- fausse VS augmentée : hypergamma-globulinémie, anémie, grossesse, insuffisance rénale, diabète, obésité, hypercholestérolémie
- Anémie microcytaire non régénérative à ferritine élevée
- histologie : en aigu : PNN - en subaigu : lymphocytes - inflammation chronique : fibrose
- penser à la maladie de Horton chez le sujet âgé +++
- bilan : électrophorèse des protéines plasmatiques, bilan infectieux, immunologique, rechercher un cancer ++
- complication à long terme : amylose AA
- traitement : AINS et corticoïdes : inhibition de la synthèse des prostaglandines, Anti-TNF alpha : action sur les cytokines

ITEM N°113 Allergies et hypersensibilités chez l'enfant et l'adulte : aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement

- Classification de Gell et Coombs
- . type I = hypersensibilité immédiate (Ig E, mastocytes, PNB) : choc anaphylactique, urticaire...
- . type IV = hypersensibilité retardée (lymphocytes T) : eczéma de contact, IDR
- enquête allergologique : interrogatoire +++ (circonstances déclenchantes), terrain atopique, toujours rechercher une seconde allergie



- patch tests (lecture à 72 heures), prick tests (lecture à 15 minutes)
- bilan de 2^e intention : Ig E spécifique, tests d'éviction-réintroduction
- tests de provocation : en réa ++
- EDUCATION +++
- carte d'allergique
- PREVENTION : éviction de l'allergène
- désensibilisation spécifique (immunothérapie) : venins, pollens, acariens
- anti-histaminiques, corticoïdes
- kit auto injectable d'adrénaline = Anakit®
- :

ITEM N°114 Allergies cutané-muqueuses chez l'enfant et l'adulte. Urticaire,

dermatite atopique et de contact

Urticaire

- papules œdémateuses fugaces et migratrices + prurit
- profonde = œdème de Quincke
- physique = dermographisme à la pression, au froid (attention à la cryoglobuline), cholinergique
- diagnostic clinique
- exploration d'une urticaire chronique (> 6 semaines) : Prick tests, bilan immunologique, thyroïdien, infectieux, BHC, ± biopsie (recherche une vascularite)
- traitement = anti-histaminiques (Atarax®, Polaramine®)
- pas de corticoïdes ++

Dermatite atopique

- diagnostic clinique : vésicules + prurit + contours émiétés
- topographie :
 - . < 2 ans : visage, convexités
 - . > 2 ans : plis de flexion, lichénification
- xérose cutanée, signe de Dennie Morgan
- attention au HSV syndrome de Kaposi -Juliusberg
- traitement = dermocorticoïdes (II ou III) + émollients
- hygiène, ongles courts, vêtements en coton
- contre-indication des corticoïdes par voie générale risque d'effet rebond +++

Eczéma de contact

- hypersensibilité retardée (type IV) : 48 - 72 heures après le contact
- prurit, vésicules, contours émiétés
- attention aux maladies professionnelles
- patch tests systématiques
- diagnostic différentiel : dermatite irritative
- traitement = dermocorticoïdes II ou III + éviction de l'allergène :

ITEM N°115 Allergies respiratoires chez l'enfant et chez l'adulte

Triade atopique = asthme, rhinite, eczéma atopique **Asthme**

- attention au tabagisme
- allergènes professionnels
- peak-flow mesure le DEP +++
- éducation ++
- EFR, prick tests
- contre-indication des bêtabloquants dans l'asthme **Rhinite allergique**
- obstruction nasale + éternuement + rhinorrhée + prurit
- intermittente / persistante ; seuil = 4 j / semaine ou 4 semaines / an
- légère / modérée à sévère selon le retentissement
- rhinoscopie antérieure : recherche une polypose nasale, une déviation septale...
- prick tests
- traitement : corticoïdes locaux, anti-histaminiques locaux, anticholinergiques locaux
- traitement étiologique = désensibilisation (acariens, pollens)
- :



ITEM 115 bis Déficit immunitaire

- risque infectieux ++
- infections communautaires : plus sévères et récidivantes
- infections opportunistes : pneumocystose, toxoplasmose, CMV, HSV ...
- déficits immunitaires congénitaux -VIH
- syndromes lymphoprolifératifs, lymphomes
- iatrogénie : transplantation, corticothérapie, splénectomie ...
- risque accru de cancers
- :

ITEM N°116 Pathologies auto-immunes : aspects épidémiologiques, diagnostiques et principes de traitement

- auto-anticorps
 - FAN en 1^{re} intention -> si positifs : recherche d'Ac-anti Ag nucléaires solubles
 - cytopénies (NFS)
 - EPP : hyperglobulinémie polyclonale
 - complément : total, C3, C4, CH50
 - pas toujours de syndrome inflammatoire
 - corticothérapie = facteur d'athérogénèse à long terme +++ (1TM cause de décès)
 - immunosuppresseurs (MTX, anti-TNFalpha...) -PEC 100%ALD 30
- Sclérodémie** : syndrome de Raynaud, capillaires dystrophiques, sclérose cutanée, atteintes viscérales : digestive (oesophage), pulmonaire (HTAP), rénale +++
- Ac anti-scl 70

Polymyosite et dermatopolymyosite : anticorps anti-JOI, atteinte musculaire -> CPK, EMG. Atteinte cutanée (érythème lilacé des paupières, signe de la manucure)
- attention au syndrome paranéoplasique ++

Syndrome de Gougerot-Sjögren : primaire ou secondaire. Atteinte des glandes exocrines : xérophtalmie, xérostomie-> syndrome sec.

- biopsie des glandes salivaires -Acanti SSA/SSB **Vascularites**

Vaisseaux de gros calibre (aorte et ses branches)

- maladie de Horton
- Takayashu (femme jeune, claudication des membres supérieurs, HTA)

Vaisseaux de moyen calibre

- Périartérite noueuse (PAN) : multinévrite, signes cutanés, néphropathie vasculaire
. PBR contre-indiquée (anévrismes) -> artériographie . rechercher une infection virale : VHB, VHC, VIH...

- maladie de Kawasaki **Vaisseaux de petit calibre**

- granulomatose de Wegener : atteinte ORL + syndrome pneumo-rénal (hémorragie intra-alvéolaire + GNRP)-> ANCAc
- polyangéite microscopique : purpura, syndrome pneumo-rénal -> ANCAp
- Churg et Strauss : asthme + rhinite, ANCAp, hyperéosinophilie sanguine
- purpura rhumatoïde
- syndrome de Goodpasture : syndrome pneumorénal, Ac anti MBG
- cryoglobulinémie : symptômes au froid, Raynaud, VS basse
- :

ITEM N°117 Lupus érythémateux disséminé

- vespertilio
- photosensibilité
- pronostic = atteinte rénale -> PBR si protéinurie > 0,5 g / 24 heures
- AC anti-ADN natif, anti-Sm, anti-nucléosome
- lupus induit : Ac anti-histone
- test de Coombs
- complément abaissé lors des poussées
- pilule oestro-progestative contre-indiquée -> contraception : microprogestatifs +++
- grossesse autorisée si rémission > 6 mois + fonction rénale normale
- antipaludéens de synthèse (Plaquenil®) -> surveillance ophtalmique +++



- corticothérapie (Prednisone) + mesures associées -> iatrogénie -PEC100%
- recherche d'un SAPL systématique
- photoprotection

Syndrome des anti-phospholipides (SAPL)

- définition = clinique (thromboses / fausses couches) + biologique : SAPL confirmé sur 2 prélèvements à 8 semaines d'intervalle
- anticoagulant circulant : augmentation du TCA non corrigée par l'adjonction de plasma témoin
- VDRL positif TPHA négatif
- Ac anti-cardiolipine
- héparinothérapie : surveillance-> héparinémie ou anti-Xa (pas de surveillance sur le TCA +++)
- AVK au long cours
- prévention des complications obstétricales : Aspirine 100 mg
- :

ITEM N°118 Maladie de Crohn et recto-colite hémorragique Maladie de Crohn

- tout le tube digestif, atteinte ano-périnéale
- tabac = facteur de risque -> arrêt impératif
- iléo-coloscopie + biopsies
- syndrome de Koenig
- histologie : atteinte segmentaire, transmurale ± ulcération, fissures, fistules, sténoses
- infiltrat inflammatoire -> granulome épithélioïde **Recto-colite hémorragique**
- rectum + colon
- lésions superficielles et continues
- pas de sténose, pas de fistule, pas de granulome
- limite entre muqueuse saine et muqueuse pathologique nette
- complication : colite aiguë grave
- traitement curatif : chirurgie : coloproctectomie totale + anastomose Néo-anale sur réservoir en J

Les 2 :

- cancer colorectal : risque relatif = 5
- dépistage : coloscopie / 2 ans
- manifestations extra-digestives : arthrites, SPA, érythème noueux, aphtes, cholangite sclérosante, uvéite, amylose AA
- traitements : dérivés salicylés, corticoïdes, immunosupresseurs, anti-TNFalpha, nutrition entérale
- :

ITEM N°119 Maladie de Horton et pseudo-polyarthrite rhizomélique Maladie de Horton

- sujet âgé > 50 ans
- vascularite des artères de gros et moyen calibre
- céphalée temporale nocturne, induration de l'artère temporale, abolition du pouls temporal
- claudication de la mâchoire, hyperesthésie du cuir chevelu
- association à des symptômes de pseudo-polyarthrite rhizomélique
- attention à l'atteinte oculaire +++ (risque de cécité) : NOIAA, NORB, OACR
- syndrome inflammatoire biologique important, cholestase anictérique
- biopsie de l'artère temporale : granulome inflammatoire à cellules géantes + fragmentation de la limitante élastique interne
- corticothérapie : 0,7 mg/kg/j : puis décroissance pour une durée totale de 18 mois + mesures associées
- si forme sévère : bolus IV de corticoïdes + anticoagulant et/ou Aspirine
- suivi : CRP

Pseudo-polyarthrite rhizomélique

- douleurs des ceintures scapulaires et pelviennes, myalgies provoquées
- dérouillage matinal
- radios normales
- rechercher une maladie de Horton +++ -> palpation des artères temporales
- corticothérapie : 0,3 mg/kg/j puis décroissance pour une durée totale de 12 mois + mesures associées
- :





ITEM N°120 Pneumopathie interstitielle diffuse

- attention aux maladies professionnelles
- EFR : troubles de la diffusion : baisse de DLCO, syndrome restrictif, baisse de compliance
- gaz du sang : effet shunt, désaturation à l'effort
- radio de thorax : syndrome interstitiel, images en verre dépoli, micronodules, syndrome réticulaire, fibrose, aspect en rayon de miel
- TDM thoracique en coupes millimétriques ++
- LBA :
 - . prédominance lymphocytaire : sarcoïdose ; Pneumopathie d'hypersensibilité, pneumopathies médicamenteuses (cordarone, methotrexate), connectivités (LED)
 - . prédominance de PNN : fibrose pulmonaire primitive : râles velcro, hippocratisme digital
 - . particules minérales (corps asbestosiques) -> asbestose, silicose (amiante) -> pneumoconioses - OAP
- pneumopathies infectieuses (pneumocystose, mycoplasme)
- lymphangite carcinomateuse
- :

ITEM N°121 Polyarthrite rhumatoïde

- arthrite bilatérale et symétrique : mains et poignets (respect des IPD)
- synovites : pannus synovial, tenosynovites
- nodules rhumatoïdes
- destruction articulaire : signes radiologiques : érosions (tête 5^e méta), géodes, pincements articulaires->déformation articulaire
- facteur rhumatoïde : latex, Waaler-Rose, ELISA
- anti-CCP
- luxation atloïdo-axoïdienne
- amylose AA
- DAS 28
- traitement des poussées : AINS (Voltarène®), corticoïdes
- traitement de fond : methotrexate + acide folique + contraception +++, anti-TNF-alpha
- traitements locaux : infiltrations, synoviorthèses, orthèses, chirurgie
- rééducation, kinésithérapie, ergothérapie -PEC 100%
- éducation
- :

ITEM N°122 Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire (syndrome de Guillain-Barré)

- affection démyélinisante primitive
- neuropathie périphérique diffuse, bilatérale et symétrique, ascendante
- atteinte sensitivo-motrice, abolition des ROT, diplégie faciale
- épisode infectieux ou vaccination récente
- évolution en 3 phases : extension, plateau, récupération
- signes de gravité : respiratoire, troubles de la déglutition, troubles végétatifs (dysautonomie), complication de décubitus (phlébite)
- hospitalisation en réa A JEUN, scope
- LCR : dissociation albumino-cytologique
- EMG : atteinte neurogène périphérique démyélinisante : baisse des vitesses de conduction, augmentation des latences distales, bloc de conduction, pas d'atteinte axonale
- gaz du sang, EFR +++
- surveillance : peak-flow, testing musculaire, ECG, déglutition, mollets
- traitement spécifique : Plasmaphérese, Ig IV
- prévention thrombo-embolique : HBPM
- kinésithérapie
- attention à la paralysie faciale » soins oculaires
- :

ITEM **N°123 Psoriasis**

- lésion élémentaire : plaque érythémato-squameuse bien limitée
- pas de prurit
- topographie : faces d'extension : coudes, genoux, ombilic, cuir chevelu
- psoriasis unguéal : dépressions ponctuées en dé à coudre
- facteur déclenchant de poussées : psy, médicamenteux, infectieux, traumatiques
- formes graves : érythrodermie, psoriasis pustuleux généralisé : contre-indication de la PUVA-thérapie - traitement des formes graves = acitrétine
- rhumatisme psoriasique : distal, asymétrique, atteinte des IPD, orteils en saucisse - pas de parallélisme avec les lésions cutanées -traitement = AINS, méthotrexate
- traitements :
 - . locaux : dermocorticoïdes forts (I ou II), dérivés de la vitamine D, rétinoïdes, kératolytiques
 - . photothérapie : PUVAthérapie (+ Psoralène®). Contre-indications : formes graves, grossesse, cancers cutanés
 - . généraux : acitrétine (Soriatane) + contraception, methotrexate, Ciclosporine
- attention : pas de corticothérapie générale -► risque d'effet rebond
- PEC psychologique : préjudice esthétique, handicap social
- :

ITEM **N°124 Sarcoïdose**

- adenopathies médiastinales hilaires, bilatérales et symétriques, non compressives ± pneumopathie interstitielle
- classification radiologiques : IV stades
- diagnostic histologique systématique sauf pour le syndrome de Löfgren
- fibroscopie : LBA : prédominance lymphocytaire, CD4 ++, biopsie : granulome tuberculoïde sans nécrose caséuse
- syndrome de Löfgren : adenopathies, fièvre, érythème noueux, arthrite, anergie tuberculinique
- syndrome d'Heerfordt : uvéite + parotidite + paralysie faciale périphérique
- ECG systématique (troubles de la conduction, hypercalcémie)
- lymphopénie
- examen ophtalmo systématique
- hypercalcémie, hypercalciurie, augmentation enzyme de conversion de l'angiotensine
- diagnostic différentiel = tuberculose +++ -> recherche systématique
- traitement : corticothérapie si sévère -attention : pas de supplémentation calcique +++ :

ITEM **N°125 Sclérose en plaques**

- lésions inflammatoires démyélinisantes de la substance blanche, disséminées dans le temps et dans l'espace
- atteinte du système nerveux central seulement +++
- NORB : baisse de l'acuité visuelle, douleur rétro-orbitaire, signe de Marcus Gunn
- diplopie : paralysie oculomotrice ou ophtalmoplégie internucléaire
- syndrome cordon post (signe de Lhermitte)
- troubles génito-sphinctériens -> bilan urodynamique systématique +++
- échographie vésicale : résidu post-mictionnel
- PL (pas systématique) : synthèse intra-thécale d'immunoglobulines
- IRM cérébrale et médullaire : hypersignaux en T2 de la substance blanche périventriculaire
- potentiels évoqués : PEV, PEA, PES, PEM
- traitement des poussées = repos + bolus IV de méthylprednisolone 1 g/j x 3 j après bilan préthérapeutique : (TA, K\ ECG)
- prévention des complications de décubitus : HBPM
- traitement de fond : Interféron bêta + contraception
- kinésithérapie +++
- traitement de la spasticité : baclofène (Lioresal®)
- ergothérapie
- :



ITEM N°126 Immunoglobuline monoclonale

- VS élevée
- attention devant une hypogammaglobulinémie
- électrophorèse des protéines -> recherche un pic / immuno-électrophorèse -> recherche une monoclonalité
- attention : contre-indication de toute imagerie avec produit de contraste iodé +++
- myélogramme +++
- étiologies : myélome, Waldenström (IgM), LLC, lymphome, plasmocytome, MGUS +++ (risque évolutif = 1% par an)
- complications : hyperviscosité sanguine, insuffisance rénale (tubulopathie, dépôts tissulaire d'Ig), cryoglobulinémie, activité autoanticorps, POEMS Syndrome, insuffisance médullaire
- amylose AL :

ITEM N°127 Transplantation d'organes : aspects épidémiologiques et immunologiques

- pénurie d'organes
- réaction allogénique : directe -> rejet aigu ; indirecte -> rejet chronique
- compatibilité : ABO identique, compatibilité HLA pour les greffes rénales, cross match négatif +++

Principes de traitement et surveillance

- immunothérapie à vie ++ : anticalcineurine (ciclosporine) + corticoïde + inhibiteur de la prolifération lymphocytaire (azathioprine ou mycophénolate mofétil)
- prophylaxie : antiviraux (ganciclovir), antibiotiques (Bactrim®), antifongique (fluconazole)
- surveillance : fonction du greffon, NFS, risque infectieux, cancers (cutanés, gynéco...)

Complications et pronostic

- non fonction primaire du greffon
- rejet hyper aigu : prévention par un cross match systématique
- rejet aigu : traitement par corticoïdes
- rejet chronique
- infectieuses : CMV, EBV, HSV, hépatites B et C, BK, pneumocystose
- tumorales : cancers cutanés, lymphomes, cancers gynéco (HPV)
- cardio-vasculaires : 1^{re} cause de décès pour les greffes rénales
- récurrences de la maladie initiale
- complications iatrogènes
- contre-indications des greffes : VIH, cancer, espérance de vie inférieure à 2 ans, facteurs de risque cardio-vasculaire importants (risque opératoire)

Aspects éthiques et légaux

- consentement
- gratuité
- anonymat
- lois de bioéthique
- inscription obligatoire sur liste d'attente de greffe gérée par l'EFG
- Bilan pré-transplantation :**
- immunologique : groupe, rhésus, RAI; phénotypage HLA, Ac anti-HLA
- recherche de cancer : TDM corps entier, PSA, FOGD, examen gynécologique
- bilan infectieux : sérologies VIH, HBV, HCV, HSV, syphilis, CMV, EBV, toxoplasmose
- facteurs de risque cardio-vasculaires : ECG, ETT, écho-doppler des troncs supra-aortiques
- :

MODULE 9 : ATHEROSCLEROSE -HYPERTENSION - THROMBOSE

ITEM N°128 Atherome : épidémiologie et Physiopathologie

- Localisations :
- . carotides, vertébrales ->AVC . coronaires->I DM
- . aorte thoracique et abdominale ->anévrisme, ischémie mésentérique . artères des membres inférieurs -> AOMI



- Physiopathologie :
 - . accumulation de LDL dans l'intima -> pénétration de monocytes-> transformation en macrophages -
 - > formation de cellules spumeuses
 - . différents stades : strie lipidique -> plaque d'athérome = noyau lipidique + chape fibreuse
- Complications : ulcération, rupture, fissure de plaque -> thrombose -> embolie
- . sténose symptomatique quand > 50 % de la lumière vasculaire . hémorragie intra-plaque -> dissection **Le malade polyathéromateux**
- 1 localisation athéromateuse -> recherche systématique des autres (clinique + paraclinique)
- évaluation du risque cardio-vasculaire global
- recherche et traitement des FDRCV
- préventions primaire et secondaire
- traitement : aspirine systématique, statines systématiques en prévention secondaire, place des IEC
- +++
- :

ITEM N°129 Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention

- 5 FDRCV majeurs : tabac, HTA, diabète II, dyslipidémie, âge (H > 50 ans, F > 60 ans)
- FDRCV prédisposants : obésité androïde, sédentarité, antécédents familiaux
- syndrome métabolique : 3 critères parmi :
 - . obésité androïde, hypertriglycéridémie, HDL cholestérol bas (< 35), HTA, glycémie à jeun > 1,1 g/l
- bilan systématique si 1 facteur de risque ou un événement cardio-vasculaire : glycémie à jeun, bilan lipidique, ECG, radio de thorax
- prévention : arrêt du tabac +++, équilibre tensionnel, alimentation équilibrée, règles hygiéno-diététiques, exercice physique
- :

ITEM N°129 bis Prise en charge d'une dyslipidémie

- LDLc = cholestérol total - HDLc - TG/ 5 (si TG < 4 g/l) **Objectifs :**
- 0 FDRCV : LDL < 2,2 g/l
- 1 FDRCV : LDL < 1,9 g/l
- 2 FDRCV : LDL < 1,6 g/l > 3 FDRCV : LDL < 1,3 g/l
- objectif : LDL < 1 g/l si :
 - . antécédent cardio-vasculaire avéré
 - . diabète II à haut risque = atteinte rénale ou avec 2 FDRCV
- FDRCV à prendre en compte : âge, antécédents familiaux, tabac, HTA, diabète II
- surveillance d'un traitement par statines : bilan hépatique, CPK
- Nofes :

ITEM N°130 Hypertension artérielle de l'adulte

- facteur de risque d'AVC +++ -> Risque relatif = 8
- HTA essentielle dans 90% des cas / secondaire dans 10% -> rechercher systématiquement une HTA secondaire
- diagnostic : PA > 140/90 à 2 reprises, sujet au repos, avec brassard adapté, PAaux2 bras
- bilan OMS : ionogramme sanguin (K +), créatinine, uricémie, NFS, bilan lipidique, glycémie, BU, ECG
- retentissement : hypertrophie ventriculaire gauche, anévrysmes, dissection, AVC, néphroangiosclérose, rétinopathie (FO ++)
- objectif :
 - . TA < 130/80 si diabète ou néphropathie . TA < 125/75 si protéinurie > 1 g/24h
- règles hygiéno-diététiques : régime sans sel, perte de poids, pas d'alcool, exercice physique régulier
- si échec après 3 mois : traitement médicamenteux : débiter par une monothérapie : IEC, bêtabloquants, diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, anti-HTA centraux
- HTA résistante = échec des règles hygiéno-diététiques + trithérapie comportant 1 diurétique
- HTA secondaire**
- hyperminéralocorticisme ++ : hypokaliémie ++
- . primaire : adénome de Conn, hyperplasie bilatérale des surrénales-> TDM des surrénales



- secondaire : sténose des artères rénales (athérome ou dysplasie fibro-musculaire) : HTA résistante, aggravée par les IEC
- phéochromocytome : HTA paroxystique + céphalées, palpitations, sueurs ; rechercher 1 NEM ++
- coarctation de l'aorte : HTA aux membres supérieurs, abolition des pouls fémoraux, radio de thorax : double bouton aortique
- toxiques : alcool, glycérrhizine, cestroprogestatifs **HTA maligne**
- PAD > 130 mm Hg + rétinopathie stade III ou IV
- risques : OAP, dissection aortique, encéphalopathie hypertensive, éclampsie
- bilan : fond d'oeil, troponine, ionogramme sanguin, bilan d'hémolyse, hémostase, protéinurie des 24 heures, ECG, radio de thorax
- traitement : inhibiteur calcique (Loxen®) IV, diminution progressive de la TA (attention à l'AVC sur bas débit)
- :

ITEM N°131 Artériopathie oblitérante de l'aorte et des membres inférieurs

- tabac : 1^{er} facteur de risque -> arrêt impératif ++
- claudication intermittente, impuissance (syndrome de Leriche)
- périmètre de marche
- palpation et auscultation des pouls périphériques
- classification de Leriche et Fontaine (4 stades)
- index de pression systolique
- écho-doppler artériel : bilan des lésions, recherche d'une circulation collatérale
- artériographie systématique si lésion iliaque ou fémorale
- contre-indication des bêtabloquants aux stades III et IV
- exercice physique : réhabilitation à la marche +++
- traitement médicamenteux : antiagrégant plaquettaire, statine, ± vasodilatateur
- angioplastie + stent ou pontage si échec du traitement médicamenteux ou si stades III et IV
- au stade de gangrène : amputation **Anévrismes**
- dilatation localisée avec perte du parallélisme des parois et calibre aorte > 30 mm
- évolution : augmentation de 0,5 cm/an
- HTA = 1^{er} facteur de risque +++
- masse battante et expansive, souffle abdominal
- anévrisme sous-rénal : signe de De Bakey
- échographie abdominale (seul examen en urgence)
- angio TDM
- bilan vasculaire systématique : échodoppler des troncs supra-aortiques, ECG, ETT, échodoppler des membres inférieurs
- traitement = chirurgie : si complication, diamètre > 5 cm ou augmentation rapide du diamètre
- :

ITEM N°132 Angine de poitrine et infarctus myocardique Angor chronique stable

- douleur constrictive rétrosternale à l'effort
- cède à la prise de trinitrine sublinguale en moins d'1 minute
- ECG percritique : sous décalage du ST, ondes T négatives
- diagnostic : épreuve d'effort : ECG, scintigraphie myocardique, échographie de stress
- ETT systématique
- coronarographie si épreuve d'effort positive
- traitement de fond :
 - . règles hygiéno-diététiques + exercice physique +++ . BB" + aspirine + statine + Plavix®
 - . IEC si antécédent d'IDM, HTA, insuffisance rénale chronique, diabète, dysfonctionnement du VG
- Syndromes coronariens aigus ST - (occlusion incomplète de l'artère)**
- haut risque / bas risque
- ECG : sous décalage du ST, ondes T négatives
- ETT systématique
- traitement : USIC, scope
- . attention pas d'antalgiques +++ (masquent la récurrence de douleur) . HNF curatif + BB" + aspirine + Plavix® + dérivés nitrés (si PAS >



100mm Hg) + statine + anti-GpIIb/IIIa si haut risque . coronarographie dans les 48 heures . attention : jamais de fibrinolyse

ST + (occlusion coronaire totale)

- ECG 18 dérivations : onde de Pardee, onde Q de nécrose (> 6 h), systématisé à un territoire vasculaire ; images en miroir
- enzymes cardiaques : troponine, CPK
- ETT : en urgence si complication (choc, OAP) sinon à J1-J2
- IDM inférieur : risque d'extension au VD ++ : contre-indication des BB , dérivés nitrés, IEC, diurétiques à la phase aiguë
- traitement :USIC, scope
- . aspirine + héparine + Plavix® + BB" + anti-GpIIb/IIIa . revascularisation : coronarographie si délai < 90 minutes, pas de thrombolyse après 12 h . dès J1 : statine + IEC
- . à distance : réadaptation à l'effort ; épreuve d'effort à 6 mois si angioplastie, à la recherche d'une resténose ; coronarographie systématique si thrombolyse à la phase aiguë
- :

ITEM N°133 Accidents vasculaires cérébraux AVC ischémique

- 3 etiologies principales : athérome, cardiopathie emboligène, HTA (lacunes)
- sujet jeune : dissection carotidienne ++ : cervicalgie, Claude-BernardHorner, échodoppler : double chenal
- symptômes : systématisation à un territoire vasculaire
- tronc cérébral : syndrome alterne ; au niveau du bulbe : syndrome de Wallenberg
- bilan étiologique : échodoppler des troncs supra-aortiques + doppler trans-crânien, ECG, ETT, bilan des facteurs de risque cardiovasculaires
- IRM séquences T1 T2 Flair + ARM
- traitement : USI neurovascular, scope . aspirine ± HNF IV
- . thrombolyse : si prise en charge avant 6 h + absence de contre-indication
- . respect de la TA jusqu'à 20/12 +++
- . équilibre de la glycémie, antipyrétiques si température > 38.5°C
- . soins oculaires si paralysie faciale ++
- . kinésithérapie, orthophonie, nursing
- . endartériectomie carotidienne à distance si sténose > 70%

Thrombose veineuse cérébrale

- hypertension intracrânienne
- crises comitiales
- TDM cérébral + injection de produit de contraste : signe du delta
- étiologie : troubles de la coagulation, post-partum, infection de voisinage (ORL)
- . traitement = HNF IV **Hémorragie méningée**
- céphalée en coup de tonnerre + syndrome méningé
- rupture d'anévrisme ++
- paralysie douloureuse du III : anévrisme de la terminaison carotidienne
- TDM cérébral sans injection en urgence ; si normal : PL
- urgence neurochirurgicale : artériographie ou chirurgie en urgence
- complications : hypertension intracrânienne, hydrocéphalie, spasmes, ischémie, resaignement
- contrôle de la tension +++ < 15/10
- prévention du spasme : nimodipine :

ITEM N°134 Néphropathie vasculaire

- HTA
- sédiment urinaire normal
- sténose de l'artère rénale : . athérome ou fibrodysplasie . hypokaliémie
- . HTA sévère et résistante
- . insuffisance rénale aggravée par les IEC
- . écho-doppler des artères rénales.
- microangiopathie thrombotique : SHU
- néphroangiosclérose maligne (HTA sévère) PBR contre-indiquée
- embolies de cristaux de cholestérol : signes cutanés, fond d'oeil
- périlartérite noueuse : PBR contre-indiquée (anévrismes), rechercher une hépatite B



Nofes :

ITEM N°135 Thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire

- triade de Virchow : stase sanguine + hypercoagulabilité + lésion pariétale
- thrombophilie : mutation des facteurs V ou II, déficit en antithrombine III, déficit en protéine C et S, syndrome des anti-phospholipides
- dans le bilan étiologique : penser à la recherche d'un cancer ++ **Thrombose veineuse profonde**
- diminution du ballonnement passif du mollet ; signe de Homans
- touchers pelviens
- écho-doppler veineux bilatéral : incompressibilité de la veine thrombosée
- recherche systématique d'une EP : ECG, radio de thorax, gaz du sang
- bas de contention ; lever précoce
- HBPM puis AVK pendant 6 à 8 mois
- maladie post-phlébitique **Embolie pulmonaire**
- rechercher des signes de gravité ++
- probabilité clinique : détermine la démarche diagnostique ++
- bilan :
 - . D-DImères: sauf si forte probabilité clinique ++ . écho-doppler veineux des membres inférieurs . gaz du sang : effet shunt . ECG (souvent normal ++)
 - . angioscanner thoracique ou scintigraphie pulmonaire
- traitement :
 - . repos strict au lit
 - . HBPM si EP non grave ; sinon HNF . thrombolyse si état de choc
- complication : coeur pulmonaire chronique
- :

ITEM N°136 Insuffisance veineuse chronique - varices

- insuffisance valvulaire
- maladie post-phlébitique
- signe du flot, épreuve de Trendelenbourg, épreuve des garrots étages
- échodoppler veineux des membres inférieurs
- ulcères veineux
- règles hygiéno-diététiques : activité physique, perte de poids
- bas de contention
- traitement chirurgical : stripping veineux
- :

ITEM N°137 Ulcère de jambe

- SAT VAT
- insuffisance veineuse : ulcère unique, peu douloureux, étendu, sale
- AOMI : ulcère petit, douloureux, bords atones, abolition des pouls périphériques
- traitement local quotidien : nettoyage, détersión, bourgeonnement (pansements gras), épidermisation (hydrocolloïdes)
- antalgiques
- kinésithérapie
- traitement étiologique : contention élastique / revascularisation
- HBPM en préventif si alitement ++
- :



MODULE 10 : CANCEROLOGIE - ONCO-HEMATOLOGIE

ITEM N°138 Cancer : épidémiologie, cancérogénèse, développement tumoral.

classification.

Epidémiologie

- 27% des décès

- par ordre de fréquence : sein > prostate > colorectal > poumon > voies aériennes supérieures

Cancérogénèse, développement tumoral

- initiation, promotion, progression

- activation d'un oncogène modification génétique -> échappement à l'apoptose, perte de l'inhibition de contact, néoangiogénèse, métastases

- dissémination : lymphatique, hématogène, cavitaire **Classification**

- TNM

- scores histo-pronostiques (SBR, Gleason)

- état général (Kamofsky, échelle OMS)

:

ITEM N°139 Facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers Facteurs de risque

- alimentation

- tabac (poumons, reins, vessie, voies aériennes supérieures)

- alcool (œsophage, voies aériennes supérieures, carcinome hépato-cellulaire)

- amiante, poussière de bois (cancers professionnels)

- UV (cutanés)

- virus (VIH, HHV8, EBV, HPV, VHB)

- iatrogènes (chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie)

- génétiques (PAF, HNPCC, VHL, NEM, BRCA1 et 2) **Prévention**

- arrêt tabac, alcool

- information sur l'alimentation, les risques de l'exposition solaire

- prévention professionnelle **Dépistage**

- frottis cervico-vaginal / 3 ans

- toucher rectal, hémocult, coloscopie si risque élevé pour le cancer colorectal

- autopalpation des seins ; mammographie / 2ans entre 50 et 74 ans

- PSA, toucher rectal pour le cancer de la prostate

:

ITEM N°140 Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations paracliniques ; stadification, pronostic Signes d'appel

- altération de l'état général

- envahissement/ compression locorégionale : schéma daté ++

- syndrome paranéoplasique : **SIADH**, acanthosis nigricans, hypercalcémie...

Investigations paracliniques

- diagnostic positif = histologique ++

- marqueurs tumoraux

- bilan d'extension locorégional et à distance

- recherche de cancers épidémiologiquement associés ++

- bilan pré-thérapeutique **Stadification**

- I = limité à l'organe

- II = extension locale

- III = extension locorégionale -IV = métastases **Pronostic**

- lié à la maladie : TNM, marqueurs, anapath

- lié au malade : âge, état général, co-morbidités

- lié au traitement : précocité du diagnostic, résection chirurgicale, réponse au traitement

:



ITEM N°141 Traitement des cancers :

Chirurgie

- curative / palliative
- conservatrice / non conservatrice
- règles carcinologiques (marges saines, exploration, curage ganglionnaire)
- envoi des pièces en anapath ++

Radiothérapie

- curative / palliative
- étalement, dose, fractionnement, champ
- effets secondaires ++
- prévention : remise en état dentaire, gouttières fluorées

Chimiothérapie

- curative / palliative
- adjuvante (diminue la rechute) / néo-adjuvante (diminue la masse tumorale)
- classification :
 - . anti-métabolites : methotrexate, 5-FU . alkylants : cyclophosphamide, cisplatine . poisons du fuseau : vincristine, taxanes . antibiotiques : anthracyclines, bléomycine
- effets secondaires : hématologiques : infections ++, digestifs, alopecie, syndrome de lyse, stérilité...
- prévention : .CECOS
- . bilan pré-thérapeutique
- . hydratation, alcalinisation des urines, protecteur vesical . anti-émétique . bains de bouche
- . facteurs de croissance hématopoïétiques . acide folinique (methotrexate)
- cancers du sein (curative) et de la prostate (palliative)
- agonistes de la LHRH : attention à l'effet flare-up
- blocage périphérique : castration chirurgicale, anti-aromatases
- anti-œstrogènes : tamoxifène : attention au risque de cancer de l'endomètre et de thrombose
- anti-androgènes

La décision thérapeutique multidisciplinaire et l'information du malade

staff multidisciplinaire (réunions de concertation pluridisciplinaire) +++

:

ITEM N°142 Prise en charge et accompagnement d'un malade cancéreux à tous les stades de la maladie

- annonce du diagnostic
- prise en charge multidisciplinaire
- suppression des facteurs de risque (tabac.) **Traitements symptomatiques**
- prise en charge de la douleur
- métastases osseuses : corticothérapie, bisphosphonates, radiothérapie
- renutrition
- soins palliatifs **Modalités de surveillance**
- surveillance à vie
- récurrence / tolérance du traitement / état général / évaluation psychologique et sociale

Problèmes psychologiques, éthiques et sociaux

- prise en charge à 100% ++
- psychothérapie de soutien

:

ITEM N°143 Agranulocytose médicamenteuse : conduite à tenir

- interrogatoire : prise médicamenteuse ; notion d'imputabilité intrinsèque et extrinsèque ++
- PNN < 500 / mm³
- myélogramme
- arrêt de tout traitement non indispensable
- isolement
- bilan infectieux : hémocultures, ECBU, coprocultures, prélèvement de gorge, radio de thorax
- antibiothérapie large spectre IV si fièvre

- facteur de croissance granulocytaire : G-CSF
- déclaration à la pharmacovigilance
- liste des médicaments contre-indiqués
- prévention : pour les chimiothérapies : surveillance de la NFS et de la température ++
- :

ITEM N°144 Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques

- leucémies (45%) > tumeurs cérébrales (20%) > tumeurs abdominales (15%) : néphroblastome et neuroblastome > rétinoblastome **Tumeurs abdominales**
- échographie abdominale ++ : privilégier les examens non irradiants
- néphroblastome :
 - . pas de manipulation ++ (risque de rupture)
 - . URO-TDM (évaluation du rein contralatéral) = médico-légal ++
 - . biopsie contre-indiquée +++
- neuroblastome :
 - . altération de l'état général
 - . métastases : hépatiques, osseuses, pulmonaires
 - . biopsie contre-indiquée ++
 - . scintigraphie au MIBG
 - . biopsie ostéo-médullaire
 - . marqueurs = catecholamines urinaires

Leucémies aiguës

- LAL +++
- attention devant une ostéomyélite chronique, redouter une leucémie
- myélogramme **Tumeurs cérébrales**
- IRM
- médulloblastome
- crâniopharyngiome
- :

ITEM N°145 Tumeurs de la cavité buccale et des voies aéro-digestives supérieures

- facteurs de risque : alcool, tabac : association synergique
- carcinome épidermoïde
- lésions pré-cancéreuses
- adenopathies cervicales
- schéma daté
- signes unilatéraux ++ (otalgie ...)
- pan-endoscopie des voies aéro-digestives supérieures sous anesthésie générale
- bilan pré-radiothérapie : consultation stornato, panoramique dentaire
- RECHERCHER UN CANCER EPIDEMIOLOGIQUEMENT ASSOCIE +++ : FOGD, fibroscopie bronchique
- arrêt du tabac et de l'alcool +++
- orthophonie : rééducation vocale
- renutrition

cancer du cavum

- carcinome indifférencié
- EBV, origine ethnique
- otite séreuse unilatérale
- signes neurologiques et ophtalmologiques (paralysie oculomotrice)
- scintigraphie osseuse systématique
- traitement = radiothérapie

Cancer de l'ethmoïde

- maladie professionnelle : poussière de bois, nickel
- adénocarcinome
- signes neurologiques et ophtalmologiques
- traitement = chirurgie : ethmoïdectomie

Wores :





ITEM N°146 Tumeurs intracrâniennes

- épilepsie
- céphalées : hypertension intracrânienne ; risque d'engagement cérébral : PL contre-indiquée
- IRM cérébrale : rupture de la barrière hémato-encéphalique
- métastases : multiples, œdème périphérique, prise de contraste en cocarde
- méningiomes : isodenses, prise de contraste importante, base d'implantation large
- diagnostic histologique : biopsie stéréotaxique
- angle pontocérébelleux : neurinome du VIII
- :

ITEM N°147 Tumeurs du col utérin

- frottis cervico-vaginal
- si dysplasies, faire une colposcopie + test au lugol et à l'acide acétique + biopsies
- conisation
- virus HPV : koilocytes
- carcinome épidermoïde
- métrorragies provoquées
- examen sous valves sous anesthésie générale : schéma daté
- classification FIGO
- surveillance : frottis du dôme vaginal +++ **Tumeurs du corps utérin**

Cancer de l'endomètre

- adénocarcinome
- hormonodépendant : hyperoestrogénie
- métrorragies post-ménopausiques
- échographie pelvienne : degré d'infiltration du myomètre
- hystéroscopie : curetage biopsique étage
- examen de seins +++, mammographie (même terrain)
- contre-indication du traitement hormonal substitutif à vie +++ **Fibromes utérins**
- facteur hormonal : hyperplasie endométriale
- interstitiel / sous-muqueux / intra-cavitaire / sous-séreux
- complications : ménorragies, compression, torsion, nécrobiose aseptique, infertilité
- si hémorragie : hystéroscopie + curetage biopsique systématique +++
- traitement médical : progestatifs
- traitement chirurgical : myomectomie, hystérectomie totale
- radiologie interventionnelle : embolisation sélective
- :

ITEM N°148 Tumeurs du colon et du rectum

- risque élevé (ATCD personnel, familial, MICI), risque très élevé (PAF, HNPCC)
- syndrome rectal : faux besoins, épreintes, ténésmes
- rectorragie
- toucher rectal
- coloscopie
- cancer du rectum : écho-endoscopie rectale + IRM pelvienne
- chimiothérapie post-op si N +
- cancer du rectum : radiothérapie pré-opératoire si T3 ou N + ; exérèse totale du mésorectum +++
- ACE
- HNPCC : surveillance gynécologique et FOGD
- pour tout polype à la coloscopie : résection endoscopique + anapath
- dépistage familial ++
- :

ITEM N°149 Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques

- rayonnement UV
- lésions pré-cancéreuses : kératose actinique, maladie de Bowen, leucoplasie

- prévention : photoprotection, dépistage et traitement des lésions précancéreuses
- risque de récurrence ++
- carcinome basocellulaire : . polymorphisme . atteinte du visage ; pas d'atteinte muqueuse . perle épithéliomateuse +++ . extension purement locale
- carcinome spinocellulaire : . monomorphe : lésion ulcéro-bourgeonnante et infiltrante . surtout sur lésion pré-cancéreuse . atteinte muqueuse possible . métastases
- mélanome : . phénotype clair, nombre élevé de naevi, . règle ABCDE . excision totale +++ ; pas de biopsie . indice de Breslow ; indice de Clark . auto-surveillance : risque de récurrence

ITEM N°150 Tumeurs de l'estomac

- adénocarcinome
- lymphome de MALT (5%)
- facteur de risque : Helicobacter pylori
- lésions pré-cancéreuses : gastrite, ulcère, maladie de Ménétrier, maladie de Biermer, polypes
- FOGD + biopsies multiples + recherche d'Hp
- écho-endoscopie gastrique
- supplémentation en vitamine B12 après toute gastrectomie

ITEM N°151 Tumeurs du foie, primitives et secondaires Carcinome hépato-cellulaire

- foie cirrhotique
- dépistage : échographie + alpha-foeto-protéine / 6 mois
- décompensation de cirrhose
- TDM : nodule hypodense, hétérogène, prise de contraste au temps artériel
- critères de Barcelone : si réunis : pas de PBH
- traitements : chirurgical, alcoolisation, radiofréquence, embolisation, transplantation hépatique (pour Child Pugh C)

Tumeurs bénignes

- angiome : hyperéchogène, homogène, avec renforcement postérieur
- hyperplasie nodulaire focale ; à l'échographie : zone hyperéchogène centrale
- adénome
- kyste biliaire : anéchogène, renforcement postérieur, pas de prise de contraste au TDM

ITEM N°152 Tumeurs de l'œsophage

- dysphagie organique
- amaigrissement, dénutrition
- fausses routes et pneumopathie d'inhalation : suspecter une fistule cœso-trachéale
- écho-endoscopie œsophagienne
- FOGD + biopsies
- bilan d'opérabilité +++
- arrêt de l'alcool et du tabac ++ **Carcinome épidermoïde (80%)**
- alcool, tabac
- lésions pré-cancéreuses : achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage, œsophagite caustique
- rechercher un cancer épidémiologiquement associé (ORL ou bronchique) +++

Adénocarcinome (20%)

- sur endobrachyœsophage +++ : à surveiller / FOGD + biopsies / 2ans -1/3 inférieur de l'œsophage





ITEM N°153 Tumeurs de l'ovaire Kystes

- fonctionnel / organique
- palpation d'une masse pelvienne séparée de l'utérus par un sillon
- critères échographiques de malignité : plus de 6 cm, parois épaisses, irrégulières, hétérogènes, présence de végétations, de cloisons, de néo-vaisseaux anarchiques
- syndrome de Krukenberg
- si pas de disparition après 3 mois de pilule œstroprogestative ou si aspect malin : coelioscopie + ovariectomie + cytologie péritoneale (patiente prévenue du risque de conversion en laparotomie)

Cancer

- cystadénocarcinome séreux -CA 125
- carcinose péritoneale et ascite
- chirurgie de réduction tumorale maximale
- :

ITEM N°154 Tumeurs des os primitives et secondaires

Primitives

- adulte jeune, adolescent
- radio : ostéolyse mal limitée, rupture corticale, envahissement des parties molles, éperon périoste
- scintigraphie osseuse (skip métastases)
- ostéosarcome : métaphyse des os longs
- sarcome d'Ewing : enfant, diaphyse des os longs, réaction périostée en bulbe d'oignon, biopsie ostéomédullaire

Secondaires

- cancers ostéophiles : poumon, prostate, rein, sein, testicule, neuroblastome
- radio : ostéolyse sans réaction périostée, vertèbre borgne ou ivoire, ostéocondensation en tache de bougie
- localisation : vertèbre > fémur > pelvis
- attention au risque de compression médullaire
- attention au risque d'hypercalcémie
- diagnostic différentiel = myélome
- traitement = corticoïdes, bisphosphonates, radiothérapie, chirurgie
- Wofes .

ITEM N°155 Tumeurs du pancréas Adénocarcinome

- facteurs de risque : tabac, pancratite chronique, hérédité
- ictère + prurit + grosse vésicule -CA 19-9
- glycémie (risque de diabète)
- écho-endoscopie
- preuve histologique systématique avant traitement : ponction guidée par TDM
- bilan d'opérabilité
- chirurgie curative = DPC ; palliative = dérivation biliaire et digestive
- prise en charge de la douleur **Tumeurs endocrines**
- recherche systématique d'une NEM 1
- insulinome : hypoglycémie organique, épreuve de jeûne
- gastrinome : syndrome de Zollinger-Ellison : ulcère gastrique, diarrhée chronique
- scintigraphie des récepteurs de la somatostatine = octréoscan ++
- :

ITEM N°156 Tumeurs de la prostate

- adénocarcinome
- hormonodépendant
- nodule au toucher rectal
- PSA
- diagnostic de certitude : biopsies prostatiques transrectales au cours d'une échographie endorectale

- score de Gleason
- IRM pelvienne : recherche une extension extra-capsulaire
- scintigraphie osseuse
- traitement curatif = chirurgie ou radiothérapie
- iatrogénie : anéjaculation, impuissance, incontinence urinaire
- hormonothérapie
- surveillance : toucher rectal, PSA, créatinine
- :

ITEM N°157 Tumeurs du poumon, primitives et secondaires

- tabac : arrêt total et définitif +++
- exposition professionnelle
- Cancer bronchique non à petites cellules
- carcinome épidermoïde ou adénocarcinome
- syndrome de compression médiastinale : dysphonie, syndrome cave supérieur, dysphagie ...
- syndrome de Pancoast- Tobias : tumeur de l'apex + névralgie cervico-brachiale C8-D1 + Claude Bernard Horner + lyse costale
- radio de thorax : rechercher les signes associés +++ : adenopathies, épanchement, atelectasie, lyse costale...
- TDM thoracique + coupes sur les surrénales ++
- diagnostic histologique : fibroscopie bronchique + biopsies
- attention aux cancers associés : ORL ++ : faire une panendoscopie
- bilan d'opérabilité ++
- bilan respiratoire pré-op : EFR + gaz du sang + scintigraphie pulmonaire de ventilation / perfusion
- place du PETscan
- kinésithérapie respiratoire
- Cancer bronchique à petites cellules
- médiastinal
- 2 stades : localisé/ disséminé
- métastases précoces
- syndrome cave supérieur
- syndrome paranéoplasique (SIADH ++)
- biopsie ostéo-médullaire Mésothéliome pleural malin
- amiante : maladie professionnelle
- pleurésie chronique, hémorragique
- taux d'acide hyaluronique élevé dans le liquide pleural
- plèvre festonnée, mamelonnée
- thoracoscopie + biopsies
- traitement palliatif : symphyse pleurale par talcage
- A/ores :

ITEM N°158 Tumeurs du rein

- hématurie macroscopique
- examen clinique : contact lombaire, varicocèle
- syndrome paranéoplasique : Polyglobulie, hypercalcémie, fièvre
- adénocarcinome
- échographie rénale + TDM abdominal : étude du rein contralatéral +++
- pas de preuve histologique nécessaire : pas de biopsie
- traitement = néphrectomie élargie emportant la graisse péri-rénale jusqu'au fascia de Gérota
- :

ITEM N°159 Tumeurs du sein

- adénocarcinome canalaire infiltrant
- cancer hormonodépendant
- dépistage : autopalpation, mammographie
- facteurs de risque : hyperostrogénie, ATCD personnels et familiaux



- examen clinique : bilatéral et comparatif, examen des aires ganglionnaires
- classification ACR (mammographique) -CA 15-3
- scintigraphie osseuse
- classification PEV (inflammation)
- grade histopronostique SBR
- traitement chirurgical : tumorectomie si taille < 3 cm ; sinon, mastectomie
- hormonothérapie si récepteurs hormonaux positifs : anti-œstrogènes (tamoxifène)
- contre-indication au traitement hormonal substitutif et à la pilule
- kinésithérapie mobilisatrice du membre supérieur et éducation après curage ganglionnaire

ITEM N°160 Tumeurs du testicule

Diagnostic :

- homme jeune
- facteur de risque : cryptorchidie
- gynécomastie
- signe de Chevasu : conservation du sillon épидидymo-testiculaire
- examen bilatéral et comparatif +++
- échodoppler testiculaire Mesures pré-opératoires :
- marqueurs sériques : alfaFP, Béta HCG, LDH -CECOS
- consentement écrit +++
- traitement chirurgical : orchidectomie par voie inguinale avec ligature 1ère du cordon
- anapath : tumeurs germinales les plus fréquentes Traitements adjuvants :
- chimiothérapie systématique
- radiothérapie si séminome Surveillance :
- autopalpation +++
- surveillance du testicule controlatéral +++
- marqueurs sériques

ITEM N°160 bis Tumeurs vesicales

- carcinome à cellules transitionnelles
- facteurs de risques : tabac, exposition professionnelle, bilharziose urinaire
- touchers pelviens
- hématurie macroscopique terminale avec caillots
- cytologie urinaire
- cystoscopie + résection endoscopique : examen anatomopathologique
- uroscanner systématique : recherche une tumeur du haut appareil associée
- instillations endovésicales (BCGthérapie) pour les tumeurs superficielles
- tumeurs infiltrantes : cystectomie radicale + dérivation des urines

ITEM N°161 Dysmyélopoïèse

- myélogramme : moelle riche ; anomalies morphologiques ; blastes < 20%
- anémie réfractaire sans excès de blastes
- anémie réfractaire avec excès de blastes
- anémie sidéroblastique idiopathique acquise : coloration de Perls : sidéroblastes
- leucémie myélomonocytaire chronique
- complications :
- acutisation
- hémochromatose transfusionnelle
- traitement symptomatique : transfusions, chélateurs du fer
- surveillance : NFS, bilan hépatique, ferritinémie





ITEM N°162 Leucémies aiguës

- insuffisance médullaire
- syndrome tumoral
- NFS-frottis : blastes circulants
- myélogramme : blastes > 20% + caryotype + immunohistochimie
- complications : syndrome de lyse, CIVD, syndrome de leucostase
- PL dans la LAL
- traitement : chimiothérapie : induction, consolidation + greffe, entretien
- séquelles : retard de croissance, stérilité, insuffisance cardiaque, cancers radio-induits

LAM

- adulte
- myélogramme : corps d'Auer, peroxydases positives **LAL**
- enfants ++
- atteinte du système nerveux central, testicules, os, atteinte médiastinale
- :

ITEM N°163 Leucémies lymphoïdes chroniques

- fréquent
- asymptomatique
- syndrome tumoral : adenopathies, splénomégalie
- NFS : hyperlymphocytose ; petits lymphocytes normaux
- pas de myélogramme
- immunophénotypage lymphocytaire : clonalité B
- EPP : hypogammaglobulinémie ± pic monoclonal IgM : risque d'infections +++
- manifestations auto-immunes : test de Coombs
- classification de Binet
- syndrome de Richter : transformation en lymphome de haut grade de malignité -> biopsie
- :

ITEM N°164 Lymphomes malins

- syndrome tumoral : adénopathies, atteinte médiastinale, **ORL...**
- altération de l'état général, fièvre, sueurs nocturnes, prurit
- urgences : syndrome cave supérieur, compression médullaire
- diagnostic histologique : biopsie +++
- bilan d'extension : examen **ORL**, TDM thoraco-abdominal, échographie abdominale, biopsie ostéo-médullaire, **PL**
- bilan pré-thérapeutique : VIH, échographie cardiaque, **CECOS**
- classification d'Ann-Arbor
- traitement : chimiothérapie- radiothérapie
- maladie de Hodgkin Wofes :

ITEM N°165 Maladie de Vaquez

- Polyglobulie : définition : augmentation de la masse globulaire totale > 120% de la théorique
- signes neurosensoriels
- érythrose cutanée
- prurit à l'eau
- **Splénomégalie**
- hyperuricémie
- complications thrombotiques et hémorragiques
- éliminer une Polyglobulie secondaire +++ : échographie abdominale, gaz du sang
- traitement = saignées
- risque d'acutisation

Autres syndromes myéloprolifératifs Leucémie myéloïde chronique

- caryotype : chromosome Philadelphie
- pas de myélogramme systématique
- biologie moléculaire : transcrit Bcr-abl

- hyperleucocytose
- **Splenomegalie**
- myélémie
- acutisation systématique +++ (LAM) **Splenomegalie myéloïde**
- métaplasie myéloïde de la rate : Splenomegalie
- biopsie ostéo-médullaire : myélofibrose primitive
- myélémie (érythroblastes), dacryocytes
- pas de chromosome Philadelphie
- :

ITEM N°166 Myelome multiple des os

- élévation de la VS
- douleurs osseuses, radiculalgies
- EPP, IEP : immunoglobuline monoclonale, IgG
- Proteinurie des 24h, immunoélectrophorèse des protéines urinaires
- myélogramme : plasmocytose médullaire > 10%, caryotype
- radio du squelette : géodes à l'emporte pièce, déminéralisation
- formes cliniques : absence de pic, hypogammaglobulinémie : myélome à chaînes légères, non excréteur, non sécrétant
- POEMS syndrome
- complications : insuffisance médullaire, infections, hypercalcémie, compression médullaire, insuffisance rénale, amylose AL
- 3 causes de syndrome néphrotique : amylose AL, maladie de Randall, cryoglobuline
- contre-indication des produits de contraste iodés +++
- classification de Salmon et Durie en 3 stades
- facteurs pronostiques : CRP, bêta-2-microglobuline
- :

MODULE 11 : SYNTHÈSE CLINIQUE ET THÉRAPEUTIQUE. DE LA PLAINTÉ DU PATIENT À LA DÉCISION THÉRAPEUTIQUE. URGENCES_

Thérapeutique générale

ITEM N°167 Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Cadre réglementaire de la prescription thérapeutique et recommandations.

- évaluer le rapport bénéfices/ risques
- respecter les RMO
- AMM délivrée par l'AFSSAPS
- médicament générique : même composition quantitative et qualitative en principe actif, même forme pharmaceutique, bioéquivalence ; principe de substitution
- stupéfiants : prescription sur ordonnance sécurisée, en toutes lettres; durée limitée : 7 à 28 jours
- :

ITEM N°168 Effet placebo et médicaments placebo

- substance inerte, dépourvue d'activité pharmacologique
- suscite les effets psychologiques accompagnant la médication
- effet nocebo : effets indésirables
- utilisation dans les essais thérapeutiques en phase III
- leur utilisation doit rester éthique (pas pour les maladies graves par exemple)
- :



ITEM N°169 L'évaluation thérapeutique et les niveaux de preuve

- niveau 1 : essais comparatifs randomisés de forte puissance ; méta-analyses d'essais comparatifs randomisés
- niveau 2 : essais comparatifs randomisés de faible puissance ; études comparatives non randomisées bien menées ; études de cohorte
- niveau 3 : études cas-témoins
- niveau 4 : biais importants, études rétrospectives, séries de cas
- méta-analyse = synthèse de plusieurs essais thérapeutiques traitant du même sujet

ITEM N°170 La décision thérapeutique personnalisée. Observance médicamenteuse.

- adaptée au patient selon : le terrain, le rapport bénéfices/ risques...
- risques de la non-observance : résistances, traitement insuffisant, effets secondaires
- facteurs de risque de mauvaise observance : précarité, troubles psychiatriques, mauvaise information, maladie chronique, maladie asymptomatique, traitement avec effets secondaires contraignants
- amélioration de l'observance : éducation, information, surveillance, formes galéniques simples, cahier d'observance

ITEM N°171 Recherche d'un terrain à risque et adaptation thérapeutique.

- bilan pré-thérapeutique -terrains à risque :
 - . insuffisance rénale : calcul de la clearance, adaptation des doses . insuffisance hépatique : attention
 - . risque d'encéphalopathie hépatique avec les psychotropes . allergie
 - . femme enceinte : risque tératogène
 - . sujet âgé : polymédication
 - . enfant : adapter les doses au poids

Interactions médicamenteuses

- cytochrome p450
- inducteurs enzymatiques : rifampicine, anticonvulsivants (carbamazépine, barbituriques, phénytoïne)
- déclaration à la pharmacovigilance

ITEM N°172 Automédication

- risques :
 - . retard au diagnostic
 - . traitement inefficace
 - . intoxication, surdosage
 - . interactions médicamenteuses
 - . allergies
- éducation et information : rôles du médecin et du pharmacien

ITEM N°173 Prescription et surveillance des antibiotiques

- débutée après les prélèvements bactériologiques
- bêta-lactamines : pénicilline + céphalosporines ; inhibent la synthèse de la paroi bactérienne
- cyclines : actives sur les germes intracellulaires ; effet secondaire principal = photosensibilisation
- aminosides : effets secondaires : toxicité rénale et cochléo-vestibulaire ; contre-indiqués dans la myasthénie
- macrolides : attention aux interactions médicamenteuses
- fluoroquinolones : risque de photosensibilisation, de tendinopathie et d'allongement du QT
- glycopeptides : effets secondaires : néphrotoxicité, ototoxicité ; surveillance de la concentration résiduelle
- antituberculeux :



- . rifampicine : interactions médicamenteuses (inducteur enzymatique), coloration orangée des urines .
- isoniazide : hépatotoxicité, neurotoxicité . éthambutol : NORB
- . pyrazinamide : hépatotoxicité, hyperuricémie
- antibiotiques contre-indiqués pendant la grossesse : cyclines, quinolones, sulfamides, aminosides
- intérêt de l'association d'antibiotiques : synergie, élargissement du spectre, éviter l'émergence de mutants résistants
- :

ITEM N°174 Prescription et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et

Non stéroïdiens

Corticoïdes

- surveillance clinique : tension, température (risque infectieux), poids
- surveillance paraclinique : glycémie, ionogramme (K +), calcémie, ostéodensitométrie
- mesures associées :
 - . règles hygiéno-diététiques (régime sans sel) . supplémentation en calcium, vitamine D ± bisphosphonates . éducation : pas d'arrêt brutal, information sur le risque d'insuffisance surrénale aiguë
 - . test au synacthène avant l'arrêt . ivermectine chez les africains
- contre-indications : infection non contrôlée, ulcère gastrique, diabète déséquilibré

AINS

- inhibiteurs des cox 1 et 2
- contre-indications : ulcère gastrique, grossesse, insuffisance rénale, Infection non contrôlée
- interactions médicamenteuses : AVK, sulfamides hypoglycémiantes
- association à un IPP si ATCD d'ulcère ou âge > 65 ans **Aspirine**
- inhibiteur de la cox 1
- antiagrégant plaquettaire pour les doses comprises entre 75 et 350 mg/j
- attention au syndrome de Reye (dans la varicelle)
- durée d'action = 7j : arrêt 7j avant la chirurgie
- :

ITEM N°175 Prescription et surveillance d'un traitement anti-thrombotique

Antiagrégants plaquettaires

- aspirine
- clopidogrel : Plavix ; dose de charge systématique = 4 à 8 cp ; durée d'action = 7 j
- anti-GpIIb/IIIa : Reopro®, Intégrilin® ; mêmes contre-indications que la thrombolyse

Anticoagulants

- Héparines :
 - . HNF : TCA à H6
 - . HBPM : attention : contre-indiquées si insuffisance rénale +++ . en préventif : HBPM : risque modéré -> 0.2 ml ; risque élevé -> 0.4 ml . en curatif : HBPM : Lovenox® : 100 UI/kg x 2 /jour ou 0,1 mL/kg x 2/jour
 - . bilan pré-thérapeutique : NFS, plaquettes, TP, TCA, créatinine . surveillance : NFS, plaquettes 2 fois / semaine
- AVK :
 - . relais dès J1 ; arrêt de l'héparine dès le 2^e INR efficace
 - . interactions médicamenteuses ++
 - . contre-indication pendant la grossesse
 - . carte AVK
 - . carnet AVK
 - . INR/mois
 - . éducation +++
- Thrombolytiques :
 - . toujours associés à une héparinothérapie
 - . contre-indications : hémorragie cérébro-méningée, ulcère gastrique, AVC de moins de 6 mois, traumatisme crânien, trouble de l'hémostase, dissection aortique, HTA non contrôlée
 - :



ITEM N°176 Prescription et surveillance des diurétiques

- contre-indications pour tous les diurétiques : déshydratation, grossesse, troubles hydro-électrolytiques, encéphalopathie hépatique, obstacle sur les voies urinaires
- diurétiques de l'anse : contre-indiqués si allergie aux sulfamides
- spironolactone : contre-indiqués si insuffisance rénale ou hyperkaliémie
- surveillance du ionogramme sanguin et de la créatinine
- :

ITEM N°177 Prescription et surveillance des psychotropes Antidépresseurs

- indications : syndrome dépressif, troubles anxieux, TOC, algies chroniques
- attention à la levée de l'inhibition
- antidépresseurs tricycliques :
 - . effets secondaires anticholinergiques . attention aux contre-indications . surveillance de l'ECG
- inhibiteurs de recapture de la sérotonine : 1RS . moins d'effets secondaires
- . attention au syndrome sérotoninergique **Lithium**
- traitement de l'accès maniaque et de la maladie bipolaire
- contre-indications : insuffisance rénale, régime désodé, cardiopathies
- bilan pré-thérapeutique : ionogramme, créatinine, ECG, TSH, p HCG
- contraception
- surveillance de la lithiémie **Anxiolytiques**
- indications : troubles anxieux, sevrages
- contre-indications : myasthénie, insuffisance respiratoire, grossesse, insuffisance hépatique
- prescription pour une durée limitée
- attention au risque de toxicomanie
- benzodiazepines, carbamates, anti-histaminiques, hypnotiques
- syndrome de sevrage : prévenu par une diminution progressive des doses

Neuroleptiques

- traitement des psychoses
- effets secondaires : dystonies, dyskinésie, syndrome parkinsonien, allongement du QT
- syndrome malin des neuroleptiques
- bilan pré-thérapeutique systématique : NFS, bilan hépatique, ECG
- attention aux neuroleptiques cachés (Pimpéran®) :

ITEM N°178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. Hémovigilance

- information et accord du patient
- bilan pré-transfusionnel : groupe ABO, rhésus, RAI
- 2 épreuves de compatibilité globulaire
- épreuve ultime au lit du patient : Beth-Vincent
- transfusion sous surveillance médicale
- dossier transfusionnel
- 1 culot globulaire augmente le taux d'hémoglobine d'1 g/dl
- culots plaquettaires : 1 unité /10 kg
- plasma : pour les hémorragies aiguës ou les CIVD
- accidents transfusionnels : hémolyse aiguë par incompatibilité ABO, choc endotoxique +++
- déclaration de tout incident transfusionnel à l'hémovigilance
- traça bilité
- Wofes :

ITEM N°179 Prescription d'un régime diététique

- éducation du patient
- adapté : enquête alimentaire
- définir un objectif pondéral
- équilibré = 50% de glucides ; 30% de lipides ; 20% de protides
- activité physique régulière

- soutien psychologique
- exemples :
 - . athérome : hypocholestérolémiant
 - . diabète : éviter les sucres d'index glycémique élevés
 - . HTA : restriction sodée, pas d'alcool
 - . corticothérapie : hyperprotidique, hypoglucidique, restriction sodée, augmenter les apports en potassium
 - . insuffisance rénale chronique : restriction sodée, restriction protidique, restriction potassique
- Wofes ;

ITEM N°180 Prescription d'une cure thermale

- crénothérapie
- prescription médicale
- adressée à la CPAM
- prise en charge à 65% par la sécurité sociale
- durée = 3 semaines
- contre-indications : infections, immunodépression, néoplasie, dermatoses sévères, pathologie cardio-vasculaire décompensée, rhumatismes inflammatoires en poussée
- :

ITEM N°181 Iatrogénie. Diagnostic et prévention

- effets indésirables des médicaments : . toxique
- . immuno-allergique . pharmacodynamique . idio-syncrasique
- imputabilité extrinsèque / intrinsèque : critères sémiologiques et chronologiques
- déclaration à la pharmacovigilance
- :
- :

Situations cliniques fréquentes et urgentes

ITEM N°182 Accidents des anticoagulants

Héparines

- hémorragies :
 - . contrôle du TCA . arrêt de l'héparine
 - . si surdosage : antagoniste = protamine 1 mg /100 UI d'HNF
- thrombopénie induite par l'héparine :
 - . affirmer la thrombopénie sur tube citrate
 - . anticorps anti-F4p
 - . danaparoïde sodique : Orgaran®
 - . déclaration à la pharmacovigilance
 - . contre-indication aux héparines à vie +++
 - . prévention : préférer les HBPM, relais précoce par AVK, surveillance des plaquettes 2 fois par semaine **AVK**
- hémorragies :
 - . facteur de risque = interactions médicamenteuses . dosage de l'INR
 - . selon l'importance de l'hémorragie : arrêt ou diminution des AVK, vitamine K, PPSB
- :

ITEM N°183 Accueil d'un sujet victime de violences sexuelles

- rassurer et préparer aux examens
- examen clinique, gynécologique et proctologique
- prélèvement vaginal
- recherche de MST
- pHCG
- certificat médical descriptif
- psychothérapie de soutien



- signalement au Procureur de la République obligatoire si sujet mineur ; avec accord de la victime si sujet majeur

ITEM N°184 Agitation et délires aigus

- urgence médicale
- attention à l'organicité
- éviter les contentions manuelles si possibles
- si refus de traitement : voie IM : neuroleptiques (Largactil®), Tranxène® si anxiété, Loxapac¹⁸ si agressivité
- surveillance de la TA **Bouffée délirante aiguë**
- fluctuation thymique
- polymorphisme des thèmes et des mécanismes du délire
- pas de syndrome confusionnel
- début brutal
- attention au risque suicidaire
- évolutions possibles : épisode unique, récurrences, maladie maniacodépressive, schizophrénie
- :

ITEM N°185 Arrêt cardio-circulatoire

- diagnostic clinique : abolition des pouls ++
- appeler le 15
- noter l'heure de l'arrêt
- gestes élémentaires de survie : ABCD : libération des voies aériennes, assistance respiratoire, massage cardiaque externe, + défibrillation
- en milieu hospitalier :
 - . scope, WP, intubation + ventilation mécanique . si asystolie : adrénaline IV 1 mg /1 mg . si fibrillation ventriculaire : choc électrique externe ; si échec : séquences CEE / adrénaline
 - . si BAV III : atropine. Si échec : isoprénaline puis sonde d'entraînement électro-systolique
- traitement étiologique : coronarographie systématique (en l'absence de cause évidente)
- protection neurologique : hypothermie thérapeutique
- si pas de cause retrouvée et récupération : indication de pose d'un défibrillateur automatique implantable (DAI)
- :

ITEM N°186 Asthénie et fatigabilité

- bilan de première intention : NFS, CRP, VS, fer, ferritine, glycémie, créatinine, BU, transaminases, TSH
- qualité du sommeil
- penser aux étiologies psychiatriques : dépression, troubles anxieux
- myasthénie : fatigabilité +++
- causes endocriniennes et métaboliques : hypothyroïdie, hypercalcémie, insuffisance rénale
- cancers
- hépatites chroniques
- anémie
- Wofes :

ITEM N°187 Anomalie de la vision d'apparition brutale Œil rouge et douloureux : Cf.

ITEM 212 Œil blanc et indolore

- NORB:
 - . scotome central
 - . signe de Marcus Gunn
 - . fond d'oeil normal
 - . IRM orbitaire (SEP)
- NOIAA :
 - . diminution du réflexe photomoteur direct



- . champ visuel : déficit altitudinal
- . œdème papillaire au fond d'œil
- . VS : rechercher une maladie de Horton ++
- OACR:
 - . baisse de l'acuité visuelle brutale, isolée . mydriase aréflexique
 - . fond d'œil : œdème rétinien, macula rouge cerise, rétrécissement artériel
 - . angiographie à la fluorescéine
 - . VS : rechercher une maladie de Horton
 - . bilan cardio-vasculaire
- OVCR:
 - . facteurs de risque cardio-vasculaires, hypertension oculaire . fond d'œil : hémorragies, œdème rétinien, nodules cotonneux . angiographie : différencie la forme ischémique de la forme œdémateuse
 - . complications : néovaisseaux, œdème maculaire cystoïde
 - . traitement = photocoagulation pan rétinienne dans la forme ischémique - Décollement de rétine : . rhéomatogène ou fractionnel . facteur de risque : myopie . myodésopsies, phosphènes . fond d'œil à 3 miroir BILATERAL ++ . traitement chirurgical : rétinopexie :

ITEM N°188 Céphalées aiguës et chroniques

- urgences :
 - . neurologiques : hypertension intracrânienne, syndromes méningés (méningite et hémorragie méningée), AVC, dissection carotidienne . glaucome aigu par fermeture de l'angle . maladie de Horton . encéphalopathie hypertensive
- TDM cérébral sans injection
- céphalées chroniques : penser à l'intoxication au CO :

ITEM N°189 Conduite suicidaire chez l'adolescent et l'adulte

- inventaire à l'entrée
- après une tentative de suicide :
 - . avis psychiatrique systématique
 - . hospitalisation 24 h
 - . surveillance du risque de récurrence
 - . psychothérapie de soutien
 - . évaluation de l'entourage
 - . suivi au long cours
- :

ITEM N°190 Convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant

- convulsions + fièvre = méningite = PL en urgence ++ (pas de TDM avant chez le moins de 1 an)
- crise convulsive hyperthermique = diagnostic d'élimination
- bilan métabolique systématique : ionogramme, créatinine, glycémie, calcémie
- EEG + imagerie cérébrale sauf pour les crises convulsives hyperthermiques simples
- attention à l'hématome sous-dural (contexte de maltraitance ++) : augmentation du PC
- méningo-encéphalite herpétique : crise partielle brachio-céphalique
- crise convulsive hyperthermique complexe si : moins de 9 mois, durée supérieure à 20 minutes, crise partielle ou déficit post-critique
- traitement de la crise : diazépam 10 mg intra-rectal + antipyrétique
- risque de récurrence : INFORMATION ET EDUCATION DES PARENTS A/ores :

ITEM N°191 Crise d'angoisse aiguë et attaque de panique

- éliminer une cause organique
- si répétition des attaques de panique = trouble panique
- 3 types de symptômes : psychiques, comportementaux, somatiques
- traitement :
 - . isoler, rassurer



. anxiolytique : benzodiazepine PO ou IM . retour à domicile + suivi ultérieur
Afofes :

ITEM N°192 Déficit neurologique récent

- GLYCEMIE +++
- central et transitoire = AIT
- central persistant = AVC ischémique constitué ou AVC hémorragique -> TDM ou IRM cérébrale en urgence
- médullaire -> IRM médullaire en urgence
- :

ITEM N°193 Détresse respiratoire aiguë du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte Nourrisson

- fréquence respiratoire normale = 30 à 50 / minute
- score de Silverman : grave si > 4
- maladie des membranes hyalines
- rechercher systématiquement un syndrome de pénétration +++ **Enfant**
- rechercher un syndrome de pénétration
- épiglottite :
 - . dyspnée laryngée + fièvre + stase salivaire . Haemophilus influenzae ; absence de vaccination . NE PAS ALLONGER. NE PAS EXAMINER LA GORGE. APPEL DU SMUR PEDIATRIQUE
 - . intubation assise + antibiothérapie (C3G) + corticothérapie en urgence . prélèvements bactériologiques une fois l'hémodynamique stable ++
- laryngite sous-glottique :
 - . dyspnée inspiratoire nocturne + cornage . virale
 - . traitement = à domicile : corticoïdes IM + humidification de l'atmosphère + surveillance 30 minutes minimum . si échec : hospitalisation : aérosols d'adrénaline . puis corticothérapie + antibiothérapie (Augmentin®) pendant 5 jours . si enfant de moins de 6 mois : endoscopie systématique **Adulte**
- signes de gravité : respiratoires, hémodynamiques, neurologiques
- examens systématiques : radiographie de thorax + ECG + gaz du sang
- mesure du DEP -SDRA =
 - . hypoxémie réfractaire : $PaO_2 / FIO_2 < 200$
 - . opacités radiologiques alvéolaires bilatérales
 - . PAPO < 18 mmHg (pas d'insuffisance ventriculaire gauche)
 - . traitement = ventilation mécanique en pression expiratoire positive

Corps étranger des voies aériennes supérieures

- syndrome de pénétration
- âge > 9 mois (pince pouce-index)
- manœuvre de Heimlich pour les asphyxies aiguës seulement
- radiographie de thorax en inspiration + expiration
- diagnostic tardif = symptômes respiratoires à répétition (infections ++)
- endoscopie systématique : fibroscopie bronchique
- corticothérapie + antibiothérapie pendant 1 semaine
- EDUCATION DES PARENTS +++ :

ITEM N°194 Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte Cf.

ITEM 302 pour l'adulte

- urgence = évaluation hémodynamique : temps de recoloration cutanée
- POIDS ++
- déshydratation : pli cutané, dépression de la fontanelle
- rechercher un foyer infectieux (otoscopie ...)
- gastro-entérite aiguë ++ (le plus fréquent) : Rotavirus ; épidémies hivernales
- complications = thrombose des veines rénales, hématome sous-dural
- traitement = REHYDRATATION +++
 - . perte de poids < 10% : soluté de réhydratation orale . perte de poids > 10% : réhydratation IV 150 ml/kg/j . choc : sérum physiologique 20 ml/kg en 20 minutes



- réalimentation 6 h après réhydratation ; chez le moins de 3 mois : hydrolysate de protéines de lait de vache
- surveillance : poids, diurèse, pouls, tension, PC ++, courbe de poids :

ITEM N°195 Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte

Enfant

- appendicite
- infection (pneumopathie de la base, otite moyenne aiguë)
- purpura rhumatoïde
- acidocétose diabétique
- torsion testiculaire
- réflexes : orifices herniaires + toucher rectal + examen des OGE +++
- bilan : échographie abdominale + ASP + radiographie de thorax
- si syndrome occlusif-» invagination intestinale aiguë +++ . toucher rectal
- . échographie abdominale : image en sandwich ou en cocarde
- . lavement opaque chez un enfant en bon état hémodynamique +++

Adulte

- ECG : attention à l'IDM
- contracture abdominale = péritonite = traitement chirurgical en urgence
- femme jeune GEU
- sujet âgé : penser à l'infarctus mésentérique ++
- tableau non spécifique avec symptômes multiples : penser à l'insuffisance surrénale aiguë
- chez l'alcoolique : 2 diagnostics : pancréatite aiguë ou hépatite aiguë alcoolique
- attention à la rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale (instabilité hémodynamique)

ITEM N°196 Douleur abdominale aiguë chez une femme enceinte

- en début de grossesse : 1 réflexe = GEU
- au 3^e trimestre : hématome rétro-péritonéal
- pré-éclampsie sévère
- nécrobiose aseptique d'un fibrome utérin
- colique néphrétique
- torsion d'annexé : coelioscopie dans les 6 heures
- bilan = rythme cardiaque fœtal + échographie obstétricale + échographie du col + ECBU
- :

ITEM N°197 Douleur thoracique aiguë et chronique

- constrictive = coronarienne
- positionnelle = séreuse : pleurale ou péricardique
- circonstances (effort)
- migratrice-»dissection aortique : TA aux 2 bras +++
- penser à l'embolie pulmonaire
- 3 contre-indications aux anticoagulants : dissection aortique ; péricardite ; endocardite
- bilan systématique : gaz du sang + troponine + ECG + radiographie de thorax ± D-Dimères
- :
- :

ITEM N°198 Dyspnée aiguë et chronique

- signes de gravité : respiratoires, hémodynamiques, neurologiques
- penser à mesurer le DEP (peak flow) à l'examen clinique
- dyspnée inspiratoire = laryngée : corps étranger, épiglottite, oedème de Quincke
- dyspnée expiratoire, sibilants = BPCO, asthme ± OAP
- crépitants = OAP, Pneumopathie infectieuse, SDRA
- asymétrie à l'auscultation = pneumothorax, pleurésie, atélectasie
- si pas d'orientation : penser à l'embolie pulmonaire
- insuffisance ventriculaire droite ->tamponnade



- bilan = NFS, ionogramme, glycémie, gaz du sang, ECG, radiographie de thorax
- dyspnée chronique -> NYHA 4 stades
- Wofes :

ITEM N°199 Etat confusionnel et trouble de conscience

- urgence thérapeutique
- GLYCEMIE
- désorientation temporo-spatiale
- fluctuation des symptômes
- inversion du rythme nyctéméral
- perplexité anxieuse = spécifique
- délire onirique, hallucinations visuelles
- troubles somatiques : déshydratation, insomnie
- sujet âgé : TR : fécalome, globe vésical
- causes médicamenteuses : toxiques, sevrage, alcool, CO
- interrogatoire de l'entourage
- TDM cérébral systématique ++
- traitement : hospitalisation au calme, pièce éclairée, éviter les contentions physiques, prévention des chutes
- réhydratation +++
- penser à arrêter les médicaments confusogènes
- :

ITEM N°200 Etat de choc

- risque de défaillance multiviscérale : créatinine
- gaz du sang ; lactates
- équilibrer la glycémie **Cardiogénique**
- OAP : traiter par diurétiques ± dobutamine ; pas de sérum physiologique ++ : G5% ++
- penser à arrêter les médicaments inotropes négatifs, les bêtabloquants +++
- pas de remplissage vasculaire sauf si insuffisance ventriculaire droite
- coronarographie systématique +++
- penser à la VNI **Septique**
- PAS < 9 mmHg après remplissage
- BGN le plus souvent
- traiter la porte d'entrée +++
- remplissage vasculaire systématique ++ : colloïdes
- test au synathène **Hypovolémique**
- Groupe rhésus RAI
- touchers pelviens +++
- transfusion de CG si hémorragie **Anaphylactique**
- éviction de l'allergène +++
- adrénaline 1 mg
- corticoïdes :

ITEM N°201 Evaluation de la gravité et recherche des complications précoces Chez un brûlé

- ASEPSIE +++
- surface corporelle lésée : règle des 9 de Wallace ; grave si > 20% chez l'adulte
- USB = % de surface totale brûlée + 3 x (surface brûlée au 3^e degré) : grave si > 100
- risque vital : face, voies aériennes supérieures, périnée, circulaire des membres
- complications : troubles hydro-electrolytiques, dénutrition, infection, intoxication au CO
- WP en peau saine
- dans le bilan, penser à : HbCO, CPK Mb, ECG, protidémie
- ANTALGIQUES++
- SAT VAT ++++

Chez un polytraumatisé

- plusieurs traumatismes dont un au moins met en jeu le pronostic vital



- respecter l'axe tête-cou-tronc ++++
- en 1^{er} : éliminer une urgence hémodynamique, respiratoire ou neurologique ; puis bilan lésionnel complet
- bilan :
 - . patient instable : radiographie de thorax + échographie abdominale + radiographie du bassin .
 - patient stabilisable : TDM corps entier
 - . patient stable : idem + rachis cervical et dorso-lombaire, ± autres
- attention : pas de sonde urinaire si traumatisme pelvien **Chez un traumatisé du rachis**
- . examen neurologique et du périnée +++ . penser au cliché du rachis cervical de face bouche ouverte . entorse grave = lésion du ligament commun vertébral postérieur : à la radio : spondylolisthésis > 3 mm
- . lésions instables : risque de déplacement secondaire ++ **Chez un traumatisé abdominal**
- si plaie : exploration systématique au bloc ; si péritoine ouvert -> laparotomie
- BU +++ : recherche une hématurie
- atteinte splénique : hématome sous-capsulaire, choc hémorragique par rupture -> splénectomie + vaccination anti-pneumococcique + antibiothérapie
- rupture d'organes creux->pneumopéritoine ; péritonite **Chez un traumatisé crânio-facial**
- traumatisme crânien
 - . rechercher une perte de connaissance initiale
 - . examen neurologique : Glasgow, oculomotricité, signes d'engagement
 - . respect de l'axe tête cou +++
 - . TDM cérébral sans injection
 - . hématome extra-dural : intervalle libre ++
 - . brèches ostéo-durales : rhinorrhée, otorrhée^ antibiothérapie
 - . paralysie faciale + otorrhée + surdité = fracture du rocher
 - . ACSOS (agression cérébrale secondaire d'origine systémique)
- traumatisme facial
 - . diplopie : incarceration d'un muscle oculomoteur ++ : fracture du plancher de l'orbite . epistaxis->sonde à ballonnets ++ (pas de méchage car risque infectieux)
 - . fracture de la mandibule : trouble de l'articulé dentaire
- traumatisme oculaire
 - . attention au corps étranger intra-oculaire ++ . si suspicion de corps étranger, contre-indication du tonomètre à aplation, de l'IRM, et du verre à 3 miroirs
- radiographie, échographie, TDM orbitaires **Chez un traumatisé des membres**
- mécanisme lésionnel
- main dominante
- heure du dernier repas
- complications :
 - . immédiates : cutanées, vasculaires, nerveuses, syndrome des loges . secondaires : déplacement secondaire, infection, syndrome des loges . tardives : pseudarthrose septique ou aseptique, cal vicieux, arthrose, ostéite chronique, algodystrophie
- traitement fonctionnel / orthopédique / chirurgical : réduction-contention- immobilisation
- HBPM si atteinte des membres inférieurs
- REEDUCATION +++
- contrôle radiologique
- Chez un traumatisé thoracique**
- pas de parallélisme entre les lésions pariétales et les lésions endothoraciques
- fractures costales : attention aux lésions spléniques
- volet costal : respiration paradoxale
- fracture du sternum : attention à la rupture de l'isthme de l'aorte et la contusion du myocarde
- emphysème sous-cutané cervical -> rupture trachéo-bronchique : faire fibroscopie bronchique
- troponine, CPK
- hémoptysie massive -> intubation sélective
- pneumothorax, hémithorax **Devant une plaie des parties molles Plaies de la main**
- main dominante, profession
- plaie en regard d'une articulation = plaie articulaire -> antibiothérapie +++
- lésions nerveuses : test de Weber, test de la motricité
- radiographie de la main et du poignet
- urgence thérapeutique : pronostic fonctionnel



- exploration chirurgicale au bloc sous anesthésie générale et sous garrot pneumatique
- immobilisation après réparation nerveuse, tendineuse, vasculaire
- SAT VAT
- :

ITEM N°202 Exposition accidentelle aux liquides biologiques. Conduite à tenir

Pour un AES :

- arrêt du geste en cours
- nettoyage à l'eau et au savon, rinçage
- désinfecter pendant 10 minutes au Dakin
- évaluer le risque : interrogatoire, statut sérologique du patient source, type de blessure
- traitement anti-rétroviral si risque suffisant et si accident datant de moins de 48 h
- contacter le médecin référent
- accident de travail
- suivi sérologique : VIH, VHB, VHC
- si pas de vaccination contre l'hépatite B : sérovaccination précoce + 1^e injection vaccinale
- VHC : pas de traitement prophylactique
- rapports sexuels protégés et pas de don du sang pendant 1 mois +++
- :

ITEM N°203 Fièvre aiguë chez l'enfant et chez l'adulte

- urgences : troubles hémodynamiques, détresse respiratoire, troubles de la conscience, purpura ecchymotique ou nécrotique > 3 mm
- 3 risques chez le nourrisson : . déshydratation
- . convulsions hyperthermiques . hyperthermie maligne
- chez le nouveau-né (moins de 1 mois) : hospitalisation systématique : infection materno-fœtale jusqu'à preuve du contraire +++
- chez le moins de 3 mois : bilan systématique : NFS, CRP, ECBU, hémocultures, radio de thorax
- traitement antipyrétique systématique chez l'enfant + mesures physiques (hydrater ++)
- > paracétamol 60 mg/kg/j A/ores :

ITEM N°205 Hémorragie digestive Haute :

- signes de gravité : retentissement hémodynamique ; attention : si prise de bétabloquants (pour prévenir une récurrence de rupture de VO) : masque la tachycardie
- hémoglobine faussement rassurante au début
- sonde nasogastrique + lavage gastrique
- érythromycine IV
- IPP IV
- FOGD en urgence chez un malade en bon état hémodynamique et sans trouble de conscience
- si rupture de varices oesophagiennes : . prévention de l'encéphalopathie hépatique et de l'infection du liquide d'ascite : lactulose + antibiothérapie (fluoroquinolone) . vasoconstricteur : somatostatine IV
- . traitement préventif secondaire au décours : bétabloquants ou ligature **Basse :**
- rectorragies / mélèna : si abondante : FOGD en premier
- coloscopie totale
- examen proctologique
- si hémorragie massive : artériographie coelio-mésentérique ou laparotomie exploratrice
- :

Grosse jambe rouge aiguë

Fébrile -> infectieux :

- érysipèle
- fasciite nécrosante Inflammatoire :
- érythème noueux : sarcoïdose, tuberculose, infection à streptocoque, yersiniose, MICI, médicaments
- thrombose veineuse profonde
- lymphangite



- poussée d'insuffisance veineuse chronique
- :

ITEM N°206 Hypoglycémie

- glycémie < 0.5 g/L
- confirmation du diagnostic = disparition des troubles après resucrage
- conduite à tenir :
 - . chez un sujet calme et conscient : resucrage PO
 - . sujet conscient mais confus ou agité : glucagon IM puis glucose PO ou IV
 - . sujet inconscient : G30% 50 ml IVD puis G10% IVSE 2L / 24h
 - . surveillance du dextro / heure
- etiologies :
 - . fonctionnelles : post-prandial tardif
 - . iatrogènes : alcool, insuline, ADO
 - . organiques : insulinome, insuffisance hépato-cellulaire : hypoglycémie à jeun

- épreuve de jeune

ITEM N°207 Infection aiguë des parties molles (abcès, panaris, phlegmon des gaines)

Panaris

- Staphylocoque aureus
- 3 stades :
 - . invasion : asymptomatique
 - . phlegmasique : pas de fièvre ; traitement médical ambulatoire
 - . collecté : douleurs pulsatiles, fièvre ; traitement chirurgical : excision, prélèvement, lavage, plaie laissée ouverte pour cicatrisation dirigée, immobilisation + antibiothérapie : Augmentin®
- SAT VAT

Phlegmons des gaines des fléchisseurs

- attitude en crochet irréductible du doigt
- douleur provoquée par la palpation du cul de sac supérieur
- rechercher et traiter la porte d'entrée ++ (panaris)
- 3 stades : inflammatoire, purulent et nécrosant (disparition du crochet)
- traitement chirurgical : mise à plat, prélèvement, lavage, excision des tissus nécrosés, cicatrisation dirigée, immobilisation
- SAT VAT

Infections à germes anaérobies (gangrène gazeuse)

- Clostridium perfringens
- crépitation gazeuse sous-cutanée
- urgence thérapeutique
- antibiothérapie : pénicilline G + metronidazole
- traitement chirurgical : excision de tous les tissus nécrosés
- oxygénothérapie hyperbare :

ITEM N°208 Ischémie aiguë des membres

- embolie sur artères saines / thrombose sur artères athéromateuses
- abolition des pouls
- signes neurologiques = signes de gravité
- palpation des pouls controlatéraux : recherche une artériopathie sous-jacente
- bilan étiologique : bilan cardio
- retentissement : rhabdomyolyse
- traitement médical : héparine IVSE + vasodilatateur IV + antalgique
- artériographie systématique si artères athéromateuses
- urgence = REVASCULARISATION +++ :
 - . embolie : pas d'examen complémentaire ; embolectomie à la sonde de Fogarty
 - . thrombose : artériographie puis angioplastie ou pontage



- si syndrome des loges : aponévrotomie de décharge
- surveillance du syndrome de reperfusion
- :

ITEM N°209 Malaise, perte de connaissance

- interrogatoire
- lipothymie / syncope
- rechercher une douleur thoracique
- hypotension orthostatique
- toujours penser à l'EP
- dextro + ECG systématiques +++

Crise comitiale

- confusion post-critique, morsure de langue, perte d'urines
- chez un épileptique connu, faire un dosage plasmatique des anti-épileptiques
- EEG
- TDM cérébral si épilepsie non connue
- traitement de la crise : libérer les voies aériennes supérieures, Rivotril® 1 mg IVD
- :

ITEM N°210 Malaise grave du nourrisson et mort subite

Malaise grave

- hospitalisation systématique
- bilan complet : gaz du sang, glycémie, CPK, bilan infectieux, bilan hépatique, ECG, radio de thorax
- périmètre crânien ++
- si pâleur : évoquer l'hématome sous-dural et l'invagination intestinale
- informer les parents, les rassurer
- survenu au changement de position : penser au RGO : faire pH-métrie + FOGD

Mort subite

- pas de cause mais des facteurs favorisants : prématuré, problèmes sociaux, tabagisme passif, couchage non adapté ...
- examen complet de l'enfant + prélèvements
- demande d'autopsie avec accord des 2 parents
- prise en charge de la famille : déculpabiliser, RdV ultérieur... A/ores.'

ITEM N°211 Œdème de Quincke et anaphylaxie

- éviction de l'allergène +++
- adrénaline SC ou 1 mg d'IVD + corticoïdes + anti-H1
- remplissage vasculaire
- liste des médicaments contre-indiqués
- port d'une carte d'allergiques
- kit auto-injecteur d'adrénaline Toxidermie :
- huileuses : syndrome de Lyell, de Stevens Johnson
- signe de Nikolsky
- déclaration à la pharmacovigilance
- :

ITEM N°212 Œil rouge et/ou douloureux Sans baisse de l'acuité visuelle

- hémorragie sous-conjonctivale
- conjonctivite : bactérienne, virale, allergique
- episclerite, sclerite

Avec baisse de l'acuité visuelle

Glaucome aigu par fermeture de l'angle :



- cercle périkératique
- œdème coméen
- semi-mydrisie aréflexique
- examen de l'œil adelphe ++
- traitement : général (hypotonisant), local (collyre hypotonisant et myotique), radical (iridectomie périphérique)
- Uvéite antérieure :
 - douleurs, larmoiement, photophobie
 - précipités rétro-cornéens
 - effet Tyndall
 - synéchies irido-cristalliniennes
 - toujours rechercher une uvéite postérieure : fond d'œil Kératite :
 - instillation de fluorescéine
 - ulcération dendritique : kératite herpétique : contre-indication aux corticoïdes locaux +++
 - autres causes : virales, bactériennes, mycosiques, syndrome sec, toxiques...

ITEM N°213 Plaies, piqûres et morsures. Prévention de la rage

- déclaration obligatoire
- incubation longue : 10 jours à 1 an
- formes furieuse et paralytique
- spasme hydrophobique
- prélèvements multiples : salivaires, LCR, biopsies cutanées ...
- soins locaux : lavage, désinfection, parage ; pas de suture ++
- apprécier le risque de contamination : enzootie rabique, nature du contact, comportement de l'animal, siège de la morsure ...
- si animal vivant : surveillance 14 j ; si mort : envoi de la tête à l'institut Pasteur
- traitement spécifique : au Centre antirabique : immunoglobulines spécifiques + vaccination :

ITEM N°214 Principales intoxications aiguës

Psychotropes

- opiacés :
 - . triade : coma aréflexique, myosis, bradypnée . antidote = Narcan®
- cocaïne :
 - . tachycardie, HTA, excitation, mydrisie bilatérale . ECG
 - . traitement = bêtabloquant
- benzodiazépines :
 - . coma calme hypotonique, pupilles normales, insuffisance respiratoire . antidote = flumazénil (Anexate®) ; attention : contre-indiqué si intoxication aux antidépresseurs tricycliques +++ : risque convulsif
- carbamates :
 - . absorption irrégulière : coma calme irrégulier ; mydrisie . toxicité cardiaque ++ : risque d'OAP, de collapsus
- barbituriques :
 - . inducteurs enzymatiques
 - . coma calme, hypotonique, myosis
 - . traitement = diurèse osmotique alcaline
- tricycliques :
 - . syndrome anticholinergique : mydrisie, sécheresse muqueuse, rétention d'urines
 - . coma agité, hypertonique, convulsions
 - . effet stabilisant de membranes +++
 - . traitement = sels de sodium molaires (bicarbonates 8,4%)
- lithium :
 - . coma hyper-réflexique . risque d'hyponatrémie ++ . lithiémie en urgence . ECG
 - . traitement = diurèse osmotique alcaline Salicylés
- céphalées, vertiges, acouphènes



- hyperventilation, hyperthermic, rhabdomyolyse
- gaz du sang, hémostase
- traitement = diurèse alcaline Paracetamol
- paracétamolémie : diagramme de Prescott
- toxicité hépatique
- latence +++ (environ 24 h)
- antidote = N-acétyl-cystéine Cardiotropes
- digitaliques :
 - . troubles neurosensoriels
 - . digoxinémie +++
 - . ECG : bradycardie, BAV
 - . attention à l'hypokaliémie ++
 - . antidote = anticorps anti-digitaliques (Digidot®)
- bêtabloquants :
 - . effet stabilisant de membranes +++ . bradycardie, BAV, choc cardiogénique . hypoglycémie . ECG

Monoxyde de carbone

- coma hypertonique
- rhabdomyolyse
- gaz du sang : attention : paO_2 normale ++
- HbCO > 5%
- traitement = caisson hyperbare
- séquelles neurologiques ; syndrome post-intervalle
- enquête technique ++
- :

ITEM N°215 Rachialgie

- horaire : mécanique ou inflammatoire +++
- examen neurologique : radiculaire, signes de compression médullaire -> IRM en urgence
- tassement vertébral : myélome, métastase, ostéoporose
- aiguë : lumbago : pas d'examen complémentaire
- chronique : lombalgie commune discale ; traitement symptomatique + REEDUCATION ++
- indice de Schober pour les lombalgies :

ITEM N°216 Rétention aiguë d'urine

- globe vésical : matité hypogastrique convexe en haut
- diagnostic différentiel = anurie (vessie vide)
- drainage des urines en urgence :
 - . sondage urétral ; contre-indications : rétrécissement ou traumatisme urétral, prostatite
 - . cathéter sus-pubien ; contre-indications : doute diagnostique, troubles de l'hémostase, cancer de vessie, cicatrice sous-ombilicale, pontage artériel rétropubien
- ECBU systématique après drainage
- vessie vidée lentement : risque d'hémorragie a vacuo
- syndrome de levée d'obstacle :

ITEM N°217 Syndrome occlusif

- douleur abdominale + nausées/ vomissements + météorisme
- mécanismes : obstruction / strangulation / fonctionnel
- antécédents chirurgicaux-* bride
- examen des orifices herniaires +++
- toucher rectal
- ASP : niveaux hydro-aériques
- obstruction du grêle : syndrome de Koenig
- traitement symptomatique : A JEUN, ± sonde nasogastrique, rééquilibration hydro-électrolytique
- volvulus du sigmoïde : . ASP : U inversé
- . lavement aux hydrosolubles : aspect en bec d'oiseau
- . complication = perforation diastatique du caecum



. traitement = montée de sonde rectale + sigmoïdectomie à distance
:

ITEM N°218 Syndrome pré-éclampsique (ne figure plus dans le nouveau programme)

- diagnostic clinique : HTA gravidique + protéinurie > 0,3 g/24h
- critères de sévérité : céphalées, acouphènes, douleur épigastrique, oligurie < 500 ml, ROT vifs, protéinurie > 1 g/24h, hyperuricémie, thrombopénie, hémolyse, cytolysé hépatique, RCIU...
- complications : HELLP syndrome, éclampsie, hématome rétropéritonéal, RCIU dyharmonieux, oligoamnios, souffrance fœtale aiguë
- penser au bilan de l'HTA : ECG, fond d'œil
- traitement :
 - . repos en décubitus latéral gauche
 - . traitement anti-hypertensif
 - . remplissage vasculaire si pré-éclampsie sévère
 - . attention : régime normosodé ++
- surveillance : diurèse, poids, échographie obstétricale
- prévention du risque de récurrence lors d'une prochaine grossesse : aspirine 100 mg *1*)

ITEM N°219 Troubles de l'équilibre acido-basique et désordres hydro-électrolytiques

- déshydratation extracellulaire :
 - . diagnostic clinique
 - . hémococoncentration, insuffisance rénale fonctionnelle
 - . pertes sodées rénale : natriurèse > 20 mmol / 24h
- hyperhydratation extracellulaire : . œdèmes
- traitement : régime désodé, restriction hydrique + diurétiques de l'anse
- déshydratation intracellulaire :
 - . hypernatrémie
 - . première étape = regarder le secteur extracellulaire
 - . diabète insipide
 - . traitement : G5% IV, correction lente
- hyperhydratation intracellulaire : . hyponatrémie
 - . attention aux fausses hyponatrémies : $\text{osmolarité} = \text{Na} \times 2 + \text{glycémie} + \text{urémie} = 300 \text{ mOsm/L}$. Na corrigée = Na mesurée + protides / 40 . hyperhydratation intracellulaire isolée : SIADH . traitement : restriction hydrique, correction lente ; attention au risque de myélinolyse centropontine
- hyperkaliémie : . ECG
 - . traitement : gluconate de calcium (contre-indiqué si traitement par digitaliques), alcalinisation (bicarbonate), insuline + G10%, Kayexalate
- hypokaliémie : . ECG ++
 - . traitement : dlfu-K®
- gaz du sang :
 - . trou anionique = $\text{Na} - (\text{Cl} + \text{HC03}^-) = 12 \pm 4 \text{ mmol/L}$. acidose métabolique à trou anionique élevé : acidose lactique, acidocétose, intoxication à l'éthylène glycol, insuffisance rénale
- /Votes :

MALADIES ET GRANDS SYNDROMES

ITEM N°220 Adénome hypophysaire

- micro / macroadénome
- syndrome sécrétant
- syndrome tumoral : céphalées, hypertension intracrânienne, hémianopsie bitemporale
- syndrome d'insuffisance antéhypophysaire : pâleur, asthénie, dépigmentation
- IRM hypophysaire + bilan ophtalmologique + bilan hormonal +++
- adénome à prolactine :
 - . galactorrhée bilatérale, hypogonadisme . β HCG
 - . causes médicamenteuses : neuroleptiques, antidépresseurs, benzodiazépines, antiépileptiques
- adénome somatotrope : acromégalie : . syndrome dysmorphique

- . troubles cardio-vasculaires . diabète
- . susceptibilité aux cancers : colon ++ . IGF1 + test de freinage / HGPO
- adénome corticotrope = maladie de Cushing
- . diagnostic différentiel = syndrome paranéoplasique . hypercatabolisme protidique : cutané, musculaire, capillaire, Osteoporose
- . redistribution facio-tronculaire des graisses . mélanodermie ++
- . test de freinage faible à la dexaméthasone négatif ++
- . diagnostic étiologique : test de freinage fort à la dexaméthasone positif
- :

ITEM N°221 Algodystrophie

- 2 phases : chaude (hyperesthésie) et froide (raideur)
- causes médicamenteuses : isoniazide, gardéna
- VS et CRP normales, liquide articulaire mécanique +++
- radiotransparence mouchetée, respect de l'interligne articulaire +++
- IRM et scintigraphie plus précoce que la radio
- épaule gelée = capsulite rétractile
- évolution très lente : prévenir le patient
- traitement :
- . mise en décharge
- . antalgiques
- . rééducation douce et indolore . soutien psychologique
- :

ITEM N°222 Anémie par carence martiale (ne figure plus dans le nouveau programme)

- anémie microcytaire, hypochrome, arégénérative
- diminution de la ferritine, du coefficient de saturation, du fer sérique
- signes d'anémie + signes de carence
- diagnostic étiologique : FOGD, coloscopie, examen gynécologique
- traitement étiologique + traitement martial : fer 200 mg/j PO pendant 4 mois
- bilan de contrôle : ferritine se normalise en dernier
- :

ITEM N°223 Angiomes cutanés

- hémangiome du nourrisson = tumeur bénigne ; intervalle libre ; régression spontanée
- maladie de Rendu-Osier
- angiome plan = capillaire
- malformation artério-veineuse : tuméfaction chaude, battante, souffle ; complications : hémorragie, insuffisance cardiaque
- lymphangiome
- A/ores :

ITEM N°224 Appendicite de l'enfant et de l'adulte

- douleur + défense en fosse iliaque droite + fièvre
- toucher rectal : douleur dans le cul de sac de Douglas
- TDM abdominal
- formes rétrocaecale, pelvienne, mésocœliaque, sous-hépatique
- complications : plastron appendiculaire, abcès, péritonite
- traitement chirurgical : appendicéctomie, examen anatomopathologique
- antibiothérapie
- complications post-opératoires : abcès de paroi, abcès du cul de sac de Douglas, hématome de paroi, péritonite ; à distance : occlusion sur bride
- Nofes :

ITEM N°225 Arthropathie microcristalline



Goutte

- hyperuricémie
- terrain : homme d'âge mûr, pléthorique
- ponction articulaire : liquide inflammatoire, stérile, cristaux d'urate (fins, longs, effilés, réfringents)
- radio : encoches épiphysaires, pincement articulaire, géodes
- bilan rénal ++
- traitement : colchicine + règles hygiéno-diététiques
- traitement de fond = allopurinol

Chondrocalcinose articulaire

- secondaire : hyperparathyroïdie, hémochromatose
- bilan : phosphocalcique, fer, ferritine, PAL, ionogramme sanguin
- terrain : femme âgée
- radio : bassin de face, 2 genoux de face, mains + poignets
- calcification des fibrocartilages
- liquide articulaire : cristaux de pyrophosphate de calcium : courts, bouts carrés, peu réfringents
- traitement : AINS
- :

ITEM N°226 Asthme de l'enfant et de l'adulte

- Physiopathologie : inflammation bronchique, hyper-réactivité bronchique, obstruction bronchique
- syndrome obstructif réversible +++
- DEP
- EFR
- sévérité : intermittent / persistant léger / persistant modéré / persistant sévère
- contre-indication des bêtabloquants ++
- environnement : éviction du tabac, lutte contre les acariens
- EDUCATION thérapeutique +++ : école de l'asthme, PAI
- traitement de la crise : (32 + courte durée d'action (ventoline) ; si échec : corticothérapie orale 60 mg ; si échec = asthme aigu grave : DEP < 30% de la théorique
- traitement de l'asthme aigu grave : . hospitalisation en réanimation
- . p2 + : salbutamol 5 mg en nébulisation . corticoïdes : solumédrol IV 60 mg / 8h . O₂ 6 à 8 L
- . hydratation + KCl 4 à 6 g/j
- :

ITEM N°227 Bronchopneumopathie chronique obstructive

- définition clinique : toux + expectoration plus de 3 mois / an pendant au moins 2 années consécutives
- radiographie de thorax : distension thoracique, syndrome bronchique, préciser l'aspect du cœur et des artères pulmonaires (dilatés à un stade avancé)
- EFR : syndrome obstructif : VEMS/ CV < 70% non réversible
- emphysème centro-lobulaire : CPT > 120% de la valeur théorique
- 3 stades selon le VEMS
- stade 3 : HTAP, insuffisance ventriculaire droite, cœur pulmonaire chronique
- fibroscopie bronchique : élimine un cancer pulmonaire
- bilan des complications du tabac ++
- surinfection bronchique : exacerbation de BPCO ; antibiothérapie : Augmentin®
- traitement au long cours : . arrêt du tabac +++
- . kiné respiratoire ++ réhabilitation respiratoire
- . contre-indications médicamenteuses (benzodiazépines ...)
- . éradication des foyers infectieux (ORL, dentaires)
- . vaccination anti-grippale et anti-pneumococcique
- . bronchodilatateur : p2 + inhalé
- . anti-inflammatoire : corticoïdes inhalés
- :





ITEM N°228 Cirrhose et complications Cirrhose

- insuffisance hépato-cellulaire : ictère, angiomes stellaires, encephalopathy hépatique, baisse du TP
- hypertension portale : Splénomégalie, circulation veineuse collatérale, ascite
- bilan étiologique systématique : sérologies hépatites B et C, coefficient de saturation de la transferrine, anticorps ;
- bilan pour le diagnostic positif : échographie abdominale, FOGD, PBH
- suivi : échographie abdominale + aFP / 6 mois
- score Child et Pugh : stades A, B et C
- traitement :
 - . arrêt de l'alcool
 - . vaccination contre l'hépatite B
 - . arrêt des médicaments hépatotoxiques
 - . transplantation : Child et Pugh C, échec de tous les traitements de l'hypertension portale, CHC unique de moins de 5 cm Complications
- toujours rechercher le facteur déclenchant d'une décompensation ++
- hémorragie digestive :
 - . prévention primaire ou secondaire : bêtabloquants ou ligature de varices oesophagiennes
- décompensation œdémato-ascitique : . ponction d'ascite systématique
- . infection : PNN > 250 / mm³
- . traitement d'une infection du liquide d'ascite = C3G + albumine 20% IV + ponction de contrôle à 48h
- . contre-indication des médicaments néphrotoxiques (aminosides, AINS, diurétiques)
- . prophylaxie secondaire systématique : fluoroquinolones
- syndrome hepatorenal :
 - . ascite + créatinine > 130 umol/l
- encéphalopathie hépatique :
 - . astérisis, foëtor, hypertonie extrapyramidale, jusqu'au coma
 - . traitement = lactulose
 - . contre-indication des benzodiazépines
 - .

ITEM N°229 Colopathie fonctionnelle

- **diagnostic d'élimination**
- **douleurs abdominales, dyspepsie, troubles du transit**
- évolution chronique ; aggravé par le stress
- éliminer une organicité ++ : NFS, ionogramme, VS, glycémie, T4 TSH, coloscopie
- traiter : rassurer sur la bénignité, psychothérapie, régime équilibré adapté, traitement symptomatique
- .

ITEM N°230 Coma non traumatique

- Glycémie +++
- score de Glasgow
- score de Liège : réflexes du tronc cérébral
- étude du tonus : hypotonie (toxiques, troubles métaboliques), hypertonie extrapyramidale (CO, neuroleptiques), rigidité de decortication (atteinte capsulaire bilatérale), rigidité de décérébration (atteinte du tronc cérébral)
- examen des pupilles ++
- TDM cérébral systématique :

ITEM N°231 Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval

Compression médullaire

- syndrome lésionnel : signes radiculaires = niveau lésionnel
- syndrome sous-lésionnel : troubles moteurs, sensitifs, sphinctériens
- syndrome rachidien : douleur, raideur rachidienne
- pas de syndrome sus-lésionnel
- risque = myélomalacie

- formes cliniques : syndrome cordonal postérieur, syndrome de Brown-Sequard, syndrome du cône terminal
- IRM médullaire +++ : ischémie = hypersignal en T2
- urgence neurochirurgicale
- corticothérapie
- immobilisation +++
- rééducation

Syndrome de la queue de cheval

- à partir de L2
- troubles sensitifs + moteurs + génito-sphinctériens
- toucher rectal
- pas de syndrome pyramidal
- IRM rachidienne en urgence
- urgence neurochirurgicale : laminectomie decompressive
- prévention des complications de décubitus
- :

ITEM N°232 Dermatoses faciales

:

Item : 233 Diabète sucré de type 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte

- définition : glycémie à jeun > 1,26 g/L sur 2 dosages

Diabète de type 1

- maladie auto-immune
- syndrome cardinal
- traitement = insuline SC
- auto-surveillance : dextro, BU
- carnet d'auto-surveillance
- objectifs glycémiques et objectif d'HbA1c (< 6,5%)
- règles hygiéno-diététiques : régime équilibré, éviter les sucres à index glycémique élevé

Diabète de type 2

- traitement de première intention : règles hygiéno-diététiques pendant 3 mois
- si échec : anti-diabétiques oraux : biguanides ou sulfamides hypoglycémisants : attention aux interactions médicamenteuses et aux contre-indications ++
- si échec : insulino-requérance

Complications chroniques Rénales :

- néphropathie diabétique glomérulaire : . 5 stades
- . BU, microalbuminurie
- . si pas de rétinopathie diabétique associée, faire une PBR . attention, si insuffisance rénale sévère, arrêter les ADO +++ . traitement = équilibre glycémique et tensionnel : objectif tensionnel = TA < 125/75 mmHg si Proteinurie > 1 g/24h . traitement par IEC systématique

Ophtalmologiques :

- examen complet bilatéral annuel ++
- rétinopathie diabétique :
 - . angiographie à la fluorescéine . non proliférante / proliférante (néo-vaisseaux) . complications : glaucome néo-vasculaire, hémorragie Intra-rétinienne, décollement de rétine
 - . traitement = photocoagulation pan-rétinienne

Neurologiques :

- multinevrite, polynévrite
- test au monofilament
- mal perforant plantaire
- examen des pieds à chaque consultation +++
- neuropathie végétative : impuissance, gastroparésie, hypotension orthostatique ++, IDM indolore

Cardio-vasculaires :



- IDM silencieux ; toute décompensation -> ECG + troponine
- coronarographie : penser à arrêter les biguanides
- insuffisance rénale chronique : éliminer une sténose des artères rénales avant d'introduire les IEC
- Infectieuses :
- bilan stomatologique + panoramique dentaire / an

Complications aiguës

- arrêt systématique des ADO +++
- recherche et traitement du facteur déclenchant

Cétoacidose diabétique :

- déshydratation, hyperkaliémie mais hypokaliémie +++ -> ECG
- BU : cétonurie ; odeur acétonique de l'haleine
- gaz du sang : acidose métabolique à trou anionique augmenté
- traitement : réhydratation : sérum physiologique + KCl puis G10% quand glycémie normalisée
- insulinothérapie IVSE 10 UI/ h jusqu'à disparition de la cétonurie

Coma hyperosmolaire :

- hyperglycémie importante ; BU : glycosurie pas de cétonurie
- déshydratation : hypernatrémie : attention : calculer la natrémie corrigée en fonction de la glycémie
- hyperosmolarité
- traitement : hospitalisation en réanimation, voie veineuse centrale, réhydratation 8 L/24h ; normalisation lente de la natrémie
- insuline IVSE
- éducation de l'entourage +++

Acidose lactique :

- biguanides + anoxie tissulaire (injection de produit de contraste iodé)
- lactacidémie augmentée
- gaz du sang
- traitement : réanimation, oxygénothérapie, réhydratation, alcalinisation, insuline IVSE, arrêt des biguanides

Hypoglycémie :

- sulfamides : attention aux interactions médicamenteuses : contre-indication à l'injection de glucagon
- éducation +++
- :

ITEM N°234 Diverticulose colique et sigmoïdite

- seul traitement d'une diverticulose = régime riche en fibres
- asymptomatique en l'absence de complication **Sigmoïdite diverticulaire :**
- coloscopie contre-indiquée en urgence +++ : risque de perforation
- TDM abdomino-pelvien = systématique : infiltration de la graisse péri-sigmoïdienne, épaississement des parois, diverticules, recherche de complications ++
- traitement médical : .A JEUN
- . antalgiques, glace sur le ventre
- . antibiothérapie double : Augmentin® + aminoside ou C3G + Flagyl® . puis régime sans résidu après quelques jours
- traitement chirurgical : après la 2^e poussée, après une complication ou chez le moins de 60 ans dès la première poussée
- . COLOSCOPIE PRE-OPERATOIRE +++ : élimine un cancer . sigmoïdectomie, anastomose colorectale, envoi en anapath
- complications :
- . abcès diverticulaire-> drainage . péritonite stercorale : ASP -> pneumopéritoine . fistules : colo-vésicales (infections urinaires à répétition, fécalurie, pneumatisme)
- . occlusion : attention au cancer sous-jacent : faire coloscopie + biopsie après avoir éliminé une perforation au scanner
- :





ITEM N°235 Epilepsie de l'enfant et de l'adulte Partielle

- rechercher une cause lésionnelle +++
- simple ou complexe
- idiopathique (ex : epilepsie bénigne de l'enfant à paroxysmes rolandiques)
- symptomatique : intoxication, sevrage, traumatisme, infection, tumeurs... **Généralisée**
- idiopathique : imagerie normale :
 - . absences : EEG spécifique : pointes-ondes à 3 cycles/seconde, bilatérales et symétriques, à début et fin brusques ; entre 2 et 10 ans
 - . grand-mal : crise tonico-clonique généralisée en 3 phases (tonique, clonique, récupération)
 - . myoclonie juvénile
- symptomatique :
 - . enfant : syndrome de West : nourrisson, spasmes en flexion, hypersarythmie à l'EEG, retard mental retard du développement psychomoteur
 - . adulte : tumeurs ++
- éducation ++ :

ITEM N°236 Fibrillation auriculaire

- paroxystique / permanente
- ECG : tachycardie irrégulière à QRS fins ; pas d'onde P
- bilan systématique : TSH T4, ionogramme (K +), ETT
- complication = EMBOLIE :
 - . facteurs de risque : cliniques = CHADS (insuffisance cardiaque, HTA, âge > 60 ans, diabète, AVC) ; valvulopathie associée, critères échographiques = dilatation de l'oreillette gauche, dysfonction VG < 35%, thrombus visible
- traitement de l'épisode aigu :
 - . ANTICOAGULER : AVK ; à vie si critères CHADS > 2
 - . REDUIRE : 2 attitudes (courte avec ETO ou longue avec 3 semaines d'anticoagulation) : CEE ou réduction médicamenteuse (Cordarone®) . RALENTIR : fonction VG normale : bêtabloquant ; dysfonction VG : digitalique ; si échec : Cordarone®
- traitement à long terme :
 - . anticoagulation selon les facteurs de risque emboliques . prévention des récurrences si réduction : anti-arythmique : flécaïne si cœur sain, Cordarone® si cardiopathie
 - . traitement radical à discuter (ablation par radiofréquence, pace-maker)
- :

ITEM N°237 Fractures chez l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques

- capacité de remodelage osseux
- cartilage de croissance
- corticale élastique et plastique
- fractures épiphysaires : classification de Salter et Harris en 5 stades : stades I et II : traitement orthopédique ; stades III et IV = fractures articulaires : traitement chirurgical
- complication = épiphysiodèse post-traumatique
- fractures métaphysaires : en motte de beurre
- fractures diaphysaires : en bois vert
- principes thérapeutiques :
 - . autorisation parentale de soins signée
 - . traitements orthopédiques en priorité par rapport aux traitements chirurgicaux
 - . éducation des parents (information sur le syndrome des loges ++)
 - . PAS DE REEDUCATION +++
 - . pas d'anticoagulation avant la puberté
- :

ITEM N°238 Fracture de l'extrémité inférieure du radius chez l'adulte

- ostéoporose
- mécanisme indirect ++ : déplacement postérieur, le plus fréquent = Pouteau-Colles, Gérard Marchand (+ styloïde cubitale)
- déplacement antérieur = Goyrand-Smith
- main dominante ++
- déformation : main botte radiale, horizontalisation de la ligne bistyloïdienne, profil en dos de fourchette
- complications spécifiques : atteinte du nerf médian, rupture du tendon du long extenseur du pouce
- traitement : soit orthopédique : BABP 6 semaines ; chirurgical : em brochage percutané
- REEDUCATION ++ précoce :

ITEM N°239 Fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte

- **Osteoporose**, sujet âgé
- fractures cervicales vraies : classification de Garden en 4 stades ; Intérêt pronostique et thérapeutique
- risque = ostéonécrose aseptique de la tête du fémur ; décompensation de tares
- fractures trochantériennes (60%)
- inspection : raccourcissement, rotation externe, adduction
- radiographies : bassin de face + hanche de profil + cadre obturateur
- traitement chirurgical :
 - . conservateur : **Osteosynthese**
 - . non conservateur = arthroplastie de hanche : Garden III ou IV . lever précoce chez les sujets âgés
- KINESITHERAPIE +++
- HBPM ++
- traitement de l'ostéoporose
- penser au traitement et au bilan des chutes si sujet âgé
- :

ITEM N°240 Glaucome chronique

- hypertonie oculaire > 21 mmHg
- augmentation de l'excavation papillaire : cup / dise > 0,3
- facteurs de risque : facteurs de risque cardio-vasculaires, corticothérapie
- champ visuel automatisé de Humphrey +++ : ressaut nasal, scotomes paracentraux, arciforme
- traitement médical : à vie ++ : collyre hypotonisant (bétabloquants, analogues de prostaglandines)
- si échec : traitement chirurgical : trabéculéctomie
- surveillance à vie : tonus oculaire, fond d'œil, champ visuel / 6 à 12 mois
- dépistage à partir de 40 ans
- :

ITEM N°241 Goitre et nodule thyroïdien Nodule thyroïdien

- bilan systématique : TSH, T4, échographie thyroïdienne, calcitonine
- attention au cancer de la thyroïde
- cancer médullaire de la thyroïde : NEM 2, diarrhée motrice, flushes, élévation de la calcitonine et de l'ACE, enquête familiale
- scintigraphie thyroïdienne : nodule froid
- cytoponction échoguidée + cytologie
- diagnostic positif de cancer = cervicotomie exploratrice pour examen histologique : pour tout nodule de plus de 1 cm ++
- nodule < 1 cm : simple surveillance
- dans le bilan pré-opératoire, penser au bilan phosphocalcique +++ car risque d'hypoparathyroïdie
- traitement radical = thyroïdectomie totale ou radiothérapie à l'iode 131 = IRA thérapie
- puis Opothérapie freinatrice à vie (cancer THS-dépendant) ++
- surveillance : TSH, thyroglobuline **Goitre**
- hypothyroïdie ou hyperthyroïdie



- iatrogène : lithium, Cordarone®
- endémique : carence en iode
- complication = goitre plongeant, compressa
- :

ITEM N°242 Hémochromatose

- génétique : autosomique récessive ; mutation C282Y, gène HFE
- clinique : pigmentation de la peau, cirrhose, cardiomyopathie dilatée, diabète, chondrocalcinose articulaire, hypogonadisme
- biologie : coefficient de saturation de la transferrine > 30% +++ = définition
- diagnostic de certitude = recherche de la mutation, avec consentement éclairé
- enquête familiale
- traitement = saignées à vie
- arrêt de l'alcool, des médicaments hépatotoxiques, vaccination contre l'hépatite B
- surveillance = ferritine
- :

ITEM N°243 Hémorragie génitale chez la femme

- métrorragies / ménorragies
- chez une femme jeune -> réflexe GEU
- cancer de l'endomètre
- fibrome utérin
- causes infectieuses : cervicite, salpingite ...
- iatrogène : pilule, stérilet, progestatifs
- tolérance hémodynamique +++ comme pour tout saignement
- examen au spéculum : détermine l'origine utérine ou vaginale du saignement
- échographie pelvienne et endovaginale systématique
- Wofes /

ITEM N°244 Hémorragie méningée

- syndrome méningé sans fièvre
- **TDM** cérébral sans injection en urgence
- angio-IRM
- artériographie cérébrale des 4 axes en urgence : diagnostique et thérapeutique
- doppler trans-crânien (recherche de spasmes)
- complications : hypertension Intracrânienne, hydrocéphalie, spasme artériel, resaignement
- anévrisme artériel intracrânien : risque de rupture important quand taille > 7 mm
- paralysie douloureuse du III -> rupture Imminente d'un anévrisme de la terminaison de la carotide interne
- traitement : contrôler la tension +++ (doit rester inférieure à 15/10), prévention du vasospasme = nimodipine (discuté), traitement endo-vasculaire (coils) ou chirurgical (clips)
- :

ITEM N°245 Hernie pariétale chez l'enfant et l'adulte

Chez l'adulte

- impulsive à la toux, réductible
- examen controlatéral et examen des autres orifices herniaires +++
- inguinale :
 - . collet au dessus de la ligne de Malgaigne
 - . indirecte = en dehors de l'artère épigastrique / directe = en dedans de l'artère épigastrique
- crurale :
 - . collet au dessous de la ligne de Malgaigne
- complication = hernie étranglée : irréductible +++ : chirurgie en urgence

Chez l'enfant

- congénital



- défaut de fermeture du canal péritonéo-vaginal
- souvent bilatérale : examen controlatéral +++
- étranglement fréquent : 1^{er} geste en urgence = manœuvre de réduction
- jamais de tentative de réduction chez la fille (risque de torsion de l'ovaire)
- traitement chirurgical systématique

ITEM N°246 Hyperthyroïdie

- syndrome de thyrotoxicose
- TSH basse (causes périphériques ++)
- maladie de Basedow :
. goitre diffus, élastique, homogène, indolore, vasculaire . orbitopathie : examen ophtalmologique systématique +++ . anticorps anti-TSH récepteur (TRAK) . scintigraphie : hyperfixation homogène diffuse
- adénome toxique : nodule hyperfixant à la scintigraphie
- iatrogène : surcharge iodée : . scintigraphie blanche
- . iodurie des 24 h élevée
- . rechercher systématiquement une thyropathie sous-jacente ++
- complications :
. cardiomyopathie : ACFA, insuffisance cardiaque, syndrome coronaire. ECG systématique +++
- . orbitopathie maligne : exophtalmie douloureuse, non réductible . crise aiguë thyrotoxique
- traitement :
. anti-thyroïdien de synthèse : néomercazole : attention au risque d'AGRANULOCYTOSE ++ -> NFS mensuelle et si fièvre . bêtabloquants non cardio-sélectifs : propranolol . repos, arrêt de travail .
- CONTRACEPTION +++
- traitements radicaux : EUTHYROÏDIE avant tout traitement radical +++ . chirurgie : thyroïdectomie subtotale ; penser au bilan phosphocalcique en pré-opératoire
- . IRA-thérapie : contre-indications : exophtalmie, grossesse, allaitement . complication principale = hypothyroïdie
- traitement ophtalmologique ++ : soins oculaires ; corticothérapie si orbitopathie maligne

ITEM N°247 Hypertrophie bénigne de la prostate

- signes fonctionnels urinaires : pollakiurie, impériosités, dysurie
- toucher rectal
- échographie vésico-prostatique et rénale +++ ; mesure du résidu post-mictionnel
- PSA +++
- débimétrie
- complications : rétention d'urines, hématurie, vessie de lutte, insuffisance rénale
- gêne fonctionnelle : score IPSS +++
- traitement :
. a bloquants, attention aux hypotensions orthostatiques
- . inhibiteurs de la 5a reductase (attention, PSA peut être faussement bas), effets secondaires nombreux
- . résection endoscopique de la prostate ; penser à l'examen anapath ; complication = TURP syndrome, éjaculation rétrograde (patient informé +++)

ITEM N°248 Hypothyroïdie

- infiltration myxoedémateuse
- aménorrhée
- TSH élevée
- recherche de maladies auto-immunes associées : syndrome de Schmidt +++
- auto-immune : Hashimoto; anticorps anti-TPO
- carence en iode : zones d'endémies goitreuse



- iatrogène : surcharge iodée : Cordarone®; lithium, antithyroïdiens de synthèse, chirurgie cervicale
 - **ECG +++++**
 - coma myxoœdémateux : hyponatrémie
 - traitement = hormonothérapie substitutive à vie : Lévothyrox® **Hypothyroïdie congénitale :**
 - syndrome dysmorphique
 - retard à l'évacuation du méconium
 - cassure de la courbe de poids ; âge osseux < âge statural < âge chronologique
 - troubles neurologiques ++ : retard psychomoteur, hypotonie, retard mental
 - dépistage obligatoire en néonatal
- Nofes :

ITEM N°249 Insuffisance aortique

- souffle proto-diastolique, maximum au foyer aortique, irradiant le long du bord gauche du sternum
- signes périphériques : PA diastolique élevée, hyperpulsatilité artérielle
- **ECG : HVG** diastolique
- aiguë -> dissection aortique ++
- ENDOCARDITE +++ : penser à l'antibioprophylaxie
- ETT : facteur pronostique = degré de dilatation du VG
- traitement chirurgical : remplacement valvulaire aortique
- bilan pré-opératoire
- :

ITEM N°250 Insuffisance cardiaque de l'adulte

- 1^e cause = ischémique
- dyspnée : stades NYHA
- ETT : FEVG < 50%
- bilan étiologique : TSH, calcémie, ferritine, vitamine B1, alcool, coronarographie ++
- complications : troubles du rythme, accidents thrombo-emboliques
- traitement :
 - . REGIME SANS SEL . IEC systématiques
 - . bêtabloquants : arrêt si décompensation ++
 - . diurétiques de l'anse si signes congestifs
 - . anti-aldostérone au stade NYHA III ou en post-infarctus
 - . resynchronisation ventriculaire : PM triple chambre +++
 - . vaccination contre la grippe
- OAP cardiogénique :
 - rechercher et traiter le facteur déclenchant +++
 - gaz du sang : effet shunt
 - radio de thorax : syndrome alvéolo-interstitiel, cardiomégalie
 - BNP, troponine +++
 - traitement : .scope
 - . G5% 500cc / 24h ; pas de sérum physiologique +++
 - . O₂ voire VNI en pression expiratoire positive
 - . arrêt des bêtabloquants +++
 - . diurétiques de l'anse : Lasilix® 60 mg IVD / 6h + KCl
 - . dérivés nitrés si PAS > 100 mmHg
 - :

ITEM N°251 Insuffisance mitrale

- maladie de Barlow
- aigu : rupture de pilier (ischémique), rupture de cordage (Barlow)
- souffle holosystolique, en jet de vapeur, maximum au foyer mitral, irradiant dans l'aisselle
- ECG : hypertrophie de l'oreillette gauche, HVG diastolique
- ETT : dilatation de l'OG et du VG
- complication = ACFA +++
- risque d'ENDOCARDITE +++



- traitement chirurgical : plastie mitrale, remplacement valvulaire mitral
- bilan pré-opératoire
- :

ITEM N°252 Insuffisance rénale aiguë. Anurie

- oligo-anurie = diurèse < 500 ml / 24h ; éliminer un globe vesical +++
- fonctionnelle : Na/K < 1, natriurèse < 20 mmol/24h ; déshydratation extracellulaire, hypovolémie
- obstructive : bilatérale ou sur rein unique : ECHOGRAPHIE RENALE SYSTEMATIQUE +++
- parenchymateuse :
 - . tubulaire : nécrose tubulaire aiguë, rhabdomyolyse, myélome . glomérulaire : GNRP, syndrome néphritique aigu . vasculaire : MAT, embolies de cholestérol, PAN . interstitielle : infection, immuno-allergique
- traitement :
 - . arrêt de tout médicament néphrotoxique +++, adapter les posologies . risque d'hyperkaliémie : ECG ++ . diurétiques de l'anse
 - . indications de la dialyse : hyperkaliémie sévère, OAP résistant, acidose sévère, syndrome urémique
- :

ITEM N°253 Insuffisance rénale chronique

- clearance de la créatinine ++
- troubles phosphocalciques : hypocalcémie, hyperphosphorémie, hyperparathyroïdie secondaire, ostéodystrophie rénale
- anémie
- traitement :
 - . prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaires . arrêt des médicaments néphrotoxiques (AINS, ADO...) . traiter l'HTA : IEC systématiques . diurétiques de l'anse si rétention hydro-sodée . règles hygiéno-diététiques : restriction sodée et protidiques, augmenter les apports en calcium . chélateurs du phosphore . supplémentation en vitamine D . EPO
 - . si hyperkaliémie : Kayexalate®
 - . préparation à la dialyse : préserver le capital veineux, vaccination contre l'hépatite B, information, fistule artério-veineuse
- inscription sur liste de greffe
- :

ITEM N°254 Insuffisance respiratoire chronique

- PaO₂ < 70 mmHg
- gaz du sang : hypoventilation alvéolaire
- obstructive : BPCO, asthme, emphysème
- restrictive : pneumopathies interstitielles
- vasculaire : cœur pulmonaire chronique post-embolique, HTAP primitive
- arrêt du tabac
- KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE
- réhabilitation respiratoire ++
- oxygenothérapie longue durée
- :

ITEM N°255 Insuffisance surrénale Périphérique :

- melanoderma
- ACTH élevée
- test au synacthène négatif
- auto-immune, tuberculose
- traitement : hormonothérapie substitutive A VIE ++ : hydrocortisone + fludrocortisone
- EDUCATION ++ : connaître la conduite à tenir en cas d'urgence
- règles hygiéno-diététiques : régime normosodé, pas de diurétique ni de laxatif

Insuffisance corticotrope :



- pas d'atteinte minéralo-corticoïde
- pas de mélanodermie
- après une corticothérapie au long cours ++ **Insuffisance surrénale aiguë** :
- déshydratation, collapsus
- hyponatrémie, hyperkaliémie
- rechercher un facteur déclenchant +++
- traitement : 100 mg d'hydrocortisone IM en urgence, puis hémisuccinate d'hydrocortisone 400 mg/j IVSE, réhydratation
- :

ITEM N°256 Lésions dentaires et gingivales

- panoramique dentaire + cliché rétro-alvéolaire
- carie
- pulpite : percussion transversale douloureuse ; antibiothérapie
- desmodontite : impression de dent longue, douleur à la percussion axiale, tests de vitalité pulpaire négatifs ; traitement = avulsion dentaire, antibiothérapie
- granulome et kyste apical
- complications : sinusite maxillaire chronique, cellulite faciale, thrombophlébite, septicémie, endocardite
- :

ITEM N°257 Lésions péri-articulaires et ligamentaires du genou, de la cheville et de l'épaule

- examen bilatéral et comparatif ++
- rééducation ++

Genou

- mécanisme lésionnel
- lésion du pivot central = entorse grave
- luxation du genou : risque de lésion de l'artère poplitée : artériographie systématique
- choc rotulien —> hémarthrose = signe de gravité
- tiroirs : test de Lachman : lésion du LCA ++
- ressaut rotatoire
- IRM du genou
- syndrome méniscal : blocages aigus, hydarthrose récidivante, instabilité
- arthroscopie pour les lésions méniscales

Cheville

- entorse du LLE ++
- critères d'Ottawa
- testing après la radiographie pour éliminer une fracture ++
- clichés dynamiques à distance : recherche une laxité
- entorse bénigne : traitement fonctionnel = protocole RICE
- entorse grave : traitement orthopédique = botte plâtrée + HBPM

Epaule

- éliminer une douleur coronarienne ou vésiculaire
- tendinite du supra-épineux
- signe de Neer, de Hawkins et de Yochum
- manœuvre de Jobe, palm up test, lift off test, manœuvre de Patte
- radio : recherche des calcifications tendineuses
- épaule pseudo-paralytique = rupture de la coiffe des rotateurs
- épaule aiguë hyperalgique = bursite aiguë à microcristaux d'hydroxyapatite
- épaule gelée = capsulite rétractile :

ITEM N°258 Lithiase biliaire et complications

- asymptomatique : pas de traitement, pas de surveillance
- pour toute complication : traitement chirurgical = cholécystectomie sous coelioscopie + cholangiographie per-opératoire + examen anatomopathologique

Colique hépatique



- douleur de moins de 6 heures
- signe de Murphy
- échographie : image hyper-échogène, mobile aux changements de position, cône d'ombre postérieur ; épaisseur de paroi normale (< 4 mm), diamètre de la voie biliaire principale < 7 mm
- bilan hépatique normal **Cholécystite aiguë**
- fièvre
- défense en hypochondre droit
- pas d'ictère
- bilan hépatique normal
- échographie : paroi épaissie > 5 mm, aspect en double contour, volume > 10cm, voies biliaires normales
- complications : gangrène, choc septique, péritonite, fistules
- traitement initial médical = antibiothérapie : C3G + Flagyl® IV
- traitement chirurgical à 48h **Angiocholite aiguë lithiasique**
- douleur, fièvre, ictère
- échographie : dilatation de la voie biliaire principale, calcul dans la voie biliaire principale
- cholestase
- écho-endoscopie = + sensible
- CPRE en urgence : diagnostique et thérapeutique ; sphinctérotomie endoscopique
- antibiothérapie
- :

ITEM N°259 Lithiase urinaire

- calcique, phospho-ammoniac-magnésienne, urique, cystinique
- colique néphrétique
- traitement symptomatique : AINS, antispasmodique, restriction hydrique tant que la douleur persiste, filtrer les urines
- BU + ASP + Echographie des voies urinaires ++++
- complications = anurie, fièvre, hyperalgie -> TDM spirale sans injection + drainage des urines en urgence
- à distance : enquête étiologique +++ : recueil des urines des 24 h, **Creatinine**, ionogramme, bilan phosphocalcique, analyse du calcul
- traitement urologique : si obstruction, infections à répétition, diamètre > 6 mm :
 . lithotritie extra-corporelle . néphrolithotomie percutanée . urétéroscopie
 . chirurgie (pour les calculs coralliformes)
- :

ITEM N°261 Maladie de Parkinson

- syndrome extrapyramidal : triade : tremblement de repos + akinésie + hypertonie plastique
- troubles de la marche, chutes
- troubles neuro-végétatifs : hypotension orthostatique ++
- traitements médicamenteux :
 . L-Dopa : précurseur métabolique de la dopamine ; fluctuation d'activité (effet on/off), DYSKINESIES, dystonies . agonistes dopaminergiques . anticholinergiques
- traitements non médicamenteux : KINESITHÉRAPIE, orthophonie, prévention des chutes +++

Syndromes parkinsoniens

- 90% = maladie de Parkinson
- dus aux neuroleptiques
- maladie de Wilson (y penser chez le sujet jeune)
- dégénératifs : paralysie supra-nucléaire progressive (paralysie de la verticalité), démence à corps de Lewy (hallucinations, chutes, sensibilité aux neuroleptiques), maladie de Huntington, dégénérescence cortico-basale, atrophie multi-systématisée (dysautonomie)
- :

Maladie de Paget (ne figure plus dans le nouveau programme)

- souvent asymptomatique
- vertèbre ivoire ou en cadre : risque de compression médullaire
- atteinte du crâne : risque de compression des nerfs crâniens, de surdité, d'hydrocéphalie



- radiographies : hypertrophie osseuse et corticale, travées grossières, anarchiques, dédifférenciation cortico-médullaire, lésions lytiques et condensantes
- scintigraphie : hyperfixation
- diagnostic différentiel = métastases osseuses condensantes
- complication rare = dégénérescence sarcomateuse
- surveillance : PAL, CTX sériques, radiographies
- traitement : bisphosphonates
- :

ITEM N°262 Migraine et algies de la face

Migraine

- antécédents familiaux
- facteurs déclenchants
- évolution par crises
- examen neurologique normal
- avec ou sans aura : toujours le préciser +++
- durée de la crise = 4 à 72h
- phonophobie
- pas d'examen complémentaire si forme typique
- complication : état de mal migraireux > 72h
- traitement de la crise :
 - . non médicamenteux : repos à l'obscurité . médicamenteux : en première intention : paracétamol, AINS ; en deuxième intention : dérivés de l'ergot de seigle, triptans
- traitement de fond : règles hygiéno-diététiques +++, médicamenteux : bêtabloquants, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques

Névralgie du trijumeau

- essentielle/ secondaire
- zone gâchette
- douleur paroxystique, en éclair, systématisée, unilatérale
- traitement : Tegretol®, thermocoagulation du ganglion de Gasser percutanée

Algie vasculaire de la face

- douleur unilatérale, périorbitaire, violente
- horaire fixe
- troubles vasomoteurs homolatéraux
- évolution épisodique et périodique
- traitement de la crise : Sumatriptan®
- traitement de fond : bêtabloquants, dérivés de l'ergot de seigle
- A/ores :

ITEM N°263 Myasthénie

- fatigabilité musculaire
- ptosis, diplopie, troubles de la déglutition
- risque de l'atteinte respiratoire +++
- test à la prostigmine
- anticorps anti-récepteur à l'acétylcholine
- EMG : phénomène de décrétement ; bloc post-synaptique
- recherche de thymome : TDM cervico-thoracique
- rechercher d'autres maladies auto-immunes
- Gaz du sang, EFR +++
- traitement = anticholinestérasiques
- traitement des poussées graves : plasmaphérèse, immunoglobulines IV
- thymectomie
- éducation +++
- contre-indications médicamenteuses : benzodiazépines, aminosides, quinine...
- crise myasthénique / crise cholinergique : premier réflexe = mettre A JEUN ++, arrêter le traitement anticholinestérasique, hospitaliser en réanimation
- :





ITEM N°264 Néphropathie glomérulaire

- atteinte glomérulaire : protéinurie, hématurie, insuffisance rénale
- syndromes glomérulaires :
 - . syndrome néphrotique : protéinurie > 3 g/24h + albuminémie < 30 g/L . syndrome néphritique : glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique . GNRP : PAM, Wegener, Goodpasture
 - . hématuries récidivantes : maladie de Berger, syndrome d'Alport
- pathologies générales : . diabète +++
 - . LED
 - . paranéoplasique : GEM +++
- LGM : enfant ; syndrome néphrotique pur ; pas de biopsie rénale systématique chez l'enfant ; traitement = corticothérapie ; attention, si albuminémie < 20 g/L -> HBPM +++
- hyalinose segmentaire et focale : PBR systématique
- GEM : première cause de syndrome néphrotique de l'adulte . syndrome néphrotique impur
 - . secondaire : cancers solides, LED, hépatite B, médicaments . complication = thrombose des veines rénales +++
- amylose : coloration au rouge congo
 - . pas de PBR systématique, faire d'abord des biopsies moins invasives : BGSA -GNRP:
 - . syndrome pneumo-rénal . ANCA : Wegener, PAM
 - . Goodpasture : anticorps anti-membrane basale glomérulaire . vascularites

ITEM N°265 Neuropathie périphérique

- syndrome neurogène périphérique : troubles sensitifs, moteurs, trophiques, abolition des ROT
- **EMG** :
 - . atteinte démyélinisante : augmentation des latences distales, bloc de conduction, diminution des vitesses de conduction nerveuses
 - . atteinte axonale : vitesses de conduction normales, diminution de l'amplitude des potentiels d'action, tracé pauvre
- bilan systématique : glycémie, ionogramme, **Creatinine**, bilan hépatique, électrophorèse des protéines sériques, sérologie VIH
- Polyneuropathie : bilatérale et symétrique, distale, évolution ascendante
 - . diabète et alcool +++
- mononeuropathie multiple : asymétrique, asynchrone, atteinte tronculaire
 - . diabète (nerfs crâniens ++), PAN, cryoglobuline
- polyradiculonévrite : Guillain-Barré, maladie de Lyme, botulisme
- :

ITEM N°267 Obésité de l'enfant et de l'adulte

- IMC > 30 ; chez l'enfant : poids > 97^e percentile
- chez l'enfant : âge de rebond de l'IMC < 6 ans = facteur prédictif
- masse grasse : pli cutané brachial
- androïde/gynoïde
- complications : cardio-vasculaires, diabète, syndrome d'apnée du sommeil, psycho-sociales
- enquête alimentaire
- courbe de poids
- traitement :
 - . traitement des facteurs de risque cardio-vasculaires . objectif pondéral
 - . régime hypocalorique équilibré ; chez l'enfant : régime normocalorique +++
 - . activité physique +++
- prise en charge psychologique
- :

ITEM N°268 Pancréatite aiguë

- lipase > 3N fait le diagnostic
- étiologie : alcool et lithiase ++

- www.facebook.com/LetResorDesMedecins |
 www.facebook.com/groups/LetResorDesMedecins |
 www.letresordesmedecins.wordpress.com |
 www.letresordesmedecins.blogspot.com

- Gougerot-Sjögren : syndrome sec : xérostomie
- test de Schirmer + mesure du flux salivaire total

- sarcoïdose
- :

ITEM N°271 Pathologie des paupières

Chalazion

- inflammation des glandes de Meibomius
- nodule inflammatoire du tarse
- récurrences
- traitement médical : pommade antibiotique et corticoïde
- au stade enkysté : traitement chirurgical
- mesures d'hygiène

Orgelet

- infection bactérienne à staphylocoque
- pustule centrée sur un cil
- traitement = antibiotique + corticothérapie locale

Ectropion, entropion

- attention au risque de kératite
- senile, cicatriciel :

ITEM N°272 Pathologie génito-scrotale chez le garçon et chez l'homme Torsion du cordon spermatique

- examen du testicule contralatéral +++
- signe de Prehn négatif ; abolition du réflexe crémasterien
- aucun examen complémentaire : chirurgie en urgence +++
- prévenir le patient du risque d'orchidectomie
- chirurgie : voie d'abord scrotale, exploration, détorsion, vérification de la vitalité du testicule, conservation ou non selon la vitalité, Orchidopexie bilatérale +++

Hydrocele

- transillumination positive
- congénitale : persistance du canal péritonéo-vaginal

Cryptorchidie

- défaut de migration testiculaire
- traitement chirurgical après l'âge de un an
- complications = stérilité, cancer du testicule

Phimosis

- décalottage contre-indiqué : risque de paraphimosis
- traitement local
- :

ITEM N°273 Pathologie hémorroïdaire Hémorroïdes externes

- complication = thrombose hémorroïdaire externe
- séquelle cutanée : marisque
- traitement médical : antalgiques, AINS, bains de siège, régularisation du transit ++
- traitement chirurgical = excision de la thrombose Hémorroïdes internes
- rectorragies rythmées par la défécation
- prolapsus hémorroïdaire
- si échec du traitement médical : ligature élastique Fissure anale
- constipation (cercle vicieux)
- augmentation de la pression de repos du sphincter interne
- douleur en 3 temps rythmée par la défécation
- rectorragie
- diagnostic différentiel = cancer de la marge anale +++
- régulariser le transit +++
- si échec du traitement médical : traitement chirurgical : sphinctérotomie interne latérale
- :





ITEM N°274 Péricardite aiguë

- virale ou idiopathique : risque de récurrence
- tuberculeuse : quadrithérapie anti-tuberculeuse pendant 1 an + corticothérapie ++
- purulente : drainage systématique + antibiothérapie
- néoplasique
- post-IDM
- douleur thoracique augmentée à l'inspiration ; fièvre
- auscultation : frottement péricardique systolo-diastolique
- ECG : sus-décalage du ST concave en haut, dans toutes les dérivations ; micro-voltage = épanchement abondant
- radio de thorax : Cardiomegalie
- ETT : fait le diagnostic
- sérologie VIH avec accord du patient
- attention au risque de TAMPONNAGE +++ : . adistolie aiguë
- . insuffisance cardiaque droite, pouls paradoxal . alternance électrique à l'ECG
- . urgence thérapeutique : drainage chirurgical + remplissage vasculaire ; contre-indication des anti-coagulants +++ - complication à long terme = péricardite constrictive
- :

ITEM N°275 Péritonite aiguë

- contracture abdominale : diagnostic clinique
- fièvre
- touchers pelviens : douleur dans le cul de sac de Douglas
- ASP : pneumopéritoine, grisaille diffuse
- bilan infectieux : hémocultures ++
- urgence chirurgicale : laparotomie, traitement étiologique, toilette péritonéale, drainage ; attention : pas d'anastomose en milieu septique +++
- antibiothérapie
- :

ITEM N°276 Pneumothorax

- spontané idiopathique du sujet jeune longiligne : blebs / bulles
- secondaire : BPCO, asthme, maladies interstitielles, iatrogène
- syndrome d'épanchement gazeux : tympanisme, abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales
- radio de thorax : hyperclarté limitée par une ligne pleurale
- 5 signes de gravité +++ : . compression
- . bilatéralité . bride
- . niveau liquide (hémopneumothorax) . anomalie du parenchyme sous-jacent
- drainage + oxygénothérapie nasale
- surveillance : bullage, radio de thorax quotidienne
- information sur le risque de récurrence +++
- si récurrence : symphyse chirurgicale par talcage :

ITEM N°277 Polykystose rénale

- autosomique dominante
- échographie rénale
- arbre généalogique ; enquête familiale
- insuffisance rénale lentement progressive
- HTA
- complications : hématurie, douleurs, lithiases, infection
- anévrismes des artères cérébrales +++ : angio-IRM si antécédents familiaux d'hémorragie méningée
- diverticulose colique
- Nofes :

ITEM N°278 Psychose et délire chronique

Schizophrénie

- syndrome dissociatif :
 - . barrages, fadding mental, néologisme, rationalisme morbide, athymormie
 - . syndrome catatonique : apragmatisme, négativisme moteur, inertie psychomotrice, catalepsie
- délire paranoïde :
 - . syndrome d'influence, thèmes et mécanismes multiples
- syndrome autistique
- formes cliniques : paranoïde, hébéphrénique, héboïdophrénique, catatonique, dysthymique
- risque suicidaire +++
- neuroleptique antiproductif et anti-déficitaire

Psychose hallucinatoire chronique

- automatisme mental
- syndrome d'influence
- mécanisme hallucinatoire
- retentissement sur la vie sociale
- neuroleptique anti-délirant

Paraphrénie

- mécanisme imaginatif
- thèmes mégalomaniques
- confabulente / fantastique
- bonne adaptation sociale

Psychoses paranoïaques

- personnalité paranoïaque ou sensitive
- pas d'HDT ++++ : HO uniquement
- délires passionnels :
 - . mécanisme interprétatif, systématisé en secteur
 - . de revendication, de jalousie, érotomaniaque
- paranoïa :
 - . persécution
 - . mécanisme interprétatif
- :

ITEM N°279 Radiculalgie et syndrome canalaire Sciatique

- urgences chirurgicales = déficit moteur < 3, syndrome de la queue de cheval
- mécanique : hernie discale ++
- syndrome rachidien, signe de la sonnette, signe de Lasègue +++
- pas de radio en première intention
- canal lombaire étroit : claudication à la marche
- traitement : repos, AINS, antalgiques, myorelaxants, KINESITHERAPIE +++ : rééducation lombo-pelvi-abdominale
- si échec : infiltration épidurale de corticoïdes
- si échec à 6-8 semaines : TDM ou IRM en vue d'un traitement chirurgical

Névralgie cervico-brachiale

- urgences : paralysie, compression médullaire
- arthrose cervicale
- radios systématiques : face + profil ³A
- Syndrome du canal carpien**
- acroparesthésies nocturnes dans le territoire du nerf médian
- examen bilatéral
- signes de Tinel et de Phalen
- examen neurologique
- EMG : diminution des vitesses de conduction nerveuses, augmentation des latences distales
- traitement médical : infiltration cortisonique
- si échec ou déficit neurologique : traitement chirurgical = section du ligament annulaire antérieur du carpe et neurolyse du nerf médian
- :



ITEM N°281 Rétrécissement aortique

- serré : surface $< 1 \text{ cm}$ ou $0,6 \text{ cm}^2/\text{m}^2$; gradient moyen VG / aorte $> 40 \text{ mmHg}$
- symptômes d'effort
- souffle méso-systolique, dur, râpeux, maximum au foyer aortique, irradiant dans les carotides ; si RA serré : abolition du B2 au foyer aortique
- ECG : HVG systolique

Reflux gastro-œsophagien chez le nourrisson, chez l'enfant et chez l'adulte. Hernie hiatale RGO chez l'adulte

- facteurs favorisants : hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage, hernie hiatale
 - pyrosis + régurgitations acides
 - en première intention : pas d'examen complémentaire
 - indication d'une FOGD : âge > 50 , signes d'alarme (hémorragie, dysphagie...), résistance au traitement médical, symptômes atypiques -> recherche une œsophagite
 - ph-métrie œsophagienne si échec du traitement ou symptômes atypiques avec FOGD normale
 - complications : ulcère, hémorragie digestive, sténose peptique, endobrachyœsophage : risque d'adénocarcinome +++
 - anti-sécrétoire : IPP (Mopral®)
 - traitement chirurgical : fundoplicature = mécanisme anti-reflux **RGO du nourrisson**
 - première cause de vomissement chronique
 - diagnostic d'élimination
 - vomissements post-prandiaux
 - après changement de position ++
 - complications : œsophagite, hémorragie digestive, retard staturo-pondéral, asthme, malaises
 - si symptômes extra-digestifs : ph-métrie
 - FOGD si suspicion d'œsophagite
 - rassurer les parents
 - épaissir l'alimentation
 - proclive dorsal 30°
 - anti-acides
 - si complication : IPP, pro-kinétique
- Wofes :
- ECG d'effort : si RA serré asymptomatique ; contre-indiqué si symptomatique +++
 - bilan pré-opératoire : remplacement valvulaire aortique
 - attention au risque d'ENDOCARDITE ++
 - complication = mort subite +++ :

ITEM N°282 Spondylarthrite ankylosante

- spondylarthropathies : ankylosante, arthrites réactionnelles, rhumatisme psoriasique, MICI
- HLA B27
- antécédents familiaux
- douleur fessière à bascule
- atteinte rachidienne
- talalgies
- uvéite antérieure
- orteil en saucisse
- atteinte sacro-iliaque : signe du trépied
- mesure de l'augmentation thoracique +++
- radio : syndesmophytes, sacro-ilite
- complications extra-articulaires : troubles de la conduction, insuffisance aortique, néphropathie à IgA, amylose AA
- traitement : AINS, infiltration de corticoïdes, kinésithérapie
- traitement de fond : methotrexate, anti-TNF Noies :

ITEM N°283 Surveillance d'un malade sous plâtre

- déplacement secondaire -> radio de contrôle
- raideur-> kinésithérapie, rééducation

- Osteoporose
- algodystrophie
- thrombose veineuse profonde -> prophylaxie : HBPM
- syndrome des loges
- surveillance :
 , clinique : douleur, couleur, chaleur locale, œdème, examen neurologique ; si anomalie : réfection du plâtre . paraclinique : radio de contrôle, plaquettes si HBPM

ITEM N°284 Troubles de la conduction intra-cardiaque

- syncope = trouble de haut degré
- si ECG normal : holter, explorations électrophysiologiques endocavitaires
- traitement = pacemaker
- bloc sino-auriculaire : absence d'onde P intermittente (type 2), permanente (type 3)
- BAV 1 : PR > 0,2 secondes
- BAV 2 : Mobitz 1 : augmentation progressive du PR jusqu'à une onde P bloquée ; Mobitz 2 : onde P bloquée de manière intermittente et régulière
- BAV 3 : dissociation auriculo-ventriculaire complète
- blocs de branche complets : QRS > 0,12 secondes :
 . gauche : M en V6 QS en V1
 . droit : M en V1 onde S traînante en V6
- blocs de branche incomplets : QRS entre 0,08 et 0,12 secondes :
 . hémibloc antérieur gauche : déviation axiale gauche, aspect Q1S3 . hémibloc postérieur gauche : déviation axiale droite, aspect S1Q3
 :

ITEM N°285 Troubles de l'humeur. Troubles bipolaires

- antécédents familiaux ++
- maladie bipolaire : types 1, 2, 3, dépressions récurrentes, trouble à cycles rapides

Accès mélancolique

- risque suicidaire +++
- présentation : pauvreté de la mimique
- trouble de l'humeur : douleur morale, tristesse, anhédonie, dévalorisation
- ralentissement psychomoteur : bradypsychie, apragmatisme
- désir de mort
- troubles somatiques : insomnie, anorexie
- syndrome de Cottard : mélancolie délirante : négation d'organe et du monde, damnation
- traitement : antidépresseurs tricycliques, neuroleptique sédatif en prévention de la levée d'inhibition motrice, hypnotique

Accès maniaque

- présentation : agitation, logorrhée
 - contact : familiarité
 - troubles du contenu de la pensée : délire
 - exaltation de l'humeur : euphorie, labilité thymique
 - excitation psychomotrice
 - troubles somatiques
 - traitement : thymorégulateur (lithium), neuroleptique sédatif, hypnotique
 - sauvegarde de justice +++
- /Votes :

ITEM N°286 Troubles de la personnalité

- schizoïde : froideur, détachement, émoussement affectif, indifférence
- évitante : timidité
- histrionique : séduction, théâtralisme, suggestibilité
- obsessionnelle : perfectionnisme, méticulosité, ponctualité
- dépendante
- borderline : relations intenses et instables, impulsivité



- antisociale : agressivité, actes illégaux, irresponsabilité, absence de remords
- paranoïaque : persécution, méfiance, inadaptabilité sociale, rancune, surestimation du moi
- :

ITEM N°287 Trouble de la réfraction

- échelle de Monoyer : acuité visuelle de loin
- échelle de Parinaud : acuité visuelle de près
- mesure objective : skiascopie
- hypermétropie : . axile / d'Indice
- . baisse de l'acuité visuelle de près
- . facteur de risque de GAFA
- . traitement = verres correcteurs convergents
- myopie :
- . axile / d'indice
- . baisse de l'acuité visuelle de loin
- . facteur de risque de décollement de rétine
- . traitement = verres correcteurs concaves
- astigmatisme :
- . perte de la sphéricité de la cornée
- . traitement = verres correcteurs cylindriques
- presbytie :
- . baisse physiologique du pouvoir accommodatif du cristallin après 40 ans
- . baisse de l'acuité visuelle de près . traitement = verres convergents
- :

ITEM N°288 Troubles des phanères

- alopecie :
- . diffuse : effluvium télogène, carencielle, hypothyroïdie, androgénétique . localisée : non cicatricielle : pelade, teigne / cicatricielle : infectieuse, traumatique, lichen plan
- onychopathies :
- . attention au mélanome unguéal : mélanonychie chez un sujet de race blanche -> biopsie ++
- . psoriasis : dépressions ponctuées en dé à coudre, hyperkératose, onycholyse . onychomycoses
- :

ITEM N°289 Troubles somatoformes

- altérations organiques objectivables ou manifestations fonctionnelles
- échelle d'alexithymie
- événement de vie
- profils de personnalité à risque : type A : HTA, IDM ; type C : cancers, dysImmunité
- traitements : psychothérapie ; psychotropes : antidépresseurs, anxiolytiques ...
- :

ITEM N°290 Ulcère gastrique et duodénal

- facteurs étiologiques : Helicobacter pylori, AINS
- diagnostic positif : FOGD + biopsies
- risque de cancer seulement pour les ulcères gastriques
- traitement :
- . règles hygiéno-diététiques
- . éradication d'Helicobacter pylori : antibiothérapie double + IPP double dose pendant 7 jours
- . puis IPP simple dose pendant 3 semaines si ulcère duodénal ; 5 semaines si ulcère gastrique
- contrôle de l'éradication :
- . pour un ulcère gastrique : FOGD 4 semaines après le traitement + biopsies
- . pour un ulcère duodénal : test respiratoire à l'urée
- contrôle de la cicatrisation si ulcère gastrique : FOGD 4 semaines après le traitement
- Complications :
- sténose pyloro-duodénale : vomissements chroniques alimentaires post-prandiaux
- hémorragie digestive : FOGD en urgence chez un patient stable sur le plan hémodynamique



- perforation : facteur de risque = AINS +++ FOGD contre-indiquée ++ . si ulcère duodénal : simple suture ; si ulcère gastrique : excision-suture

Gastrite

- diagnostic histologique : FOGD + biopsies
- chronique à *Helicobacter pylori*
- auto-immune atrophique : maladie de Biermer : carence en vitamine B12 +++:
 - . anticorps anti-cellules pariétales et facteur intrinsèque . risque d'adénocarcinome gastrique
 - . traitement = vitamine B12 IM + surveillance de la FOGD / 3 ans

:

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT

ITEM N°291 Adénopathie superficielle

- examen de toutes les aires ganglionnaires +++
- rechercher une hépato-splénomégalie
- rechercher une porte d'entrée cutanée : examen du territoire de drainage
- interrogatoire : facteurs de risque de MST, voyage, contact avec le BK, alcool, tabac
- bilan : NFS, VS, radio de thorax, IDR, sérologies
- ponction à l'aiguille
- échographie de l'aire concernée
- si intoxication alcool-tabagique et adénopathie cervicale : pan-endoscopie des voies aériennes supérieures
- étiologies principales :
 - . infectieuses : pyogènes, BK, maladie des griffes du chat, syphilis, VIH, toxoplasmose . métastases
 - . hémopathie maligne : lymphome ++

:

ITEM N°292 Algies pelviennes chez la femme

- aiguës :
 - . GEU +++
 - . torsion d'annexé sur kyste ovarien
- cycliques :
 - . dysménorrhée
 - . syndrome intermenstruel et syndrome prémenstruel
- chroniques :
 - . endométriose : douleur, dysménorrhée, dyspareunie

:

ITEM N°293 Altération de la fonction visuelle

- examen bilatéral et comparatif
- baisse de l'acuité visuelle aiguë :
 - . œil rouge et douloureux : kératite, GAFA, uvéite antérieure, corps étranger intra-oculaire
 - . œil blanc et indolore : hémorragie intra-vitréenne, hyalite, OACR, OVCR, NOIAA, NORB, DMLA exsudative, décollement de rétine, cécité monoculaire transitoire
- baisse de l'acuité visuelle progressive : . DMLA
 - . glaucome chronique à angle ouvert
 - . rétinopathie diabétique : œdème maculaire cystoïde
 - . maculopathie toxique : antipaludéens de synthèse, éthambutol
- altération du champ visuel = scotome : . NORB
 - . NOIAA : altitudinal
 - . neuropathie optique éthylique : bilatéral
 - . syndrome chiasmatique : hémianopsie bitemporale +++

:





ITEM N°294 Altération de la fonction auditive

- examen bilatéral ++
- acoumétrie : diapason : tests de Weber et de Rinne
- otoscopie +++
- audiometrie tonale : conduction aérienne et osseuse ; écart entre CA et CO = surdité de transmission
- audiometrie vocale
- impédancemétrie = tympanométrie + étude du réflexe stapédien

Oreille externe

- bouchon de cérumen ++

Oreille moyenne

- tympan normal : otospongiose :
- ankylose de l'étrier sur la fenêtre vestibulaire . épreuve de Lewis négative : conduction osseuse > conduction cartilagineuse . réflexe stapédien aboli . TDM des rochers
- tympan anormal :
- otite sérumuqueuse : aspect du tympanogramme caractéristique, traitement = aérateurs trans-tympaniques ; chez l'adulte : attention au cancer de cavum ++
- otite chronique cholestéatomateuse : masse blanc nacré dans la caisse du tympan ; TDM des rochers ++

Oreille interne :

- surdité unilatérale ou asymétrique : neurinome de l'acoustique : surdité de perception, IRM cérébrale : tumeur de l'angle pontocérébelleux
- surdité bilatérale : presbyacousie +++

ITEM N°295 Amaigrissement

- perte de poids > 5% du poids de base en moins de 6 mois = dénutrition
- iatrogénie
- enquête alimentaire
- penser au VIH chez le sujet jeune
- rechercher un cancer chez le sujet de plus de 50 ans
- anorexie mentale
- syndrome dépressif
- troubles digestifs : malabsorption, maladie cœliaque, MICI
- troubles endocriniens : diabète, hyperthyroïdie
- bilan : NFS, VS, ionogramme, créafmine, glycémie, calcémie, bilan hépatique, TSH, albumine, pré-albumine
- chez le sujet âgé : examiner la cavité buccale +++ :

ITEM N°296 Aménorrhée secondaire

- arrêt des règles depuis plus de 3 mois
- signes cliniques à rechercher : galactorrhée, hyperandrogénie, carence œstrogénique
- courbe de température sur 3 mois
- échographie pelvienne
- test aux progestatifs
- etiologies :
- utérines : **Synechie**, sténose cicatricielle . ovariennes : ménopause
- hypophysaire : hyperprolactinémie ++, syndrome de Sheehan . hypothalamique : post-pilule, psychogène, anorexie mentale

Aménorrhée primaire

- absence de ménarche après 16 ans
- évaluation des caractères sexuels secondaires +++
- âge osseux
- échographie pelvienne
- dosages hormonaux
- si retard statural associé : caryotype +++

- syndrome de Turner
- hyperplasie congénitale des surrénales Wofes :

ITEM N°297 Anémie

- VGM : micro ou macrocytaire
- reticulocytes +++
- reticulocytes < 100 000 = arégénérative -> myélogramme
- anémie macrocytaire carentielle :
. myélogramme : moelle riche, érythroblastes nombreux, mégalo-blastes . dosages : folates sériques et érythrocytaires, vitamine B12 . etiologies : maladie de Biermer, malabsorption, dénutrition
- anémie hémolytique :
. bilan : baisse de l'haptoglobine, élévation des reticulocytes, de la bilirubine, des LDH, frottis sanguin : recherche de schizocytes . corpusculaire : sphérocytose héréditaire, déficit en G6PD, hémoglobinopathies : thalassémie, drépanocytose . extra-corpusculaire : auto-immune -> test de Coombs positif, mécanique (prothèse valvulaire, MAT), infectieuse, toxique . hémolyse chronique -> échographie abdominale à la recherche de lithiase biliaire, traitement systématique par folates
- anémie microcytaire : carence martiale, inflammatoire, thalassémie A/ores

ITEM N°298 Ascite

- matité décline à limite supérieure concave vers le haut, mobile
- ponction d'ascite systématique : cytologie, biochimie, bactériologie
- complications : mécaniques, infection, troubles hydro-électrolytiques
- liquide pauvre en protéides < 25 g/L :
. cirrhose
. anasarque : dénutrition, syndrome néphrotique, insuffisance cardiaque
- liquide riche en protéides > 25 g/L : . carcinose péritoneale
. tuberculose . Budd Chiari
- ascite chyleuse
- maladie gélatineuse du péritoine
:

ITEM N°299 Boiterie et troubles de la démarche chez l'enfant

- 2 diagnostics à redouter : infections ostéo-articulaires et tumeurs **Epiphysiolyse fémorale supérieure**
- adolescent
- attitude vicieuse : raccourcissement, adduction, rotation externe ; rotation interne limitée
- radio : ligne de Klein au dessus du sommet de la tête
- risque = ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
- chirurgie en urgence : pas de réduction ; ostéosynthèse bilatérale ++ **Ostéochondrite primitive de hanche**
- nécrose ischémique de la tête fémorale
- enfants obèses
- attitude vicieuse : raccourcissement, rotation externe
- radios : normales au début ++
- 4 stades : condensation du noyau, fragmentation, réossification, déformation en coxa plana
- scintigraphie osseuse ++ : hypofixation lacunaire
- traitement orthopédique : mise en décharge prolongée **Rhume de hanche = synovite aiguë transitoire**
- Infection des voies aériennes supérieures récente
- diagnostic d'élimination
- radio normale
- échographie : épanchement articulaire
- contrôle radiologique et clinique à 6 semaines pour éliminer une ostéochondrite débutante +++



ITEM N°300 Constipation chez l'enfant et l'adulte (avec le traitement)

Chez l'enfant

- date d'apparition du meconium ; si retard : Hirschsprung, hypothyroïdie, mucoviscidose
- interrogatoire nutritionnel
- courbe staturo-pondérale +++
- fonctionnelle / organique
- prise en charge diététique +++ : augmenter l'apport en fibres

Maladie de Hirschsprung

- ASP : niveaux hydro-aériques ; absence d'air dans le rectum
- lavement opaque : zone de disparité de calibre
- manométrie rectale : absence de réflexe recto-anal inhibiteur
- biopsies rectales profondes à la pince de Noblett

Chez l'adulte

- fréquence des selles < 3 par semaine
- attention au risque de cancer : coloscopie si âge > 40 ans ou signes d'alarme
- iatrogénie : antidépresseurs, opiacés ...
- métabolique : hypothyroïdie
- dyschésie = trouble de l'évacuation rectale
- règles hygiéno-diététiques
- laxatifs osmotiques :

ITEM N°301 Déficit moteur et /ou sensitif des membres

Glycémie +++

Déficit moteur

- périphérique :
 - . syndrome neurogène périphérique
 - . syndrome myogène : déficit proximal ; élévation des enzymes musculaires ; EMG . syndrome myasthénique
- central :
 - . syndrome pyramidal : hypertonie spastique, ROT vifs, polycinétiques, diffusés, signe de Babinski positif
 - . syndrome extrapyramidal
 - . syndrome cérébelleux : statique (élargissement du polygone, danse des tendons) ; cinétique (dysmétrie, asynergie, adiadicocinésie)

Déficit sensitif

- système lemniscal : tact, proprioception
- système extra-lemniscal : thermo-algique
- syndrome thalamique : sensations douloureuses de l'hémicorps controlatéral
- topographie +++ : tronculaire, radiculaire, plexique
- :

ITEM N°302 Diarrhée aiguë chez l'enfant et chez l'adulte (avec le traitement)

Chez l'adulte

- interrogatoire : prise médicamenteuse (antibiotiques ++), voyage, contexte de TIAC
- syndrome dysentérique = diarrhée invasive
- syndrome cholériforme = diarrhée sécrétoire
- syndrome rectal = ténésmes, épreintes, fausses envies
- notion de fièvre
- coprocultures, examen parasitologique des selles, sérologies

- rectosigmoïdoscopie systématique si syndrome dysentérique ou si diarrhée post-antibiotiques
- diarrhée post-antibiotiques : rechercher les toxines de C. Difficile dans les selles = colite pseudo-membraneuse ; traitement = arrêt des antibiotiques responsables + metronidazole
- chez le sujet âgé avec facteurs de risque cardio-vasculaires, penser à la colite ischémique
- traitement : REHYDRATATION +++, ± antibiothérapie (fluoroquinolones)
- pas de ralentisseur du transit dans les syndromes dysentériques +
- penser à la déclaration obligatoire pour certaines diarrhées

Chez l'enfant

- attention au risque de déshydratation +
- examen clinique : premier élément = hémodynamique : temps de recoloration cutané
- poids +
- première cause = gastro-entérite aiguë (rotavirus)
- traitement : . à jeun
- . réhydratation : soluté de réhydratation orale ; si perte de poids > 10% : réhydratation IV 150 ml/kg/j
- . réalimentation 6h après une hydratation exclusive : hydrolysats de protéine de lait de vache chez le moins de 3 mois ; lait sans lactose si diarrhée sévère
- . traitement symptomatique = anti-sécrétoire : Tlorfan® . si hospitalisation : penser à l'isolement +

ITEM N°303 Diarrhée chronique

Diarrhée motrice

- test au rouge carmin : première selle avant 6-8 h
- tumeur carcinoïde
- hyperthyroïdie
- trouble fonctionnel intestinal +

Diarrhée de malabsorption

- stéatorrhée > 6 g/24h
- syndrome carenciel +
- maldigestion : insuffisance pancréatique, insuffisance biliaire
- maladie cœliaque :
 - . anticorps anti-gliadine, endomysium et TG
 - . FOGD = bleu de méthylène (aspect de mosaïque) + biopsies
 - . atrophie villositaire
 - . traitement = régime sans gluten à vie
 - . complication = lymphome T du grêle

Diarrhée exsudative

- hypoprotidémie -MICI
- augmentation de la clearance fécale de l'alpha anti-trypsin

Diarrhée osmotique

- maladie des laxatifs +
- risque d'hypokaliémie +
- coloscopie : mélanose, aspect tubulé du colon

Diarrhée sécrétoire

- persiste à jeun
- prise d'AINS ou de veinotoniques
- syndrome de Zollinger Ellison

Chez l'enfant

- courbe staturo-pondérale +
- maladie cœliaque
- allergie aux protéines de lait de vache : atopie, prick tests
- mucoviscidose -MICI





ITEM N°304 Diplopie

- préciser les caractéristiques : . binoculaire / monoculaire . horizontale, verticale, oblique
 - examen de l'oculomotricité +++
 - réflexe photomoteur, symétrie des pupilles
 - cover test
 - examen au verre rouge -TEST DE LANCASTER
 - paralysie complète et douloureuse du III : attention à l'anévrisme intracrânien +++
 - contexte de traumatisme -> fracture du plancher de l'orbite avec incarceration du muscle droit inférieur
 - hypertension intracrânienne : atteinte du VI non localisatrice
- /Notes :

ITEM N°305 Douleur buccale

- examen endobuccal
- panoramique dentaire
- douleur dentaire et gingivale : carie, pulpite, parodontite, abcès, accident d'évolution d'une dent de sagesse...
- ulcération : si chronique, redouter un cancer +++ -> biopsie
- mycoses
- lithiase salivaire
- zona :

ITEM N°306 Douleur des membres et des extrémités

- caractéristiques de la douleur : HORAIRE, siège, type, intensité, évolution, retentissement...
 - horaire inflammatoire : 1^{er} diagnostic à évoquer = arthrite septique +++
 - examen bilatéral et comparatif
 - étiologies : ostéo-articulaire, musculaire, vasculaire, neurologique ...
 - hanches :
 - . ostéonécrose aseptique . algodystrophie . coxarthrose
 - genou :
 - . penser à examiner la hanche ++ (douleur projetée) . chondrocalcinose articulaire
 - . atteinte méniscale . gonarthrose - épaule :
 - . pathologie abarticulaire +++ : tendinite du supra-épineux
 - . rupture de la coiffe des rotateurs
 - . manœuvres (Jobe, Patte, palm-up test, lift-off test)
- A/ores ;

ITEM N°307 Douleur et épanchement articulaire

- mécanique / inflammatoire +++
- genou : choc rotulien, signe du flot
- radio standards systématiques avant toute ponction articulaire +++
- ponction articulaire : examen cytologique, biochimique et bactériologique
- liquide inflammatoire / mécanique
- douleur inflammatoire avec liquide mécanique et VS normale = algodystrophie

Arthrite d'évolution récente

- préciser les caractéristiques ++ : . mono/ oligo / polyarthrite
- . aiguë / subaiguë / chronique
- signes radiologiques : déminéralisation, érosions, tuméfaction des parties molles, pincement diffus de l'interligne, absence d'ostéophyte
- éliminer en priorité une arthrite septique : bilan infectieux
- si arthrite septique, rechercher une splénomégalie et un souffle : ENDOCARDITE ++
- bilan immunologique : facteur rhumatoïde, FAN, complément... :



ITEM N°308 Dysphagie

- cancer des voies aéro-digestives supérieures +++
- FOGD systématique
- organique (aux solides) / fonctionnelle (aux liquides)
- dénutrition, amaigrissement
- risque de Pneumopathie d'inhalation
- rechercher une intoxication alcool-tabagique à l'interrogatoire
- dysphagie fonctionnelle = trouble moteur de l'œsophage : sclérodermie, mégaoesophage idiopathique -> manométrie : diminution du péristaltisme, augmentation de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, absence de relaxation du SIO lors de la déglutition
- autres causes : corps étranger, infection, diverticules, sténose peptique, sténose cicatricielle sur œsophagite caustique, troubles neurologiques ...
- :

ITEM N°309 Electrocardiogramme : indications et interprétations

- valeurs normales : P < 0,12s, PR < 0,20s, QRS < 0,08s
- rythme : sinusal ou non
- fréquence cardiaque : tachycardie, bradycardie
- axe :
 - . gauche : hypertrophie ventriculaire gauche, bloc de branche gauche, hémibloc antérieur gauche
 - . droit : hypertrophie ventriculaire droite, hémibloc postérieur gauche
- hypertrophie ventriculaire gauche : S en V1 + R en V5 > 35 mm
- onde Q pathologique si > 1/3 de l'amplitude de l'onde R = nécrose
- sous-décalage de ST : lésion sous-endocardique (angor)
- sus-décalage de ST : SCA ST + (lésion sous-épicaudique), pericardite :

ITEM N°310 Elévation de la créatininémie

- formule de Cockcroft : clearance (ml/min) = $(140 - \text{âge}) \times \text{poids} \times F / \text{creatinine}$; avec F = 1,25 chez l'homme et 1,05 chez la femme
- clearance > 90 = normale ; 60-90 = insuffisance rénale débutante ; 30-60 = insuffisance rénale modérée ; 15-30 = insuffisance rénale sévère ; < 15 = insuffisance rénale terminale
- insuffisance rénale aiguë : diurèse ? : conservée ou anurie +++
- étiologie :
 - . obstructive : échographie rénale systématique . fonctionnelle : contexte
 - . organique : glomérulaire, interstitielle, tubulaire, vasculaire
- :

ITEM N°311 Eosinophilic

- PN éosinophiles > 500 /mm³
- étiologies :
 - . parasitoses : examen parasitologique des selles, sérologies . allergies
 - . hémopathies : leucémie myéloïde chronique, maladie de Hodgkin . maladies de système : PAN, Churg et Strauss, LED . maladie des embolies de cholestérol . hyperéosinophilie primitive
- complications propres :
 - . cardiopathies : fibrose
 - . pulmonaires : toux, asthme . neurologiques :

ITEM N°312 Epanchement pleural

- syndrome d'épanchement liquidien : matité hydrique, abolition du murmure vésiculaire et des vibrations vocales, souffle pleurétique
- radio de thorax : opacité dense et homogène, décline, à limite supérieure concave en haut et en dehors (ligne de Damoiseau), prolongée par une ligne bordante axillaire
- ponction pleurale systématique : examen macroscopique, cytologique, biochimique et bactériologique
- biopsie pleurale si suspicion de néoplasie ou de tuberculose

- pleurésie à liquide clair :
 - . transsudat : protides < 30 g/L : insuffisance cardiaque, insuffisance hépato-cellulaire, syndrome néphrotique . exsudat : protides > 30 g/L : néoplasie, tuberculose, parapneumonique, embolie pulmonaire
- pleurésie purulente : terrain débilité ++ :
 - . bilan : TDM thoracique ; fibroscopie bronchique ; examen ORL +++ . chez l'enfant : staphylococcie pleuro-pulmonaire
 - traitement : . drainage
 - . KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE +++ . pour les pleurésies purulentes : antibiothérapie, ponction-lavages quotidiens, fibrinolytiques, traitement de la porte d'entrée ++
 - :

ITEM N°313 Epistaxis (avec le traitement)

- clinique : hémodynamique +++ (comme pour toute hémorragie)
- à l'interrogatoire : prises médicamenteuses : anticoagulants ++
- étiologie : essentielle, traumatique, trouble de l'hémostase, HTA, tumeur (fibrome naso-pharyngien)
- traitement = hémostase locale :
 - . mouchage puis compression bidigitale pendant 10 minutes . si échec : tamponnement antérieur = méchage ; si trouble de l'hémostase : utiliser des mèches résorbables (Surgicel®) . si échec : sonde à double ballonnet (tamponnement postérieur) . si échec : injection locale de produits sclérosants puis radiologie interventionnelle (embolisation) ou chirurgie (ligature)
 - à distance : cautérisation Wores :

ITEM N°314

Exanthème

- toxidermie ++
- infection virale
- scarlatiniforme : scarlatine, staphylocoque, Kawasaki
- morbilliforme : rougeole, rubéole, mégalérythème épidémique, VIH, mononucléose
- roséoliforme : syphilis secondaire, exanthème subit du nourrisson, fièvre typhoïde

Erythrodermie

- pas d'intervalle de peau saine
- attention aux complications : troubles hydro-électrolytiques, surinfection +++
- psoriasis
- eczéma
- médicamenteuse
- lymphome cutané T
- idiopathique Wores :

ITEM N°315 Hématurie

- diagnostic : bandelette urinaire ; examen cytologique des urines : GR > 10 /mm³
- urologique : caillots, douleur, signes fonctionnels urinaires
 - . cancer de vessie, cancer du rein, infection, lithiase, cancer de la prostate, tuberculose, bilharziose...
- néphrologique : glomérulaire : cylindres hématiques
 - . maladie de Berger, glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, GNMP, GNRP, polykystose rénale
- bilan : ECBU, créatinine, protéinurie des 24 h, échographie rénale et vésicale
- :

ITEM N°316 Hémogramme : indications et interprétation

- en urgence : angine ulcéro-nécrotique, fièvre après chimiothérapie, hémorragie, purpura
- surveillance médicamenteuse : héparine, néomercazole, chimiothérapie
- lors de la grossesse : à M6

- valeurs normales :
 - . Hb : chez l'homme : 13-17 g/dl chez la femme : 12-16 g/dl . VGM : 82-98 p³
 - . plaquettes : 150000-400000 /mm³ . GB : 4000-10000/mm³
- hyperlymphocytose : lymphocytes > 4000 /mm³ : infection, syndrome mononucléotique, LLC, lymphome
- myélémie : infection, inflammation, régénération, syndrome myéloprolifératif
- neutropénie : PNN < 1500 /mm³ : médicaments, infection, insuffisance médullaire
- thrombocytose : plaquettes > 500000 /mm³ : thrombocytemie essentielle, splénectomie, carence martiale
- frottis sanguin : drépanocytes, corps de Jolly (asplénisme, splénectomie), schizocytes (hémolyse mécanique), corps de Heinz (splénectomie, déficit en G6PD)

ITEM N°317 Hémoptysie

- rejet de sang rouge aéré par la bouche au cours d'un effort de toux, provenant des voies aériennes sous-glottiques
- clinique : hémodynamique +++, détresse respiratoire
- ECG, radio de thorax, gaz du sang +++ systématiques
- fibroscopie bronchique systématique + hémostase locale
- TDM thoracique
- étiologie : cancer broncho-pulmonaire, tuberculose...
- traitement :
 - . vasoconstricteur : Glypressine® IV . si échec : embolisation
 - . si échec ou hémorragie cataclysmique : intubation sélective + ventilation mécanique

ITEM N°318 Hépatomégalie et masse abdominale

- hépatomégalie : cirrhose, hémochromatose, maladie de Wilson, métastases, cholestase, foie cardiaque, abcès ...
- masse abdominale : cancers colique, pancréatique, gastrique ...anévrisme de l'aorte abdominale

ITEM N°319 Hypercalcémie (avec le traitement)

- calcémie > 2,6 mmol/L
- CALCEMIE CORRIGEE +++ = calcémie mesurée + 0,02 X (40-albuminémie) mmol/L
- hyperparathyroïdie primaire :
 - . hypercalcémie, hypophosphorémie, hypocalciurie . adénome, hyperplasie, adénocarcinome . NEM I et Ma
 - . échographie cervicale ; scintigraphie au MIBI
- causes malignes : syndrome paranéoplasique, métastases ostéolytiques, myélome
- ECG +++ : aplatissement des ondes T, raccourcissement du QT, troubles de la conduction, troubles du rythme
- traitement de l'hypercalcémie aiguë :
 - . hospitalisation en réanimation si > 3,5 mmol/L
 - . réhydratation massive +++
 - . bisphosphonates IV
 - . corticothérapie si myélome
 - . si traitement digitalique : arrêt +++

ITEM N°320 Ictère

- étiologie : extra-hépatique / intra-hépatique
- ictère cholestatique : urines foncées, selles décolorées
- prurit

- syndrome de cholestase : augmentation de la bilirubine totale, de la bilirubine conjuguée, des PAL et des yGT
- complication tardive = cirrhose biliaire secondaire
- ictères non cholestatiques : maladie de Gilbert, hyperhémolyse
- échographie abdominale +++ : recherche une dilatation des voies biliaires
- causes extra-hépatiques : pancréatite chronique, cancer de la tête du pancréas, cholangite sclérosante, lithiase de la voie biliaire principale
- causes intra-hépatiques : cirrhose, stéatose, kyste hydatique, métastases, carcinome hépatocellulaire, abcès, hépatites
- :

ITEM N°321 Incontinence urinaire de l'adulte Chez la femme

- incontinence d'effort : cervicocystoptose ou insuffisance sphinctérienne
- incontinence par impériosités : irritation vésicale, obstacle, contractions vésicales non inhibées
- incontinence permanente : fistule uro-vaginale ou déficit sphinctérien majeur
- interrogatoire : abondance des fuites, retentissement
- manœuvre de Bonney : si positive = cervicocystoptose
- rechercher un prolapsus
- examen neurologique
- trophicité vulvo-vaginale
- BU et ECBU systématiques
- échographie pelvienne et rénale : résidu post-miction nel, dilatation des cavités pyélocalicielles
- bilan uro-dynamique : débimétrie, cystomanométrie, profilométrie uretrale
- traitement :
 - . médicaments : anticholinergiques si impériosités . kinésithérapie : rééducation sphinctérienne, bio-feed-back . chirurgie : colposuspension par bandelettes sous-urétrales
- Chez l'homme**
- post-chirurgie prostatique
- par regorgement : rétention vésicale chronique
- toucher rectal :

ITEM N°322 Mouvements anormaux

- tremblements :
 - . de repos : syndromes Parkinsoniens ; médicaments
 - . d'attitude : essentiel
 - . d'action : syndrome cérébelleux
- myoclonies : épilepsie
- chorees : Huntington, Wilson ; traitement = neuroleptique
- dystonies : lésions cérébrales, médicaments : neuroleptiques, L-Dopa
- dyskinésies : activité stéréotypée complexe ; médicaments ++ : neuroleptiques, L-Dopa ; traitement = anticholinergiques
- tics Wofes :

ITEM N°323 Œdèmes des membres inférieurs

- bilatéraux : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatocellulaire, dénutrition, hypothyroïdie, grossesse, médicaments : AINS, inhibiteurs calciques
- unilatéraux : thrombose veineuse profonde, cancer (obstruction lymphatique), érysipèle, allergie, algodystrophie
- examen clinique : poids +++
- rechercher une atteinte muqueuse (ORL)
- épanchement des séreuses associé
- traitement = restriction sodée, diurétiques
- :





ITEM N°324 Opacités et masses intra-thoraciques

- syndrome médiastinal : syndrome cave supérieur, paralysie récurrentielle gauche, dyspnée, dysphagie, Claude Bernard Horner
- opacité d'allure tumorale : rechercher une lyse costale, des adenopathies médiastinales, un épanchement pleural
- opacité en foyer : rechercher un aspect excavé, un épanchement pleural
- syndrome interstitiel : rechercher des adenopathies médiastinales (sarcoïdose)
- opacité alvéolaire : contours flous, confluent, bronchogramme aérien ++
- atélectasie : dense, homogène, systématisée, pas de bronchogramme, retractile ++
- opacité interstitielle : limites nettes, non confluent, non systématisée : linéaire / nodulaire / réticulo-nodulaire / rayon de miel (fibrose) -> TDM avec coupes millimétriques +++
- opacités médiastinales : goitre, thymome, adenopathies
- maladie de Hodgkin : adenopathies latéro-trachéales, élargissement du médiastin supérieur, compressives, asymétriques
- :

ITEM N°325 Palpitations

- interrogatoire : antécédents familiaux de mort subite +++, antécédents de syncope
- ECG, holter, exploration électro-physiologique
- tachycardie sinusale
- extrasystoles auriculaires : onde P de morphologie différente ; QRS fin, prématuré
- flutter auriculaire : ondes F à 300 /min
- fibrillation auriculaire : foyers de micro-réentrée ; tachycardie irrégulière à QRS fins
- tachycardie jonctionnelle : maladie de Bouveret : par réentrée intra-nodale ou faisceau accessoire
- extrasystoles ventriculaires : QRS large, prématuré ; critères de gravité : fréquentes, polymorphes, phénomène R sur T
- tachycardie ventriculaire : mauvaise tolérance hémodynamique +++ : dissociation auriculo-ventriculaire, QRS larges, soutenue si > 30 secondes, complexes de capture et de fusion
- striadyne : pas d'action sur les TV, ralentissement d'une tachycardie supra-ventriculaire, réduit une tachycardie jonctionnelle
- torsade de pointe : hypokaliémie ++
- traitements : bêtabloquants, Cordarone®
- . pour les troubles du rythme jonctionnels : ablation du faisceau accessoire par radiofréquence si échec du traitement médical . pour les TV : DAI : défibrillateur automatique interne :

ITEM N°326 Paralysie faciale

- centrale : prédomine sur le facial inférieur, dissociation automatico-volontaire, pas de signe de Charles Bell, autres troubles neurologiques souvent associés : fait la différence avec la paralysie faciale périphérique
- PFP à frigore idiopathique
- zona du ganglion géniculé
- bilan : test de Schirmer, examen ORL, examen OPHTALMOLOGIQUE ++
- traitement :
- . SOINS OCULAIRES +++ : occlusion palpébrale nocturne, cache oculaire, collyres antiseptiques . kinésithérapie ++ . a frigore : corticothérapie
- complications : oculaires (kératite), spasmes hémifaciaux, syncinésies faciales, syndrome des larmes de crocodile
- :

ITEM N°327 Phénomène de Raynaud

- acrosyndrome déclenché par le froid
- 3 phases : blanche, cyanique, rouge
- interrogatoire : tabac ++, médicaments, profession
- test d'Allen
- palpation des pouls ++

- examen neurologique
- rechercher des télangiectasies, une sclérodactylie, des troubles trophiques (sclérodermie)
- CAPILLAROSCOPIE systématique : recherche des mégacapillaires
- primitif : maladie de Raynaud
- secondaire : artériopathie, sclérodermie, LED, CREST syndrome ...
- arrêt du tabac
- prévention contre le froid ++
- inhibiteurs calciques
- contre-indication des bêtabloquants +++ :

ITEM N°328 Protéinurie et syndrome néphrotique chez l'enfant et chez l'adulte

- protéinurie des 24 h et électrophorèse des protéines urinaires
- protéinurie > 1 g/24h = néphropathie glomérulaire ++
- syndrome néphrotique : définition biologique : protéinurie > 3 g/24h + hypoalbuminémie < 30 g/L
- . pur : pas d'hématurie, pas d'HTA, pas d'insuffisance rénale organique, protéinurie sélective . clinique
- : oedèmes ++
- . complications : hyperlipidémie, troubles de la coagulation (attention à la thrombose des veines rénales), risque infectieux, risque de surdosage médicamenteux
- . si albuminémie < 20 g/L : anticoagulation systématique +++
- première cause de SN chez l'enfant = glomérulonéphrite à LGM (lésions glomérulaires minimes)
- première cause de SN chez l'adulte = GEM
- :

ITEM N°329 Prurit (avec le traitement)

- interrogatoire : rechercher un prurit dans l'entourage +++
- lésions de grattage / lésions spécifiques
- risque de surinfection +++
- gale +++
- dermatoses prurigineuses : eczéma, urticaire, varicelle
- causes générales : cholestase, lymphome, carence martiale, prurit sénile ...
- prévention de l'infection : règles d'hygiène, ongles courts
- anti-H1 = traitement symptomatique
- :

ITEM N°330 Purpuras chez l'enfant et chez l'adulte

- 2 urgences : purpura fulminans +++, syndrome hémorragique
- fièvre

Purpura thrombopénique idiopathique

- thrombopénie confirmée sur tube citrate
- myélogramme
- bilan d'hémostase
- fond d'oeil +++
- sérologie VIH

- traitement = corticothérapie ; pas de transfusion +++ **Purpura vasculaire**

- infiltré, nécrose, pas d'atteinte muqueuse, pas de syndrome hémorragique, décline
- cryoglobulinémie

- PAN : HBV ++

- purpura rhumatoïde :

. triade purpura vasculaire + douleur abdominale + arthralgies bilatérales et symétriques . bilan rénal + protéinurie des 24 h . complications rénales, digestives, orchite

:

ITEM N°331 Souffle cardiaque chez l'enfant

- fonctionnel / organique
- terrain : trisomie 21 (canal atrio-ventriculaire), syndrome de Turner (coarctation de l'aorte)



- clinique : cyanose, signes d'insuffisance cardiaque, caractéristiques du souffle, palpation des pouls périphériques +++
- échographie cardiaque systématique +++
- :

ITEM N°332 Splénomégalie

- clinique : rechercher un syndrome tumoral et des signes d'hypertension portale +++
- étiologies :
 - . infectieuses : septicémie, endocardite, fièvre typhoïde, VIH, paludisme . hématologiques : hémolyse, lymphome, syndrome myéloprolifératif, syndrome lymphoprolifératif . hypertension portale : cirrhose . inflammatoires : LED, polyarthrite rhumatoïde
- complications : hémodilution, hypersplénisme :

ITEM N°333 Strabisme de l'enfant

- tout strabisme après 4 mois est pathologique
- risque d'amblyopie fonctionnelle +++
- convergent / divergent
- accommodatif = secondaire à une hypermétropie
- dépistage systématique
- test des reflets cornéens
- test à l'écran unilatéral (mouvement de refixation)
- examen ophtalmologique complet avec fond d'œil : élimine une cause organique
- acuité visuelle : dépiste une amblyopie +++
- traitement = occlusion de l'œil sain : supprime la neutralisation
- correction de l'hypermétropie ++
- :

ITEM N°334 Syndrome mononucléosique

- hyperlymphocytose $> 4000 / \text{mm}^3$: grands lymphocytes hyperbasophiles bleutés = LT8 activés
- mononucléose infectieuse = primo-infection à EBV :
 - . asymptomatique ou angine, syndrome pseudo-grippal, polyadénopathie
 - . rash érythémateux après prise d'ampicilline
- primo-infection à CMV
- primo-infection à toxoplasmose
- primo-infection VIH

ITEM N°335 Thrombopénie

- risque hémorragique ++ quand plaquettes $< 50\,000 / \text{mm}^3$
- purpura hémorragique
- confirmer par un 2^e prélèvement sur tube citrate +++
- myélogramme +++
- bilan d'hémostase complet
- centrale : aplasie, dysmyélopoïèse, carence en folates, envahissement médullaire
- périphérique : destruction = auto-immune, immuno-allergique à l'héparine, virale ; hyperconsommation = **CIVD**, MAT ; trouble de la répartition = hypersplénisme
- facteurs de mauvais pronostic : plaquettes $< 20\,000 / \text{mm}^3$, purpura extensif, bulles hémorragiques, hémorragies rétinienues au fond d'œil
- traitement : transfusion de plaquettes si $< 20\,000 / \text{mm}^3$
- contre-indication des gestes invasifs, et des médicaments anticoagulants ++
- :





ITEM N°336 Toux chez l'enfant et chez l'adulte (avec le traitement)

- interrogatoire : notion de quintes, syndrome de pénétration
- radio de thorax
- toux aiguë : infection, coqueluche, asthme, corps étranger
- toux chronique : BPCO, cancer broncho-pulmonaire, pneumopathies interstitielles, BK
- première étiologie = ORL
- iatrogénie : IEC ++
- traitement :
 - . symptomatique : antitussif opiacé : codéine ou non opiacé : attention : contre-indiqué chez l'enfant, si toux productive ou chez l'insuffisant respiratoire chronique +++
 - . kinésithérapie respiratoire +++
 - :

ITEM N°337 Trouble aigu de la parole. Dysphonie

- interrogatoire : tabac, alcool, profession (cancer des VADS)
- clinique : laryngoscopie indirecte, examen ORL, recherche d'adénopathies cervicales
- bilan : laryngoscopie directe, pan-endoscopie des VADS si suspicion de cancer
- dysphonie aiguë : laryngite
- dysphonie chronique : laryngite chronique, cancer laryngé, tumeurs bénignes des cordes vocales, paralysie du récurrent
- fonctionnelle : surmenage vocal
- :

ITEM N°338 Trouble de l'érection

- étiologies :
 - . iatrogène : bêtabloquants, anti-hypertenseurs, psychotropes, post-prostatectomie
 - . organique : neurologique, vasculaire, endocrinienne
 - . psychogène
- facteurs de risque : diabète, athérome, tabac, alcool
- interrogatoire : persistance du désir, persistance d'érections matinales ou nocturnes, retentissement
- clinique : examen des OGE, toucher rectal, pouls fémoraux, examen neurologique
- Plethysmographie pénienne
- traitement :
 - . psychothérapie, sexothérapie
 - . inhibiteur de la phosphodiesterase 5 = Viagra (attention aux contre-indications)
 - . injections intra-caverneuses . chirurgie (prothèse pénienne)
 - :

ITEM N°339 Troubles de l'hémostase et de la coagulation

- augmentation du temps de saignement : trouble de l'hémostase primaire : plaquettes, facteur Willebrand, fibrinogène
- augmentation isolée du TP : déficit en facteur VII
- augmentation isolée du TCA : mélange avec un plasma témoin : si pas de correction : anticoagulant circulant ; si correction : hémophilie A ou B
- maladie de Willebrand : . autosomique dominant
- . trouble de l'hémostase primaire : hémorragies cutanéomuqueuses . augmentation du temps de saignement
- hémophilie :
 - . transmission récessive liée à l'X
 - . hémarthroses récidivantes -> arthropathie chronique
 - . élévation du TCA normalisée par l'adjonction de plasma témoin
- CIVD :
 - . syndrome hémorragique + thromboses
 - . thrombopénie, baisse du fibrinogène et des facteurs de coagulation, élévation du TCA, du TP, des complexes solubles ; des D Dimères et des PDF

- . diagnostic différentiel = fibrinolyse aiguë primitive (plaquettes normales)
- bilan de thrombophilie :
- . résistance à la protéine C activée, déficit en protéine C et S, SAPL, déficit en antithrombine III, mutation du facteur II
- :

ITEM N°340 Troubles de la marche et de l'équilibre

- rechercher une ataxie = trouble de la coordination
- examen neurologique complet
- épreuve de Romberg +++ :
- . négative : atteinte cérébelleuse
- . positive non latéralisée : atteinte proprioceptive : marche talonnante . positive latéralisée : atteinte vestibulaire homolatérale
- troubles de la marche sans ataxie :
- . syndrome astasie-abasie : hydrocéphalie à pression normale . syndrome frontal
- . steppage : paralysie du sciatique poplité externe ou de L5 . maladie de Parkinson : perte du ballant du bras, petits pas, festination, freezing, piétinement sur place, difficultés au démarrage . marche spastique : fauchage . myopathique : dandinante
- étiologies à évoquer chez le sujet âgé : hématome sous-dural, syndrome post-chute, latrogénie +++
- :

ITEM N°341 Troubles de la miction

- troubles de la retenue : pollakiurie, impériosités
- troubles de l'évacuation : dysurie, rétention vésicale
- bilan uro-dynamique : débitmétrie, cystomanométrie, profilométrie urétrale
- interrogatoire : retentissement sur la qualité de vie ++
- touchers pelviens
- échographie rénale et vésicale : mesure du résidu post-mictionnel
- ECBU
- complications de la dysurie : vessie de lutte, dilatation des cavités pyélocalicielles et insuffisance rénale chronique
- :

ITEM N°342 Tuméfaction pelvienne chez la femme

- éliminer un cancer de l'ovaire en priorité +++
- interrogatoire : date des dernières règles, dernier frottis cervico-vaginal
- touchers pelviens
- examen au spéculum
- échographie pelvienne et endovaginale
- fibrome utérin, tumeur de l'ovaire, GEU
- :

ITEM N°343 Ulcération ou érosion des muqueuses orales et / ou génitales

- interrogatoire : voyage, facteur de risque de MST
- examen des aires ganglionnaires
- prélèvement local, sérologies MST
- étiologies :
- . infectieuses : MST, HSV, syphilis, MST tropicales : chancre mou, maladie de Nicolas Favre, Donovanose, VIH . aphtes
- . traumatique ou caustique
- . ulcération chronique = carcinome (spinocellulaire ++) +++ faire des biopsies
- :



ITEM N°344 Vertiges

- examen vestibulaire : nystagmus, déviation segmentaire, épreuve de Romberg
- otoscopie
- acoumétrie au diapason
- examen neurologique
- syndrome vestibulaire périphérique :
 - . nystagmus : unidirectionnel, horizonto-rotatoire, inhibé par la fixation oculaire
 - . déviations posturales : syndrome harmonieux . vertige paroxystique positionnel bénin : manœuvre de Dixe et Hallpicke
 - . maladie de Meniere . labyrinthite
 - :

ITEM N°345 Vomissements du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte (avec le traitement)

Adulte

- aspect : alimentaire, bilieux, fécaloïde, sanglant
- examen abdominal et des orifices herniaires
- examen neurologique
- attention au risque de déshydratation et à l'hypokaliémie
- complications : inhalation bronchique
- etiologies : occlusion intestinale, syndrome méningé, hypertension intracrânienne, IDM inférieur, troubles métaboliques
- anti-émétiques : antidopaminergiques, sétrons

Nourrisson

- première cause : RGO
- vomissement en période néonatale : si vomissements bilieux : urgence chirurgicale ++ : sténose duodénale, maladie de Hirschsprung, atrésie intestinale
- après sevrage du lait maternel : allergie aux protéines de lait de vache
- après un intervalle libre d'un mois : sténose du pylore
- syndrome occlusif : invagination intestinale aiguë
- hématome sous-dural
- acidocétose diabétique : BU, cétonurie

